

외국인환자유치 등록에 따른 업무 참고 매뉴얼

목 차

제1부 외국인환자 유치사업 등록

1. 외국인환자 유치사업의 등록 배경 및 목적 -----	3
2. 외국인환자 유치사업 등록 개요 -----	5
3. 외국인환자 유치사업 등록 요건 -----	7
4. 외국인환자 유치사업 등록 절차 -----	16
5. 외국인환자 유치사업 등록 의무 및 준수사항 -----	18
6. 외국인환자 유치사업 등록 변경 -----	21
7. 휴업 및 폐업, 휴업 후 영업 재개 -----	21
8. 외국인환자 유치업자의 자본금 적용기준 -----	22

제2부 외국인환자 유치사업 실적보고

1. 외국인환자 유치 사업 실적보고 목적과 내용 -----	24
2. 집계 대상이 되는 외국인환자 범위 -----	25
3. 외국인환자 실적보고를 위한 가이드라인 -----	27
4. 실적보고 항목별 입력방법 안내(의료기관용) -----	29
5. 실적보고 항목별 입력방법 안내(유치업자용) -----	33
6. Q&A -----	37

제3부 외국인환자 사증발급·체류절차

1. 외국인의 입국절차 -----	39
2. 외국인의 체류관리 -----	41
3. 외국인환자 사증발급 및 체류절차 -----	46
4. 향후 추진계획 -----	48

제4부 의료분쟁 예방 및 해결 방안

1. 리스크 관리 체크리스트 -----	49
2. 외국인환자 의료분쟁 가상사례분석 -----	53

부 록

*[부록1] 외국인환자 유치 관련 법규 -----	83
*[부록2] 외국인환자를 유치하기 위한 의료기관 가이드라인 -----	90
*[부록3] 외국인환자를 유치하기 위한 유치업자 가이드라인 -----	92
*[부록4] 한국의료로 이용하기 위한 환자 안내서 -----	94
*[부록5] Patient Guidelines -----	97
*[부록6] 외국인환자 유치사업계획서 -----	100
*[부록7] 의료기관 기본정보 -----	101
*[부록8] 유치업자 기본정보 -----	103
*[부록9] 외국인환자 유치사업 실적조사표(의료기관) -----	105
*[부록10] 외국인환자 유치사업 실적조사표(유치업자) -----	106
*[부록11] 의료기관/유치업자 휴업/폐업 신고서-----	107
*[부록12] 외국인환자 유치 의료기관/유치업자 변경신청서 -----	108
*[부록13] 조치계획서 -----	109
*[부록14] 외국인환자 유치 등록 영문 증명 신청서 -----	110
*[부록15] 증권기간단축 확인서 -----	111
*[부록16] HEALTH PROVIDER CERTIFICATE -----	112
*[부록17] HEALTH FACILITATOR CERTIFICATE -----	113
*[부록18] 외국인환자 유치 의료기관 등록신청서 -----	114
*[부록19] 외국인환자 유치업자 등록신청서 -----	116
*[부록20] 외국인환자 유치 의료기관 등록증 -----	118
*[부록21] 외국인환자 유치업자 등록증 -----	119
*[부록22] 외국인환자 유치 의료기관/유치업자 등록증 재발급신청서 -----	120
*[부록23] C-3-M, G-1-M 비자 서류 -----	122
*[부록24] 외국인 환자 초청 확인서 -----	123

1부 외국인 환자 유치사업 등록

1. 외국인환자 유치사업의 등록 배경 및 목적

가. 추진배경

- 의료법 개정에 따라 외국인환자를 유치하려는 의료기관 및 유치업자는 의료법 (제27조의2) 및 보건복지부령에서 정한 요건을 갖추어 의무적으로 등록하여야 함

나. 사업목적

- 외국인 환자를 유치하려는 의료기관 및 유치업자에게 일정한 요건을 갖춰 등록하게 함으로써 무분별한 외국인 환자 유치행위로 인한 국내 의료 시장질서 혼탁화를 방지하고 지속적으로 관리할 수 있는 제도적 장치로 활용하기 위함
- 외국인환자 유치 과다경쟁으로 인한 공공 의료서비스의 질적 저하를 막고 미자격 의료기관 및 유치업자의 난립으로 인해 발생할 수 있는 한국의료서비스의 대외 이미지 실추를 방지하기 위함

다. 추진경과

의료법 개정전

- 의료법 제27조(무면허 의료행위 등 금지) ③누구든지 「국민건강보험법」이나 「의료급여법」에 따른 본인부담금을 면제하거나 할인하는 행위, 금품 등을 제공하거나 불특정 다수인에게 교통편의를 제공하는 행위 등 영리를 목적으로 환자를 의료기관이나 의료인에게 소개·알선·유인하는 행위 및 이를 사주하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 환자의 경제 사정 등 특정한 사정이 있어서 관할 시장 군수 구청장의 사전승인을 받을 경우에는 그러지 아니한다.

【벌칙】

- ◇ 제27조제3항을 위반한 자: 3년 이하의 징역이나 1천만원이하의 벌금

【행정처분】

- ◇ 법 제27조제3항을 위반하여 영리를 목적으로 환자를 의료기관이나 의료인에게 소개 알선 그 밖에 유인하거나 이를 사주하는 행위를 한 경우 :자격정지 2개월

의료법 개정전 (판례)

(의료법 위반에 관한 판례, 대법원 2004. 10. 27. 선고 2004도 5724 판결)

- : 구 의료법(2002. 3. 30 법률 제6686호로 개정되기 전의 것) 제25조 제3항의 '소개·알선'이라고 함은 환자와 특정 의료기관 또는 의료인 사이에서 치료위임계약의 성립을 중개하거나 편의를 도모하는 행위를 말하고, '유인'이라 함은 기망 또는 유혹을 수단으로 환자로 하여금 특정 의료기관 또는 의료인과 치료위임계약을 체결하도록 유도하는 행위를 말하며, '이를 사주하는 행위'라고 함은 타인으로 하여금 영리를 목적으로 환자를 특정 의료기관 또는 의료인에게 소개·알선·유인할 것을 결의하도록 유혹하는 행위를 말하고, 위 조항은 의료인 또는 의료기관 개설자가 아닌 자의 환자 유인행위 등을 금지함은 물론 의료인 또는 의료기관 개설자의 환자 유인행위나 그 사주행위까지도 금지하는 취지이다.

의료법 개정

- 2009년 1월 30일 의료법 개정 (외국인에 한정 유치 행위 허용)
- : 의료법 제27조(무면허 의료행위 등 금지) ③누구든지 「국민건강보험법」이나 「의료급여법」에 따른 본인부담금을 면제하거나 할인하는 행위, 금품 등을 제공하거나 불특정 다수인에게 교통편의를 제공하는 행위 등 영리를 목적으로 환자를 의료기관이나 의료인에게 소개·알선·유인하는 행위 및 이를 사주하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 할 수 있다.
1. 환자의 경제적 사정 등을 이유로 개별적으로 관할 시장·군수·구청장의 사전승인을 받아 환자를 유치하는 행위
 2. 「국민건강보험법」 제93조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 외국인(보건복지부령으로 정하는 바에 따라 국내에 거주하는 외국인은 제외한다)환자를 유치하기 위한 행위

2. 외국인환자 유치사업 등록 개요

가. 외국인환자 유치사업 대상 및 제한

- 외국인환자 유치활동의 허용 대상은 「국민건강보험법」 제93조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 외국인에 한정하며 보건복지부령이 정하는 바에 따라 유치활동이 불가능한 국내에 거주하는 외국인은 아래와 같음
 - 「출입국관리법」 제31조에 따라 외국인등록을 한 사람
(출입국관리법시행령 제12조 및 별표1에 따른 기타(G-1)의 체류자격을 가진 사람은 제외함)
 - 「재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포
- 「보험업법」 제2조에 따른 보험회사, 상호회사, 보험설계사, 보험대리점 또는 보험중개사는 외국인환자를 유치하기 위한 행위가 금지됨
- 상급종합병원(종합전문요양기관)의 경우 의료법 제27조의2제5항에 따라 병상수의 100분의 5를 초과하여 외국인환자를 유치 할 수 없음

나. 외국인환자 유치사업 등록 대상 및 접수

- 「국민건강보험법」 제93조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 외국인환자에 대한 유치활동을 허용하는 내용으로 「의료법」이 개정(법률 제9386호, 2009.1.30 공포, 5.1 시행)됨에 따라 외국인환자 유치사업 등록을 위한 사전접수를 '09. 4. 28일부터 받도록 함(등기우편 또는 방문접수)
- 외국인환자 유치사업 등록 대상은 외국인환자를 유치하고자 하는 국내 의료기관 및 유치업자로 정하며 의료법 제27조의2에 따라 외국인 환자를 유치하고자 하는 의료기관 및 유치업자는 일정 요건을 갖추어 등록하여야 함
- 외국인환자 유치사업 등록업무 및 사업실적 보고는 한국보건산업진흥원이 위탁받아 수행함

의료법시행령 제42조(업무의 위탁)

- ② 법 제86조제2항에 따라 보건복지부장관은 다음 각 호의 업무를 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원에 위탁한다.
1. 법 제27조의2제1항 및 제2항에 따른 등록 업무(등록 요건 검토는 포함하되, 등록 여부 결정 및 등록증 발행·재발행은 제외한다)
 2. 법 제27조의2제3항에 따른 사업실적 보고 업무
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 업무를 위탁받은 각 중앙회장 및 한국보건산업진흥원은 위탁받은 업무의 처리 내용을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관에게 보고하여야 한다.

- 외국인환자 유치사업 등록접수는 한국보건산업진흥원에서 '09. 4. 28일부터 수시로 받고 있으며 등록신청서 제출 후 20일 이내에 등록증을 교부받을 수 있음
 - 처리기간은 '일' 단위로 계산하고 초일을 산입하되, 공휴일을 산입하지 않음(민원사무처리에관한법률 제6조제2항)
- 한국보건산업진흥원은 신청서 및 구비서류를 접수검토하여 보건복지부에 그 내용을 알림. 복지부는 등록요건에 적합한 경우 등록증을 발행하여 진흥원에 송부하고, 진흥원은 발행된 등록증을 신청자에게 통보 및 교부함
- 등록 신청시 대표자 본인이 직접 방문할 경우는 신분증을 지참하고 대리인이 신청할 경우는 대표자의 신분증 사본 및 위임장을 제출함 (우편접수시 대표자 신분증 사본 제출)

○ 한국보건산업진흥원 위탁 업무 내용

- 외국인 환자 유치 의료기관 및 유치업자 등록업무 위탁 수행
·신청서 접수, 검토 및 등록증 교부, 통보 등
- 외국인 환자 유치 사업 실적보고 관리 업무 수행
·외국인 환자 국적, 성별 및 출생년도, 진료과목, 입원기간 등 실적 보고

3. 외국인환자 유치사업 등록 요건

가. 외국인환자 유치 의료기관 등록 요건

- 외국인환자 유치 의료기관의 등록 요건 사항은 다음과 같음
 - 유치하고자 하는 외국인환자 진료과목의 전문의 1인 이상. 다만, 진료과목이 『전문 의의 수련 및 자격인정 등에 관한 규정』 제3조에 따른 전문과목이 아닌 경우는 제외함
 - ※ 재직증명서 등을 통해 진료과목 전문의가 현재 병원에 근무하고 있음을 증명하도록 함

나. 외국인 환자 유치 의료기관 등록 신청시 제출서류

- 외국인 환자 유치 관련 등록 신청을 희망하는 의료기관은 등록신청서와 함께 아래의 서류를 구비하여 제출하여야 함
 - 의료기관 개설신고 증명서 또는 개설허가증 사본 1부
 - 사업계획서 1부 (기관소개, 사업목적 및 주요사업내용, 업무 조직 등 포함-“별표2” 참조)
 - 진료하고자 하는 외국인환자 진료과목 전문의의 명단 및 자격증 사본 (치과, 한의과 등은 의사 명단 및 자격증 사본 제출)
 - 사업자등록증 사본 1부

다. 외국인환자 유치업자 등록 요건

- 외국인환자 유치업자의 등록 요건 사항은 다음과 같음
 - 아래의 요건을 만족하는 보증보험에 반드시 가입할 것
 - 「보험업법」 제4조 제1항 제2호 라목의 보증보험에 대하여 금융위원회의 허가를 받은 보험회사만 해당하고 보험금액 1억원 이상, 보험기간은 1년 이상으로 함

- ◆ 보증보험이 만료될 경우에는 만료일 7일전까지 아래의 자료를 제출할 것
 - 보증보험 증서를 갱신하여 제출
 - 자본금의 현재 유지 상태 증빙서류
 - 국내 사무실 유지 상태 증빙서류

· 보증보험금으로 외국인환자 유치과정에서 발생한 손해를 배상한 경우, 1개월 이내에 보증보험에 다시 가입할 것

보증범위는 외국인환자 유치업자가 외국인환자를 유치하여 의료기관에 소개 알선하는 과정에서 고의 또는 과실로 인하여 외국인환자가 입게 되는 손해에 대한 배상책임을 보장하는 것을 내용으로 함

- 유치업자의 자본금의 규모는 1억원으로 함
·유치업자가 기존 사업을 운영하고 있을 경우, 기존 사업의 법정 최저 자본금을 제외한 자본금이 1억원 이상으로 함
- 국내에 사무실을 둘 것

라. 외국인환자 유치업자 신청 시 제출서류

- 외국인 환자 유치 관련 등록 신청을 희망하는 유치업자는 등록신청서와 함께 아래의 서류를 구비하여 제출하여야 함
 - 정관 1부
 - 자본금 규모를 증명할 수 있는 서류 (세무사 또는 공인회계사가 확인한 대차대조표, 법인등기부등본 등)
 - 사업계획서 1부 (회사개요, 사업목적 및 주요사업내용, 업무조직 및 인원 등 포함-“별표2” 참조)
 - 보증보험에 가입된 사실을 증명할 수 있는 서류 1부 (보증보험증권 원본)
 - 사무실 소유권 또는 사용권이 있음을 증명하는 서류
 - 사업자등록증 사본 1부

마. 보증보험 가입 및 절차

- 보장금액 및 기간
 - 의료법 제27조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제19조의4제1항제3호에 의거 보증보험의 가입금액은 1억 원 이상, 보험기간은 1년 이상으로 함
- 보장방법 및 절차
 - 보장방법 : 외국인환자 유치업자는 등록신청 전 법령에서 정한 금액을 보장하는 보증보험에 가입하여야 함
 - 손해배상 책임보장 금액에 상당하는 인허가 보증보험에 가입
 - ※ 보험료율 : 보장금액의 0.737%

○ 보증보험 가입 (보증보험 가입내용)

- 보험계약자

·외국인환자 유치업자가 보험료를 납입할 의무를 지닌 보험계약자가 되며, 또한 이용자에 대한 손해배상 책임자가 됨

- 피보험자

·보험금 청구권자이며, 현재 등록 및 사업실적보고 업무의 위탁을 받고 있는 한국보건산업진흥원으로 설정함(향후 보건복지부장관의 지정을 통하여 변경 가능)

○ 보험업법에서 명시된 보증보험 업무를 취급하는 회사는 현재 “서울보증보험(주)” 1곳이며, 보험계약의 체결은 ‘사이버 지점’ 에서도 가능함

□ 보험계약의 체결

【 보증보험 개요 】

1. 보증보험이란?

• 보증보험은 각종 거래에서 발생하는 신용위험을 감소 시키기 위하여 보험의 형식으로 취급하는 보증제도로, 보증보험 회사가 일정한 대가 (보험료)를 받고 계약상의 채무이행 또는 법령상의 의무이행을 보증하는 특수한 형태의 보험

2. 보증보험 유형

• 보증보험 유형은 “인허가보증보험”이며, 채무자의 법령상 또는 계약상 채무 또는 의무의 불이행으로 인해 채권자가 입은 손해를 담보하는 보험상품

3. 보증보험의 목적

• 채무자의 채무불이행으로 인한 손해를 보상

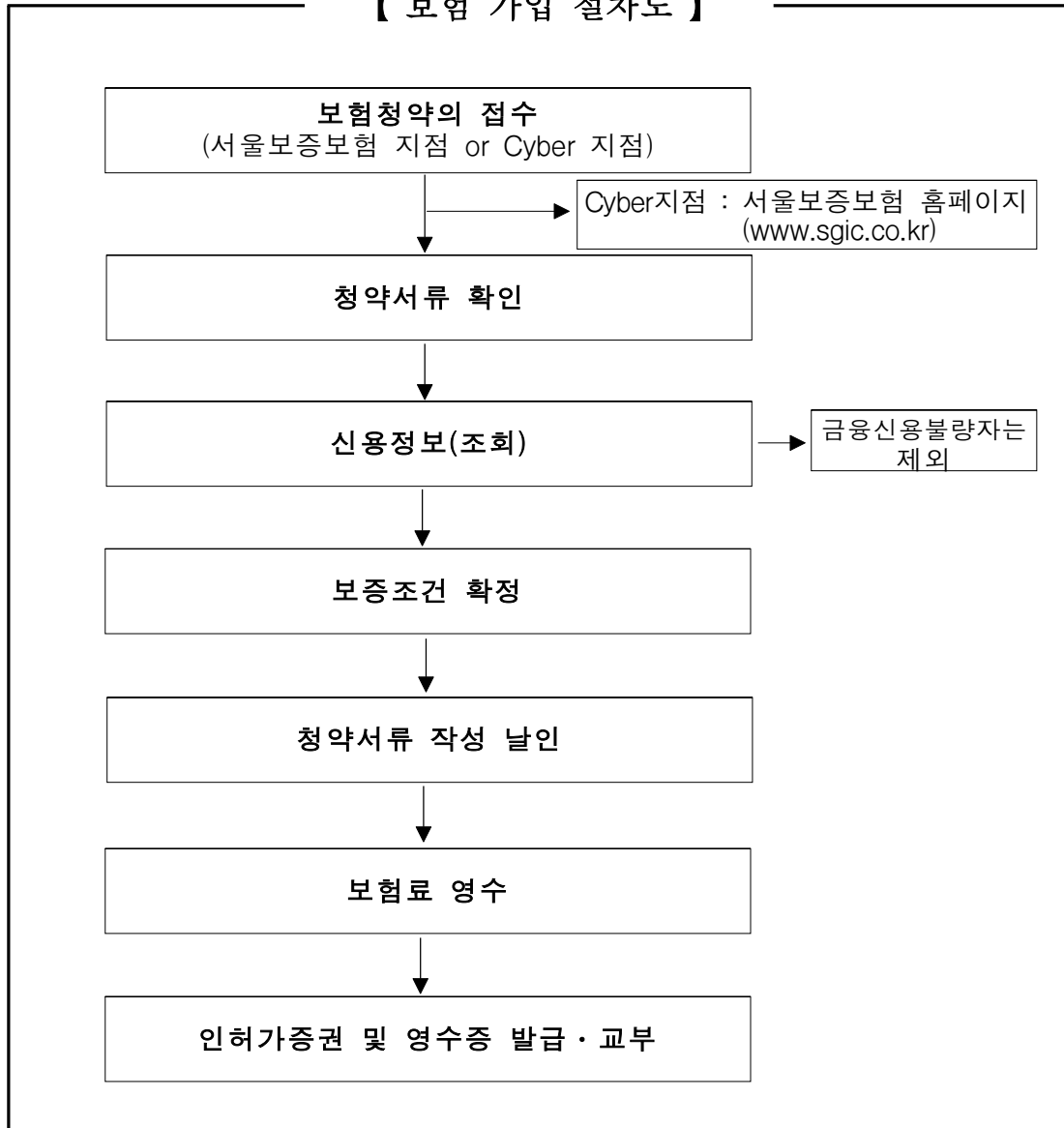
4. 보험사고의 성격

• 채무자의 고의 또는 과실로 인한 손해 담보

5. 중도해지 여부

• 보증보험은 보험기간 중 중도해지가 불가능하다는 것이 기본 원칙 이나 보험사고가 없었음이 명확한 때에는 해지 가능

【 보험 가입 절차도 】



○ 보험계약의 청약

- 외국인환자 유치업자가 보증보험회사에 보증보험계약을 청약하며, 청약시 법인 등기부 등본이나 사업자등록증을 지참

○ 청약에 대한 인수 심사

- 외국인환자 유치업자로부터 이행보증에 관한 청약을 받은 보증보험회사는 청약서류를 확인하는 것 이외에 신용정보 등을 조회하여 적절한 자격을 갖추었다고 판단될 경우, 인수조건(연대보증인 추가 여부 등) 확정

○ 보험자의 승낙

- 청약서를 최종 작성하고(보험계약자의 서명날인) 보험료 납입

○ 보험증권의 발행

- 보험계약 청약서가 접수되고 보험료가 영수되면 보증보험회사는 보험계약자에게 보험증권 교부

□ 보증보험금 지급 사유 및 청구절차

○ 지급 사유

- 이용자(외국인환자)가 유치업자와 체결한 계약과 관련하여 손해를 입었으나 유치업자가 그 손해의 배상에 응하지 아니하여 보증보험금으로 손해를 배상받고자 하는 경우 그 이용자는 보증보험금 지급 청구

○ 이용자의 보증보험금 청구 서류

당사자간 다툼이 없는 경우

- 이용자와 외국인환자 유치업자간의 손해배상합의서(공정증서)
- 손해액을 증명하는 서류

당사자간 다툼이 있는 경우

- 화해조서 또는 확정된 법원의 판결문 정보
- 그 밖에 이에 준하는 효력이 있는 서류
- ※ 소비자분쟁조정위원회의 조정 성립시 재판상 화해와 같은 효력이 있으므로, 소송제기 전 한국소비자원의 피해구제 및 소비자분쟁조정위원회의 조정을 통해 신속하게 손해배상청구를 할 수 있도록 권유
- 손해액을 증명하는 서류

○ 청구기관 및 서류

- 이용자는 손해배상합의서(공정증서이어야 함), 화해조서 또는 확정된 법원의 판결문 정보 그 밖에 이에 준하는 효력이 있는 서류를 당해 외국인환자 유치업자 보증보험의 피보험자(현, 한국보건산업진흥원)에 제출하여 보증보험금 청구에 관한 협조 요청

○ 손해배상 청구에 관한 단계별 처리방안

당사자간 다툼이 없는 경우

- 손해액에 관하여 외국인환자 유치업자와 이용자 사이에 다툼이 없는 경우 당사자간 손해배상합의서로서 보험금을 이용자에게 지급

당사자간 다툼이 있는 경우

- 보험회사의 판단에 따른 보험금 지급

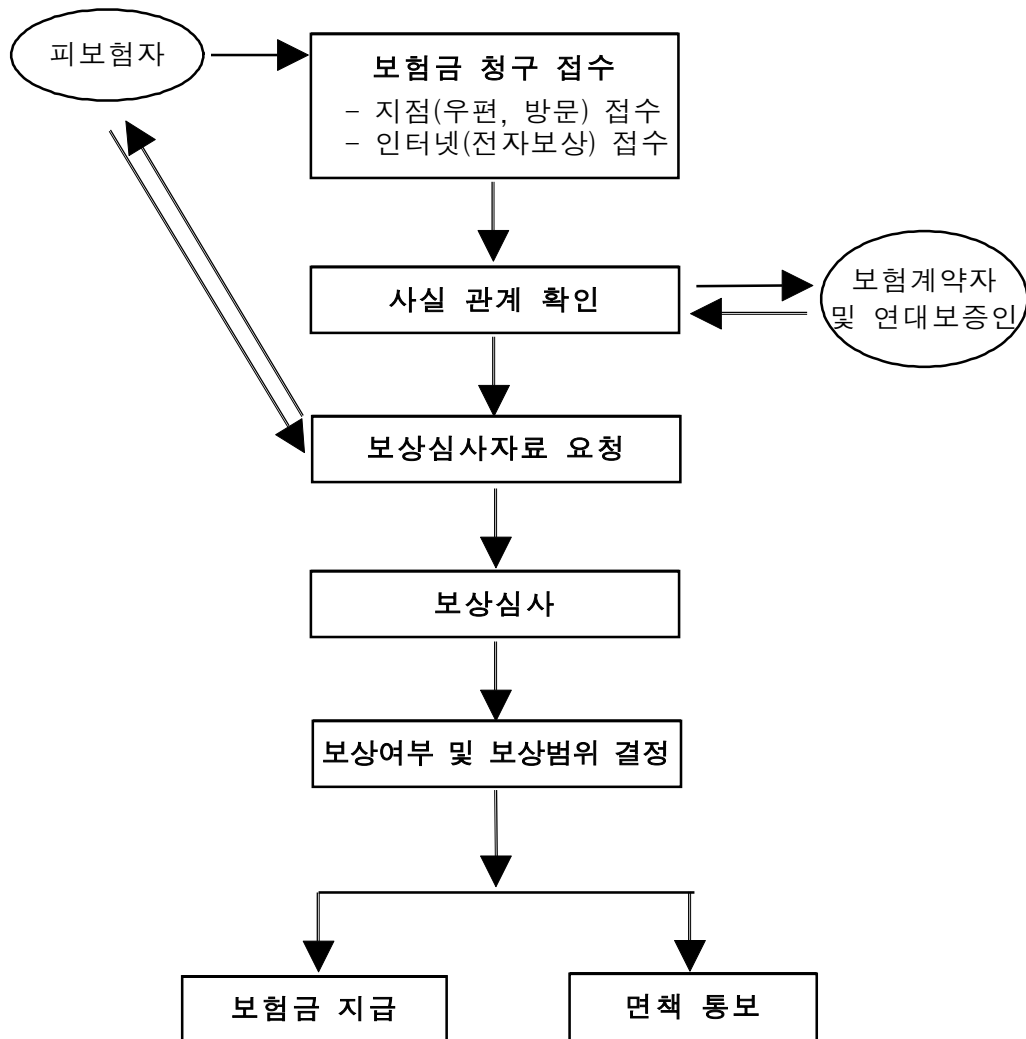
- 당사자간에 이용자의 손해에 관하여 다툼이 있는 경우라고 하더라도, 외국인환자 유치업자의 명백한 고의 또는 과실이 입증되고 손해액 또한 객관적으로 확정되는 경우, 통상 보험회사는 보험금을 지급하므로 보험금 청구

- 소비자분쟁조정결정에 따른 보험금 지급

- 보험회사의 결정에 외국인환자 유치업자가 불복하는 경우, 이용자의 요청으로 한국소비자원에 피해구제 및 소비자분쟁조정위원회에 조정 요청하도록 하여 그 결정에 따라 보험금 지급
- 화해조서 및 법원의 확정 판결

※ 외국인환자 유치업자가 보험회사의 결정이나 소비자분쟁조정위원회의 결정에 불복하여 법원의 판결을 받아야 한다고 판단한 경우 화해조서 및 확정판결문을 첨부하여 보험금 청구

<그림> 보험회사의 보험금 지급 절차



보험금 청구권 경합과 지급액

- 손해를 입은 이용자가 다수이고, 그 손해액의 합계액이 보증보험 가입금액을 초과한 경우, 채권자 평등의 원칙에 의거 균등한 권리가 있으므로 지급한도가 초과된 상태에서 손해배상을 청구하는 이용자에 대해서도 보험금 청구

<참고>

보증보험회사의 보험금 지급 절차

● 피보험자의 보험금 청구

- 피보험자는 보험금 청구서, 당사자간 계약서, 보험증권, 손해의 입증자료 등을 첨부하여 보증보험회사에 보험금 청구

● 보험금 지급을 위한 심사

- 보험금 청구를 받은 보험회사는 손해사정에 필요한 서류를 확인하는데, 통상 보험증권, 인허가 신청서 및 허가서, 허가취소 통보 문서, 민원인의 민원서류, 손해액 입증서류 등 확인
- 또한 관계법령에 따라 증권상에 기재된 위험내용인지 여부를 확인하는데, 관청의 민원처리 내용, 증권 및 약관 내용, 등록취소 서류로 확인
- 보험기간 내에 발생한 손해인지 여부를 확인하고, 손해액 산정은 적정한지 여부에 대해서 당사자간 합의서, 해당 관청의 손해배상 명령서, 조정기관의 조정결정문, 법원의 확정판결문 등 확인

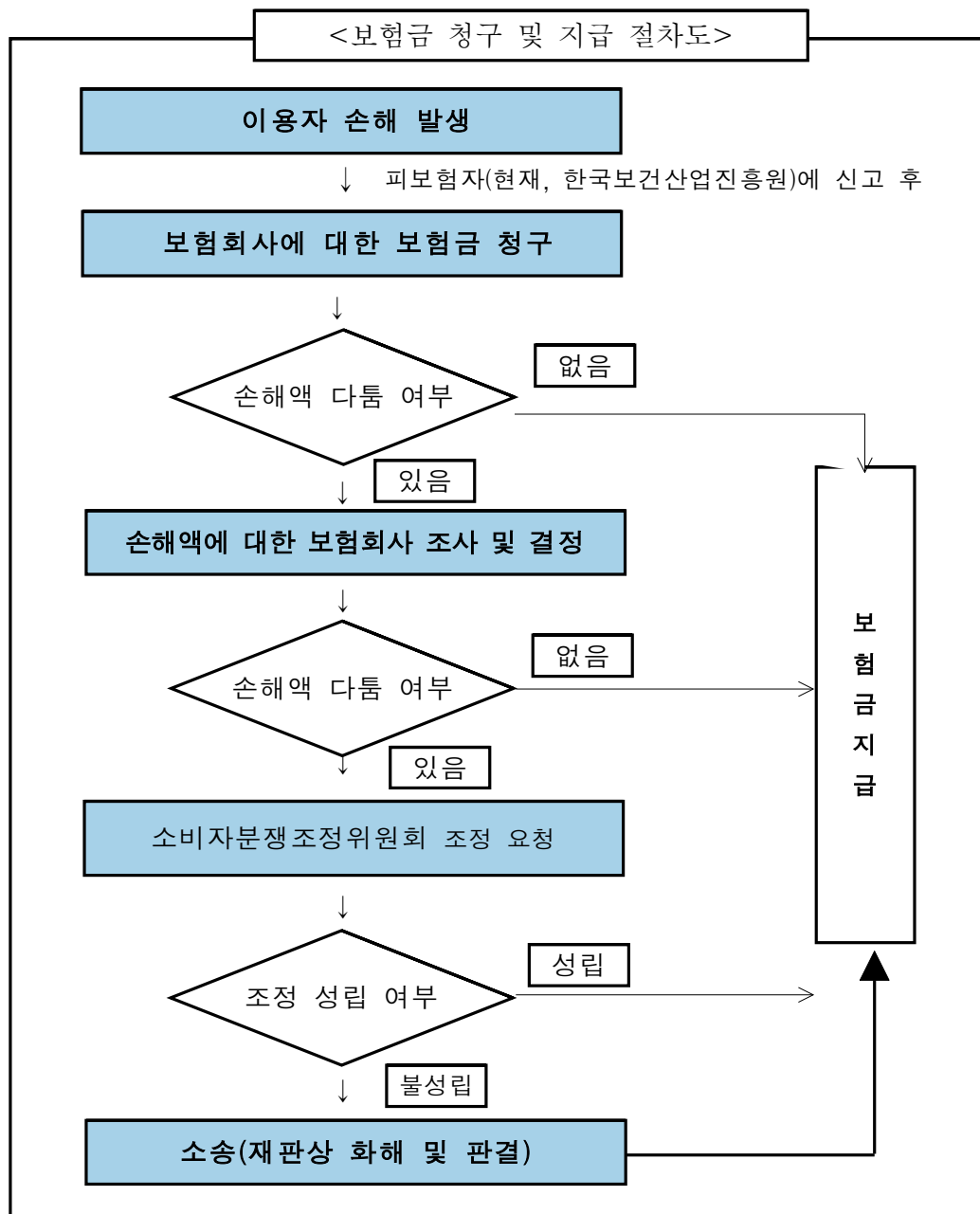
○ 보험금 청구권 소멸시효

- 보험금 청구권은 「상법」 제662조 및 약관에 의거 2년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성
- 시효의 기산점
 - 상법은 보험금 청구권 소멸시효의 기산점에 대해서 규정하고 있지 않아 민법에 따르고 있으며, 권리를 행사할 수 있을 때부터 시효가 진행(「민법」 제166조)

○ 보험금 청구권 소멸시효에 관한 판례(대법원 2005.12.23. 선고 2005다59383, 59390 판결)

보험금청구권은 보험사고가 발생하기 전에는 추상적인 권리에 지나지 않고 보험사고의 발생으로 인하여 구체적인 권리로 확정되어 그때부터 그 권리를 행사할 수 있게 되는 것이므로, 특별한 다른 사정이 없는 한 원칙적으로 보험금액청구권의 소멸시효는 보험사고가 발생한 때로부터 진행한다고 해석해야 할 것이고, 다만 보험사고가 발생한 것인지의 여부가 객관적으로 분명하지 아니하여 보험금청구권자가 과실 없이 보험사고의 발생을 알 수 없었던 경우에도 보험사고가 발생한 때로부터 보험금청구권의 소멸시효가 진행한다고 해석하는 것은 보험금청구권자에게 너무 가혹하여 사회정의와 형평의 이념에 반할 뿐만 아니라 소멸시효제도의 존재 이유에 부합된다고 볼 수도 없으므로 이와 같이 객관적으로 보아 보험사고가 발생한 사실을 확인할 수 없는 사정이 있는 경우에는 보험금청구권자가 보험사고의 발생을 알았거나 알 수 있었던 때로부터 보험금액청구권의 소멸시효가 진행

○ 보험금 청구절차



4. 외국인환자 유치사업 등록 절차

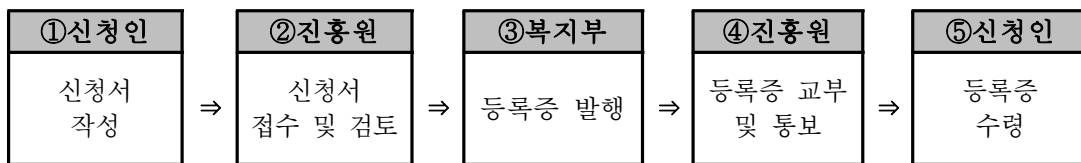
가. 외국인환자 유치사업 등록 업무 위탁

○ 외국인환자 유치사업 등록 및 사업실적 보고 업무는 한국보건산업진흥원이 위탁받은
·의료법시행령 제42조(업무의 위탁) ② 법 제86조제2항에 따라 보건복지부장관은 다음 각
호의 업무를 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원에 위탁한다.

- 1) 법 제27조의2제1항 및 제2항에 따른 등록 업무(등록 요건 검토는 포함하되, 등록 여부 결정 및 등록증 발행·재발행은 제외한다)
- 2) 법 제27조의2제3항에 따른 사업실적 보고 업무

나. 외국인환자 유치사업 등록 절차

○ 외국인환자유치 희망 의료기관 및 유치업자는 다음 순서에 따라 한국보건산업진흥원
(이하 진흥원)에 등록을 신청할 수 있음



신청인은 등록요건을 확인하고 등록신청서와 구비서류를 준비하여 진흥원에 신청함

- 1) 진흥원은 신청인의 서류를 접수하고 검토 후 그 내용을 복지부에 알림
 - 2) 복지부는 등록요건에 적합한 경우 등록증 발행하여 진흥원에 송부함
 - 3) 진흥원은 발행된 등록증을 신청인에게 통보 및 교부함(접수일로부터 20일 이내)
 - 4) 신청인이 등록증을 수령함
- 처리기간은 ‘일’ 단위로 계산하고 초일을 산입하되, 공휴일을 산입하지 않음(민원사무처리에관한법률 제6조제2항)

○ 등록접수 전 확인사항

공 통 사 항

- 외국인환자 유치사업 등록신청서의 충실 기재 여부 확인
- 사업계획서 1부 제출
 - 기본사항을 비롯하여 사업목적 및 주요사업내용 등이 기술되었는지 확인
- 사업자등록증 사본 1부

의 료 기 관

- 의료기관 개설허가증 및 개설신고증명서 사본 1부
- 유치하고자 하는 외국인환자 진료과목의 전문의의 명단 및 자격증 사본 1부

유 치 업 자

- 정관 1부 (법인인 경우)
- 보증보험 가입 확인을 증명할 수 있는 서류 (보증보험증권 원본)
 - 1억원 이상을 보장하는 보증보험에 가입여부 확인
 - 보증보험의 유효기간 확인 (1년 이상)
- 1억 이상의 자본금을 소유하고 있는지 확인 (세무사 또는 공인회계사가 확인한 대차대조표, 법인등기부등본 등)
 - 유치업자가 기존 사업을 운영하고 있을 경우, 기존 사업의 법정 최저 자본금을 제외한 자본금이 1억원 이상으로 함
- 부동산 소유권 또는 사용권을 증명하는 서류 1부 (임대계약서 등)

○ 등록요건에 적합한 경우

- 외국인환자 유치 등록증(의료법시행규칙 별지 제9호의4, 5 서식) 발행 및 교부
- 등록관리대장(별표 7,8)에 기록

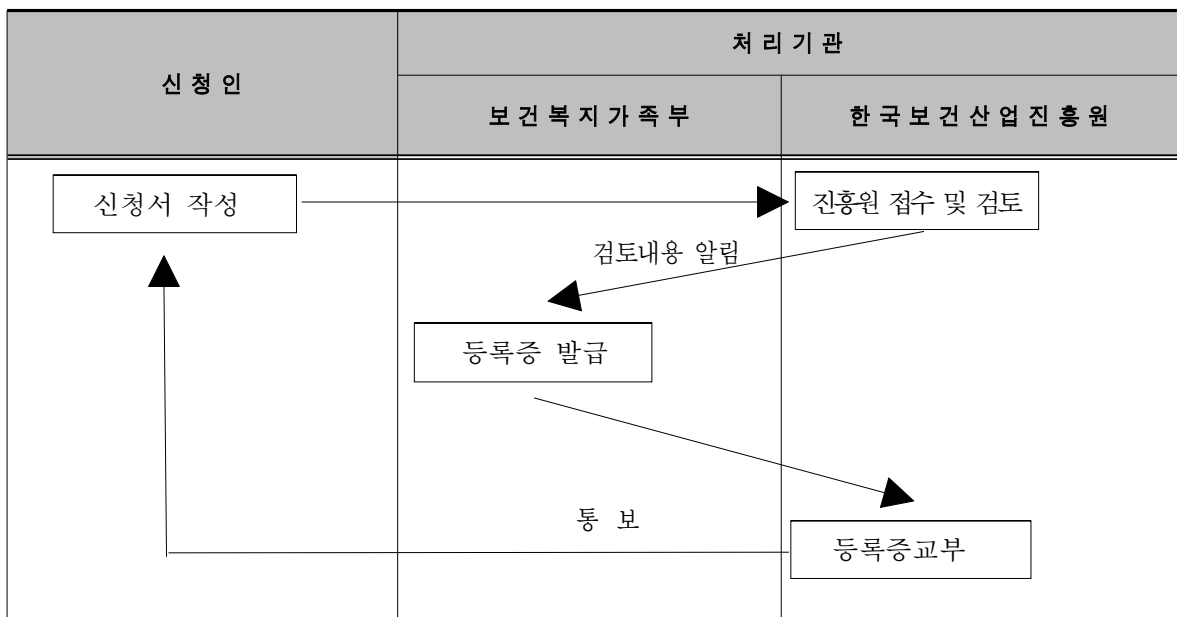
○ 등록요건에 부적합한 경우

- 신청인에게 부적합함을 통보하고, 신청서류 일체를 반려

5. 외국인환자 유치사업 등록 의무 및 준수사항

- 외국인환자유치 희망 의료기관 및 유치업자는 반드시 등록요건을 갖추어 등록업무 위탁기관인 한국보건산업진흥원(이하 진흥원)에 접수해야 하며 등록 기준에 적합할 경우 등록증을 발부 받아 외국인환자 유치사업을 시작할 수 있음
- ※ 외국인환자 유치 등록 기관은 해외 홍보 및 마케팅 활동 등에 필요한 경우, 유치 등록 영문 증명서를 신청하여 발급받을 수 있다.
 - 1) 유치등록기관 : 신청서(별표10서식)를 작성하여 한국보건산업진흥원에 제출
 - 2) 한국보건산업진흥원 : 신청서 접수 및 발급 의뢰
 - 3) 보건복지부 : 영문증명서(별표12 또는 별표13) 발급
 - 4) 한국보건산업진흥원 : 영문증명서 교부
- 외국인환자 유치업자 및 의료기관의 등록은 아래와 같은 경우 취소될 수 있음
 - 등록요건을 충족시키지 못할 경우
 - 외국인환자 유치 허용 대상 이외의 자를 유치하는 행위를 한 경우
 - 의료법 제63조에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 경우
 - 상급종합병원(종합전문요양기관)이 병상의 100분의 5를 초과하여 외국인환자를 유치한 경우

<그림 1> 외국인환자 유치업자 및 의료기관 등록 프로세스

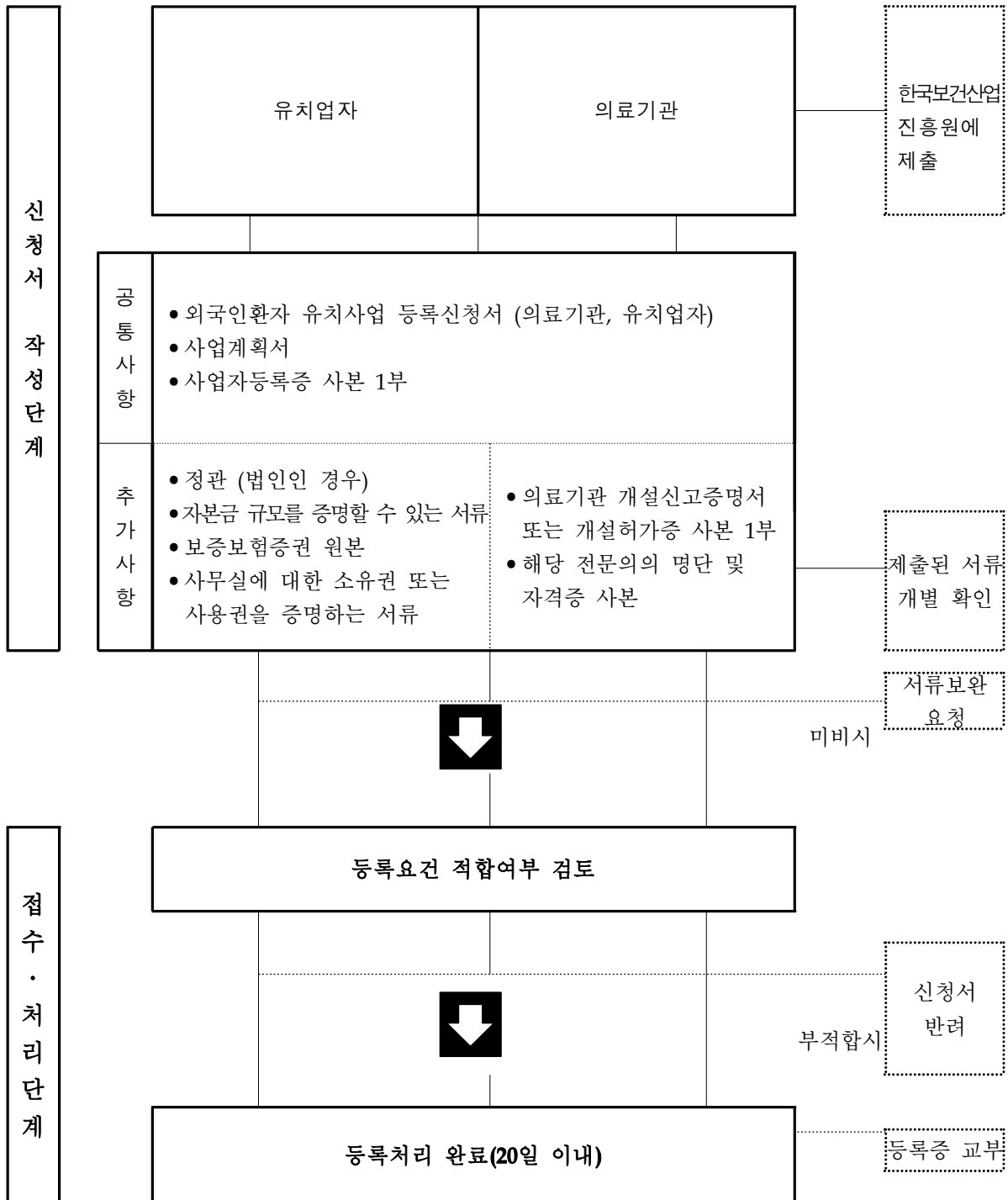


<표 1> 등록관련 Check list

의료기관	유치업자
<u>등록요건</u>	
☐ 유치하고자하는 진료과목의 전문의 1인 이상 (진료과목이 『전문의의 수련 및 자격인정 등에 관한 규정』 제3조에 따른 전문과목이 아닌 경우는 제외함) ☐ 해당 전문의의 재직증명서 ☐ 치과, 한의과 등은 의사 명단 및 자격증 사본	☐ 보증보험 가입 (1억원 이상, 가입기간 1년 이상) ☐ 자본금 규모 (1억원) ☐ 국내에 사무실을 둘 것
<u>첨부서류</u>	
☐ 사업계획서 1부 ☐ 의료기관 개설신고증명서 또는 개설허가증 사본 1부 ☐ 유치하고자하는 외국인환자 전문의의 명단 및 자격증 사본 ☐ 사업자등록증 사본 1부	☐ 정관 1부 (법인인 경우) ☐ 자본금 규모를 증명할 수 있는 서류 ☐ 사업계획서 1부 ☐ 보증보험에 가입된 사실을 증명할 수 있는 서류 1부 (보증보험증권 원본) ☐ 사무실에 대한 소유권이나 사용권이 있음을 증명하는 서류 ☐ 사업자등록증 사본 1부

<표 2> 자본금 확인 서류(예시)

설립유형	자본금증명	사실확인방법
법인	출자자본증자(유상증자)	등기부등본
	- 잉여자본금증자(무상증자) - 자본(자산에서 부채를 뺀 금액) - 회사내규 예산 확인서 - 재무제표 - 대차대조표	세무사 또는 회계사의 확인서
개인 사업자	- 개시대차대조표 - 대차대조표	
	예금잔액증명서	은행확인



<그림 2> 외국인환자 유치사업 등록 업무 절차도

6. 외국인환자 유치사업 등록 변경

가. 변경 신고가 필요한 경우

- 의료기관 : 의료기관명, 소재지, 대표자 등이 변경된 경우 등
- 유치업자 : 상호명, 소재지, 법인대표자 , 보증보험에 관한 사항 가운데 변경이 있는 경우 등

나. 변경신고 방법

- 변경신청서에 변경 내용 작성 후 한국보건산업진흥원에 제출

다. 등록증의 재발급

- 등록증을 발급받은 자가 등록증을 분실하였거나 헐어서 못쓰게 되어 재발급 받고자 할 때에는 등록증 재발급신청서(별지 제9호의 6서식)를 작성하여 한국보건산업진흥원에 제출
 - 등록증이 헐어서 못쓰게 된 경우, 기발급된 외국인환자 유치 의료기관 등록증 또는 외국인환자 유치업자 등록증을 반납해야함

라. 법령 위반 여부 점검

- 등록된 의료기관 및 유치업자를 현장 방문하여 법령에서 정하고 있는 등록 요건 및 의무사항 위반 여부 점검을 통해 법령 위반 여부 판단
 - 상호명, 소재지, 대표자 등 변동 여부, 보증의 변경 여부 등

7. 휴업 및 폐업, 휴업 후 영업 재개

가. 신고대상

- 외국인환자 유치사업에 등록한 의료기관 및 유치업자로서 휴업 또는 폐업하거나 영업을 재개하려는 자

나. 신고방법

- 외국인환자 유치사업을 등록한 의료기관 및 유치업자가 휴업 또는 폐업하는 경우 아래와 같이 서류를 구비하여 한국보건산업진흥원에 신청함

	휴업	폐업	휴업 후 영업 재개
의료기관 및 유치업자	• 휴업신고서 • 등록증	• 폐업신고서 • 등록증	• 재개업신고서

- 휴업에는 외국인환자 유치사업의 등록 후营业을 개시하지 아니하는 경우도 포함함
- 유치업자가 폐업 또는 휴업을 할 경우 현재 계약체결자 등 유치·소개 중에 있는 환자에 대한 조치계획서(별표9서식) 1부를 제출하여야 함
 - ※ 폐업 또는 휴업을 할 경우 현재 계약체결자 등 유치·소개 중에 있는 환자가 없는 경우 본인 확인서(자유양식)를 제출하도록 함
 - 외국인환자 유치사업의 변경, 휴업, 폐업의 신고(재발급 포함)를 대리인이 수행할 경우는 대표자의 위임장 및 신분증 사본을 제출하도록 함
- 유치업자가 폐업을 한 경우, 가입한 보증보험의 증권기간단축확인서(별표11서식) 발급을 신청할 수 있다.

8. 외국인환자 유치업자의 자본금 적용 기준

가. 외국인환자 유치업자 자본금 등록 요건

- 자본금의 규모는 1억원 이상이어야 함
 - 기존 사업을 운영하고 있을 경우에는 기존 사업의 법정 최저 자본금을 제외한 자본금이 1억원 이상으로 함

나. 외국인환자 유치사업 자본금 적용 기준

구분	기존사업의 법정최저자본금 필요 여부	외국인환자 유치사업 등록 자본금 충족요건
기존사업을 운영하고 있는 경우	필요	• 기존 사업의 법정최저자본금을 제외한 자본금이 1억원 이상 - 여유 자본금이 1억원 이상 : 증자 불필요 - 여유 자본금이 1억원이 안될 경우 : 증자 필요
	불필요	• 자본금 1억원 이상 - 보유 자본금이 1억원 이상이면 증자 불필요

기존사업을 운영하고 있지 않은 경우	-	• 자본금 1억원 이상
---------------------------	---	--

○ 유치업자가 등록신청시 다른 사업을 운영하고 있는 경우

1) 다른 법률에서 법정최저자본금이 필요한 사업을 운영하고 있는 경우

- 다른 법률에서 요구하고 있는 법정최저자본금을 충족한 나머지가 1억원 이상이어야 함(1억원이 안될 경우에는 증자 필요)

예) 관광진흥법상 여행업, 건설산업기본법, 은행법 등

2) 다른 법률에서 법정최저자본금이 필요한 사업을 운영하고 있지 않은 경우

- 자본금이 1억원 이상이면 됨(1억원이 안될 경우에는 증자 필요)

○ 유치업자가 기존 사업을 운영하고 있지 않은 경우

- 자본금이 1억원 이상이면 됨

○ 유치업자가 등록신청시 기존 사업을 운영하고 있고, 다른 법률에서 법정최저자본금을 요구하는 사업을 하고 있는 경우에는 그 증빙 자료를 제출하여야 함

- 관련 자료가 허위사실일 경우에는 의료법에서 규정하고 있는 외국인환자 유치업자의 등록요건을 충족하지 못하므로 등록취소 사유에 해당됨

- 증빙자료

- 현재 운영하고 있는 사업 중 법정최저자본금을 요구하고 있는 사업내역
- 법정최저자본금을 요구하고 있는 해당 법률
- 해당 법률에서 요구하고 있는 법정최저자본금의 금액

제2부 외국인환자 유치 사업 실적보고

1. 외국인환자 유치사업 실적보고 목적과 내용

가. 목적

- 법 제27조의2제3항에 따라 외국인환자 유치업자 및 의료기관은 유치한 외국인환자의 국적·성별 및 출생년도 등 보건복지부장관이 정하는 사항을 보고할 의무가 있음.
- 국적·인원, 진료과목, 외국인 환자의 병상 이용률 등을 파악하여 체계적인 외국인환자 유치행위를 위한 기본 통계 데이터로 활용함과 동시에 의료시장 질서 유지 및 외국인환자 유치 사업 전략 수립에 있어 마케팅 자료로 활용하기 위함
- 외국인환자 유치실적에 대한 지속적인 모니터링을 통하여, 내국인에 대한 역차별 여부 및 사업지원 대책을 마련하기 위해 필요함

나. 내용

1) 외국인환자 유치사업 실적보고 대상

- 외국인환자 유치 사업을 위하여 등록한 유치업자 및 의료기관을 대상으로 함

2) 외국인환자 유치사업 실적보고 접수 기관

- 외국인환자 유치사업 등록업무 및 사업실적 보고의 접수는 한국보건산업진흥원이 위탁 받아 수행함

의료법시행령 제42조(업무의 위탁)

② 법 제86조제2항에 따라 보건복지부장관은 다음 각 호의 업무를 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원에 위탁한다.

1. 법 제27조의2제1항 및 제2항에 따른 등록 업무(등록 요건 검토는 포함하되, 등록 여부 결정 및 등록증 발행·재발행은 제외한다)
2. 법 제27조의2제3항에 따른 사업실적 보고 업무

3) 외국인환자 유치사업 실적보고 주요 내용

- 외국인환자 유치 사업을 위하여 등록한 의료기관 및 유치업자는 매년 3월 31일까지 전년도 사업실적을 보고하여야 함
- 보고내용은 다음과 같은 사항을 포함하도록 함
 - 의료기관

- : 외국인환자의 국적, 성별 및 출생년도, 진료과목, 입원기간, 주상병명 및 외래 방문일수
- 유치업자
 - : 외국인환자의 국적, 성별 및 출생년도, 방문 의료기관, 진료과목, 입원기간 및 외래 방문일수, 입국일, 출국일
- 외국인환자 실적보고는 시행규칙 시행 후(2009.5.1) 최초로 유치한 외국인환자부터 적용하도록 함
- 제출방법
 - 등록 유치기관은 외국인환자 유치사업 실적보고 시스템 (<http://medicalkorea.khidi.or.kr>)을 통해 확인한 후 매년 3월 31일까지 한국보건산업진흥원에 제출하도록 함
 - 진흥원은 매년 4월 30일까지 보고받은 내용과 결과를 복지부장관에게 보고함

2.집계 대상이 되는 외국인환자 범위

※ 의료법 제27조제3항제2호에 따라 외국인환자에 해당되는 범위내의 환자만 집계합니다. 의료법상 외국인환자는 국민건강보험 미가입자! 국내 비거주자!이며, 국내 비거주는 외국인등록을 하지 않거나 거소신고를 하지 않은 자를 말합니다. 외국인환자의 범위는 다음과 같으며, 반드시 숙지하시어 정확한 통계보고에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 유치 행위를 할 수 없는 외국인환자의 범위

- 법 제27조제3항제2호에 따라 외국인환자를 유치할 수 있는 대상에서 제외되는 국내에 거주하는 외국인은 『국민건강보험법』 제93조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 국내에 거주하는 외국인으로서 아래의 어느 하나에 해당하는 외국인을 말합니다.
 - 『출입국관리법』 제31조에 따라 외국인등록을 한 사람
 - 『출입국관리법 시행령』 제12조 및 별표 1에 따른 기타(G-1)의 체류자격을 가진 사람은 제외
 - 『재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률』 제6조에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포
 - 재외국민(영주권자)은 우리나라 ‘국민’이므로 의료법 제27조3항2호에서 말하는 ‘외국인’에 해당할 수 없어 유치대상이 안됨

나. 유치 행위 대상이 되는 외국인환자의 범위

- 법 제27조제3항제2호에 따라 외국인환자를 유치할 수 있는 대상이 되는 외국인은 『국민건강보험법』 제93조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 외국인을 말합니다.
- 특수한 외국인 : 주한 외교관, 외국공관의 직원과 그 가족 등의 경우 외국인등록이 의무사항이 아니므로 국내에 장기체류하더라도 외국인등록을 하지 않으면 유치대상이 될 수 있습니다.
- 외국국적동포(시민권자) : 국민건강보험에 가입되어 있지 않고, 국내거소신고나 외국인등록이 되어있지 않으면 유치대상이 될 수 있습니다.

다. 외국인환자 유치대상 표

[외국인환자 유치대상 표]

		유치대상이 되는 경우	유치대상이 안 되는 경우
외국인	국내 거주	① 건강보험 미가입 + 외국인등록 하지 않은 경우 ② 건강보험 미가입 + 외국인등록 + G1 체류자격	① 건강보험 가입자(피부양자) ② 건강보험 미가입 + 외국인등록 ③ 외국인근로자(산재보험가입자)
	국외 거주	항상 유치대상이 됨	-
특수한 외국인 · 주한외국공관과 국제기구의 직원 및 그의 가족 · 주한미군 및 그의 가족 · 대한민국정부가 초청한 자 등으로서 외교·산업·국방상 요한 업무에 종사하는 자 및 그의 가족 · 기타 법무부장관이 특별히 외국인등록을 면제할 필요가 있다고 인정하는 자	국내 거주	① 건강보험에 미가입 + 외국인등록 하지 않은 경우	① 건강보험 가입자(피부양자) ② 건강보험 미가입 + 외국인등록
재외국민(영주권자) · 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권(영주권)을 취득한 자 또는 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자	국내·외거주	-	의료법에서 규정하고 있는 '외국인'이 아니므로 외국인환자 유치 대상이 되지 못함
외국국적동포(시민권자) · 대한민국의 국적을 보유하였던 자(대한민국정부 수립 전에 국외로 이주한 동포를 포함한다) 또는 그 직계비속(직계비속)으로서 외국국적을 취득한 자	국내 거주	① 건강보험 미가입 + 외국인등록 하지 않은 경우 ② 건강보험 미가입 + 국내거소신고 + G1 체류자격 ③ 건강보험 미가입 + 외국인등록 + G1 체류자격	① 건강보험 가입자(피부양자) ② 건강보험 미가입 + 국내거소신고 ③ 건강보험 미가입 + 외국인등록
	국외 거주	항상 유치대상이 됨	-

3. 외국인환자 실적보고를 위한 가이드라인

※ 외국인환자 유치사업 실적보고를 위하여 전반적인 가이드라인을 제시하여 드립니다.
참고하시기 바랍니다.

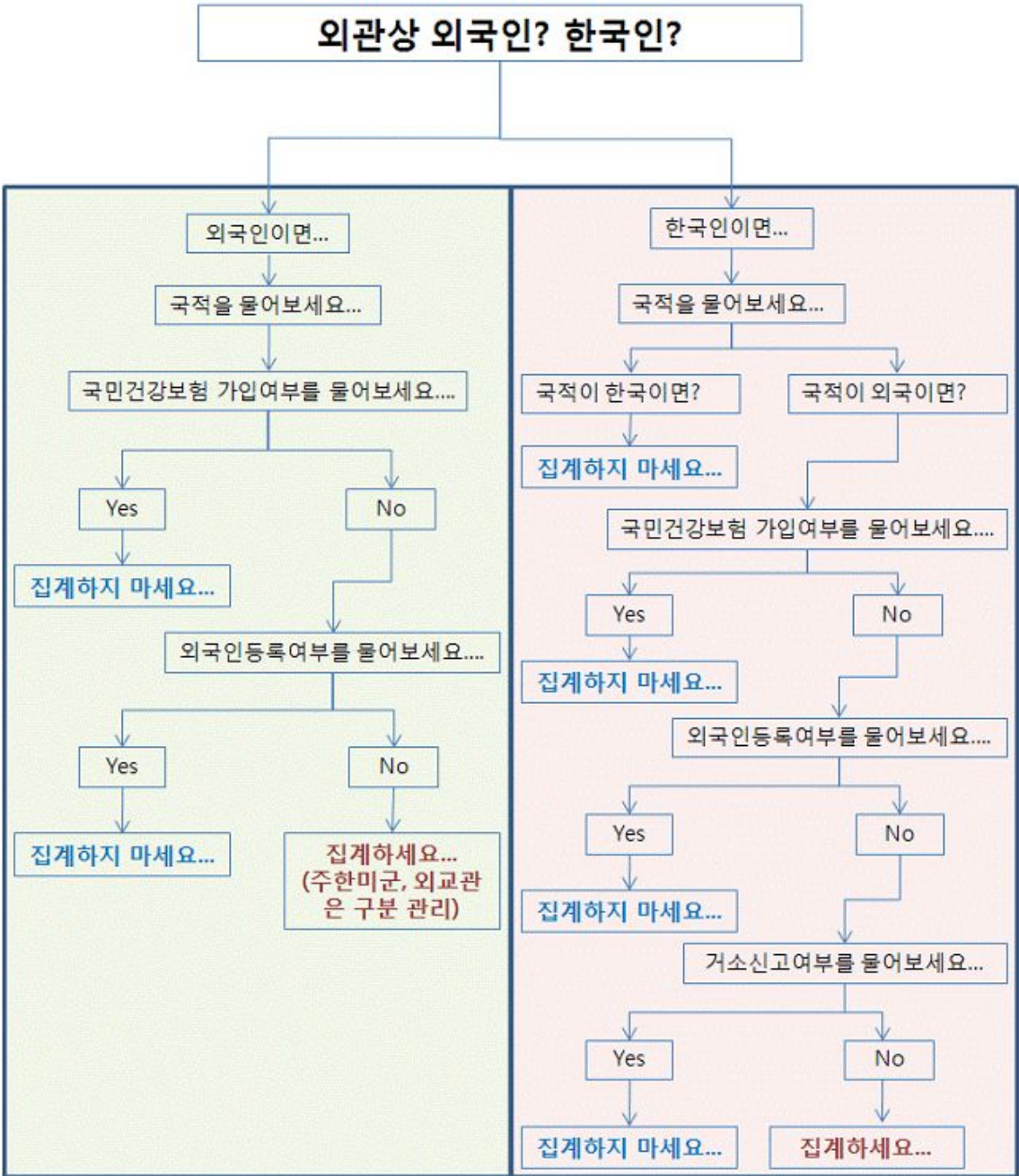
가. 외국인환자가 방문하면?

○ 아래와 같은 간단한 형식으로 문진을 합니다.

- 아래의 표는 외국인환자 집계를 위하여 필요한 항목만으로 작성된 것이므로 각 기관에서는 참고하셔서 기관에 맞는 양식을 만드시길 바랍니다.

Registration Form(Sample)			
환자 고유 번호 (의료기관용)		환자ID(집계용)	2009-□□□□□
Name(이름)		Birth(생년월일)	
Gender(성별)	☐ Male ☐ Female	Passport #(여권번호)	
Nationality(국적)			
Korean National Health Insurance (국민건강보험 가입여부)		☐ Yes ☐ No	
Foreign Registration (외국인등록여부)	☐ Yes (Number :) ☐ No		
Status(체류상태)	☐ Resident(거주) ☐ Tourist(관광) ☐ Health(의료목적) ☐ Other(기타) _____		
Occupation(직업)		☐ US Armed Forces in Korea(family) ☐ Diplomat(family) (주한미군 및 가족)(외교관 및 가족)	
Address(현 거주지)			
Telephone			
Emergency Contact			
E-mail address			

나. 외국인환자 내원 시 진행사항 가이드라인



4. 실적보고 항목별 입력방법 안내 (의료기관용)

※ 실적보고 방식은 개별 입력 방식과 엑셀업로드 방식이 있으며, 엑셀업로드 방식을 이용할 경우 사이트내에서 엑셀양식을 다운로드 받으신 후 작성하셔야 합니다.

※ 실적보고 항목은 다음과 같습니다.

환자ID, 국적, 출생년도, 성별, 진료과, KCD코드, 요양급여코드(비급여코드), 외래방문일수, 외래/입원, 초진일, 입원일, 퇴원일, 진료비 총 13개 항목

※ 항목별 입력방법에 대하여 안내하여 드리며, 충분히 숙지하시어 입력하시기 바랍니다.

가. 환자ID

- 2009-00001, 2009-00002, 2009-00003, ...로 개별 환자의 유일한 번호를 부여하셔야 합니다.
- '2009'는 조사년도이며, '00001'은 일련번호로 최대 99,999명까지 입력 가능합니다.
- 고유번호 체계 :

년도	일련번호
2009	00001

- 단, 주한미군의 경우 환자ID를 2009-90001, 2009-90002, 2009-90003, ...으로 부여해주십시오.
- ※ 외교관과 그 가족의 경우에는 2010년도부터 별도 코드를 부여할 예정임
- 실환자 수를 산출하기 위하여 반드시 필요한 항목이므로, 기관에서 숙지하여 환자번호를 관리하셔야 합니다.

나. 국적

- 196개의 국적으로 표준화 되어 있습니다.
- 개별입력 시: 해당 국적을 검색하여 국적을 반드시 입력하셔야 합니다.
- 엑셀업로드 시: 제공되는 196개의 표준화 된 국적표에서 해당 국적을 찾으셔서 반드시 한글로 입력하신 후 업로드 하셔야 합니다.

다. 출생년도

- 해당 외국인환자의 출생한 년도를 4자리(YYYY)로 반드시 입력하셔야 합니다.

라. 성별

- 남/여로 반드시 입력하셔야 합니다.

마. 진료과

- 25개의 진료과로 표준화 되어 있습니다.
 - 개별입력 시: 해당 진료과를 검색하여 진료과를 반드시 입력하셔야 합니다.
 - 엑셀업로드 시: 제공되는 25개의 표준화 된 진료과표에서 해당 진료과를 찾으셔서 반드시 한글로 입력하신 후 업로드 하셔야 합니다.
- 해당 진료과를 찾을 수 없는 경우에는 ‘기타’로 분류하시기 바랍니다.

바. KCD코드

- 기입력한 진료과에 해당하는 KCD코드(주 질병)를 찾아 반드시 입력하셔야 합니다.
- 2,045개의 KCD코드로 표준화 되어 있습니다.
 - 개별입력 시: 해당 KCD코드를 검색하여 KCD코드를 반드시 입력하셔야 합니다.
 - 엑셀업로드 시: 제공되는 2,045개의 표준화 된 KCD코드표에서 해당 KCD코드를 찾으셔서 반드시 코드로 입력하신 후 업로드 하셔야 합니다.
- 방문하는 외국인환자의 주요 질병을 알기위한 목적이므로, 해당 KCD코드가 없는 경우 가장 가까운 코드를 찾아 반드시 입력하셔야 합니다.

사. 요양급여코드(비급여코드)

- 기입력한 KCD코드에 해당하는 요양급여코드(비급여코드)를 찾아 반드시 입력하셔야 합니다.
- 6,988개의 요양급여코드로 표준화 되어 있습니다.
 - 개별입력 시: 해당 요양급여코드(비급여코드)를 검색하여 요양급여코드(비급여코드)를 반드시 입력하셔야 합니다.
 - 엑셀업로드 시 : 제공되는 6,988개의 표준화 된 요양급여코드표(비급여코드표)에서 해당 요양급여코드(비급여코드)를 찾으셔서 반드시 코드로 입력하신 후 업로드 하셔야 합니다.
- 방문하는 외국인환자가 어떤 치료를 받았는지를 알기위한 목적이므로, 해당 요양급여코드(비급여코드)가 없는 경우 가장 가까운 코드를 찾아 반드시 입력하셔야 합니다.

- 외국인환자는 대부분 비급여 대상이지만, 방문하는 외국인환자가 어떤 치료를 받았는지를 알기위한 목적이므로 외국인환자가 받은 주 치료가 급여에 해당하는 경우는 반드시 급여코드를 입력하셔야 합니다.

아. 외래방문일수

- 조사기간 동안 외국인환자가 해당 진료과에 방문한 총 일수를 입력하셔야 합니다.
 - 일정기간을 두고 같은 진료과를 방문한 경우, 해당 진료과 방문 일수를 모두 합하여 입력
 - 예) 외국인환자가 2009년 3월 1일 내과를 외래로 3일 방문한 후 2009년 8월 1일 내과를 외래로 5일 방문한 경우, 이 외국인환자의 외래방문일수는 총 8일이 됩니다.

자. 입원/외래

- 해당진료과에 외래인 경우 외래로, 입원인 경우 입원으로 구분하여 주시기 바랍니다.
 - 개별입력 시 : 외래, 입원을 선택하여 주십시오.
 - 엑셀업로드 시 : 외래, 입력을 한글로 입력하여 주십시오.

차. 초진일

- 조사기간 동안 외국인환자가 해당 진료과에 처음 방문한 일(YYYYMMDD)을 입력하셔야 합니다.

카. 입원일

- 조사기간 동안 외국인환자가 해당 진료과에 입원을 한 경우 입원일(YYYYMMDD)을 입력하셔야 합니다.
 - 해당 진료과에 외래 후 입원한 경우는 입원환자로 분류되므로, 입원기록(진료과, KCD코드, 요양급여코드 등)을 입력

타. 퇴원일

- 조사기간 동안 외국인환자가 해당 진료과에 퇴원을 한 경우 퇴원일(YYYYMMDD)을 입력하셔야 합니다.
 - 조사기간 전에 입원을 하여 조사기간 내에 퇴원을 행한 외국인환자는 집계되지 않음

파. 진료비

- 조사기간 동안 외국인환자가 해당 진료과에서 발생한 진료비 총 금액(원)을 입력하셔야 합니다.(반드시 숫자만 입력하셔야 합니다.)
 - 외국인환자가 여러 개의 다른 진료과를 방문하였을 때, 여러 개의 진료과에서 발생한 진료비 총합으로 산출되는 경우는 총합으로 한번만 입력
 - 외국인환자가 여러 개의 다른 진료과를 방문하였을 때, 각 진료과에 대한 진료비가 각각 산출되는 경우는 각각 입력
- 외국인환자 유치사업의 경제성 평가를 위하여 필요한 항목이므로 반드시 입력하셔야 하며, 위 목적 외에는 사용되지 않습니다.

하. Case별 구체적 입력 및 산출 방법

○ 단일진료과 방문시

- A환자가 1개 진료과 외래 방문

환자I D	국 적	출 생 년 도	성 별	진료과	KCD코 드	요양급여 코드	외래방문 일 수	외래/입 원	초진일	입원 일	퇴원 일	진료 비
2009-00001	일본	1964	여	산부인과	산부인과 주 질병	산부인과 주 치료	2	외래	20090415			원

- B환자가 1개 진료과 외래 방문 후 동일 과 입원

환자I D	국 적	출 생 년 도	성 별	진료과	KCD코 드	요양급여 코드	외래방문 일 수	외래/입 원	초진일	입원일	퇴원일	진료 비
2009-00003	중국	1945	여	내과	내과 주 질병	내과 주 치료	1	입원	20090515	20090516	20090518	원

○ 복수진료과 방문시

- C환자가 2009년 3월에 2개 진료과 외래 방문, 2009년 8월에 다른 1개 진료과 외래 방문

환자I D	국 적	출 생 년 도	성 별	진료과	KCD코 드	요양급여 코드	외래방문 일 수	외래/입 원	초진일	입원 일	퇴원 일	진료 비
----------	--------	------------------	--------	-----	-----------	------------	----------------	-----------	-----	---------	---------	---------

2009-00002	미 국	195 5	남	내과	내과 주 질병	내과 주 치료	1	외래	2009030 1			원
2009-00002	미 국	195 5	남	외과	외과 주 질병	외과 주 치료	2	외래	2009030 1			원
2009-00002	미 국	195 5	남	비뇨기 과	비뇨기 과 주 질병	비뇨기과 주 치료	1	외래	2009082 0			원

- D환자가 2개 진료과 외래 방문 후 1개 진료과 입원

환자ID	국적	출 생 년 도	성 별	진료 과	KCD코 드	요양급여 코드	외래방문 일수	외래/입 원	초진일	입원일	퇴원일	진료 비
2009-00004	필리 핀	197 5	남	내과	내과 주 질병	내과 주 치료	1	외래	200903 01			원
2009-00004	필리 핀	197 5	남	외과	외과 주 질병	외과 주 치료	1	입원	200903 01	200903 01	200903 15	원

5. 실적보고 항목별 입력방법 안내(유치업자용)

※ 실적보고 방식은 개별 입력 방식과 엑셀업로드 방식이 있으며, 엑셀업로드 방식을 이용할 경우 사이트내에서 엑셀양식을 다운로드 받으신 후 작성하셔야 합니다.

※ 실적보고 항목은 다음과 같습니다.

국적, 출생년도, 성별, 입국일, 출국일, 진료과, 방문의료기관, 외래방문횟수, 외래/입원, 초진일, 입원횟수 총 11개 항목

※ 항목별 입력방법에 대하여 안내하여 드리며, 충분히 숙지하시어 입력하시기 바랍니다.

가. 국적

○ 196개의 국적으로 표준화 되어 있습니다.

- 개별입력 시 : 해당 국적을 검색하여 국적을 반드시 입력하셔야 합니다.

- 엑셀업로드 시 : 제공되는 196개의 표준화 된 국적표에서 해당 국적을 찾으셔서 반드시 한글로 입력하신 후 업로드 하셔야 합니다.

나. 출생년도

- 해당 외국인환자의 출생한 년도를 4자리(YYYY)로 반드시 입력하셔야 합니다.

다. 성별

- 남/여로 반드시 입력하셔야 합니다.

라. 입국일

- 해당 외국인환자가 입국한 일자를 총 8자리(YYYYMMDD)로 반드시 입력하셔야 합니다.

마. 출국일

- 해당 외국인환자가 출국한 일자를 총 8자리(YYYYMMDD)로 반드시 입력하셔야 합니다.

바. 진료과

- 25개의 진료과로 표준화 되어 있습니다.
 - 개별입력 시 : 해당 진료과를 검색하여 진료과를 반드시 입력하셔야 합니다.
 - 엑셀업로드 시 : 제공되는 25개의 표준화 된 진료과표에서 해당 진료과를 찾으셔서 반드시 한글로 입력하신 후 업로드 하셔야 합니다.
- 해당 진료과를 찾을 수 없는 경우에는 ‘기타’로 분류하시기 바랍니다.
- 처음 방문한 진료과가 응급의학 혹은 가정의학인 경우는 이후에 방문한 진료과를 입력하셔야 합니다.
 - 응급의학 혹은 가정의학에서 진료가 끝난 경우는 그대로 입력 가능

사. 방문의료기관

- 총 1,499개(2010.2.4 기준) 외국인환자 유치 등록 의료기관으로 표준화 되어 있습니다.
 - 개별입력 시 : 해당 의료기관을 검색하여 의료기관을 반드시 입력하셔야 합니다.
 - 엑셀업로드 시 : 제공되는 1,499개의 표준화 된 등록 의료기관에서 해당 등록의료기관을 찾으셔서 반드시 한글로 입력하신 후 업로드 하셔야 합니다.

아. 외래방문횟수

- 한 환자가 의료기관을 방문한 총 횟수를 입력하셔야 합니다.

자. 입원/외래

- 해당 의료기관에 외래인 경우 외래로, 입원인 경우 입원으로 구분하여 주시기 바랍니다.
- 개별입력 시 :
- 엑셀업로드 시 :

차. 초진일

- 조사기간 동안 외국인환자가 해당 의료기관에 처음 방문한 일(YYYYMMDD)을 입력하셔야 합니다.

카. 입원일

- 조사기간 동안 외국인환자가 해당 진료과에 입원을 한 경우 입원일(YYYYMMDD)을 입력하셔야 합니다.
- 해당 진료과에 외래 후 입원한 경우는 입원환자로 분류되므로, 입원기록(진료과, KCD코드, 요양급여코드 등)을 입력

타. Case별 구체적 입력 및 산출 방법

1) 단일 의료기관 방문시

- A환자가 1개 의료기관 외래 방문

국 적	출생 년도	성 별	입국일	출국일	진료과	방문의료기 관	외래방문횟 수	외래/입 원	초진일	입원횟 수
일 본	196 4	여	2009041 5	2009042 5	산부인 과	가 산부인과의 원	5	외래	2009041 5	

- B환자가 1개 의료기관 외래 방문 후 동일 의료기관 입원

국 적	출생 년도	성 별	입국일	출국일	진료과	방문의료기 관	외래방문횟 수	외래/입 원	초진일	입원횟 수
중 국	194 4	여	2009060 1	2009061 5	내과	나 종합병원	2	입원	2009060 2	1

2) 복수 의료기관 방문시

- C환자가 2009년 3월에 2개 의료기관 외래 방문, 2009년 8월에 다른 1개 의료기관 외래 방문

국 적	출 생 년 도	성 별	입국일	출국일	진료과	방문의료기 관	외래방문횟 수	외래/입 원	초진일	입원횟 수
미 국	195 5	남	2009081 5	2009081 6	내과	다 의원	1	외래	2009081 5	
미 국	195 5	남	2009081 5	2009081 6	치과	라 치과의원	1	외래	2009081 5	
미 국	195 5	남	2009081 5	2009081 6	비뇨기 과	마 비뇨기과	1	외래	2009081 6	

- D환자가 2개 의료기관에 외래 방문 후 1개 의료기관에 입원

국적	출생 년도	성 별	입국일	출국일	진료 과	방문의료기 관	외래방문횟 수	외래/입 원	초진일	입원횟 수
필리 핀	197 5	남	2009092 5	2009100 1	내과	바 의원	1	외래	2009092 5	
필리 핀	197 5	남	2009092 5	2009100 1	외과	사 의원	1	입원	2009092 5	1

3) 산출방법

- 동일한 방문 의료기관의 외래와 입원은 입원을 기준으로 집계합니다.

Case	입력건수	분석(산출)
외래 1건	외래 1건	(실환자 분석 시) 외래환자 1건 (의료기관별 분석 시) 외래환자 1건
외래 2건(다른 의료기관)	외래 2건	(실환자 분석 시) 외래환자 1건 (의료기관별 분석 시) 외래환자 2건
외래 1건, 입원 1건 (같은 의료기관)	입원 1건	(실환자 분석 시) 입원환자 1건 (의료기관별 분석 시) 입원환자 1건
외래 2건, 입원 1건	외래 1건, 입원 1건	(실환자 분석 시) 입원환자 1건 (의료기관별 분석 시) 입원환자 1건, 외래환자 1건

6. Q & A

가. 외국인환자를 유치하기 위해 꼭 등록해야 하나요?

- 외국인 환자를 유치하려는 의료기관 및 유치업자에게 일정요건을 갖춰 등록하게 함으로써 무분별한 외국인 환자 유치행위로 인한 국내 의료 시장질서 혼탁화를 방지하고 지속적으로 관리할 수 있는 제도적 장치로 활용하기 위하여 외국인환자 유치사업의 등록을 시행하고 있습니다. 따라서 의료법 제27조의2(2009.1.30 공포)에 의거 외국인환자를 유치하려는 의료기관 및 유치업자는 의료법 및 보건복지부령에서 정한 요건을 갖추어 의무적으로 등록하여야 합니다.

나. 외국인환자 유치 실적보고를 꼭 해야만 하나요?

- 의료법 제27조의2제3항(2009.1.30 공포)에 따라 외국인환자 유치업자 및 의료기관은 유치한 외국인환자의 국적, 성별, 진료과목, 입원기간 등 보건복지부장관이 정하는 사항을 보고할 의무가 있습니다. 따라서 매년 3월31일까지 전년도 외국인 환자 사업실적을 반드시 한국보건산업진흥원에 보고하여야 합니다.

다. 외국인환자의 유치 관련 등록은 어디서, 어떻게 하나요?

- 외국인환자 유치 관련 등록은 의료법 시행령 제42조(업무의 위탁)에 따라 등록업무, 사업실적 보고업무를 한국보건산업진흥원이 위탁받았습니다.

의료법시행령 제42조(업무의 위탁)

- ② 법 제86조제2항에 따라 보건복지부장관은 다음 각 호의 업무를 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원에 위탁한다.
 1. 법 제27조의2제1항 및 제2항에 따른 등록 업무(등록 요건 검토는 포함하되, 등록 여부 결정 및 등록증 발행·재발행은 제외한다)
 2. 법 제27조의2제3항에 따른 사업실적 보고 업무

- 따라서 한국보건산업진흥원은 등록 및 사업실적보고 업무를 위탁받아 수시로 접수를 받으며 신청자는 공휴일을 제외한 행정처리 가능 일에 우편(등기) 및 직접방문을 통해 등록신청서와 구비서류를 제출할 수 있습니다.

라. 외국인환자 실적보고를 어떻게 해야 하나요?

- 한국보건산업진흥원의 홈페이지를 통해 사업실적 보고 양식을 확인한 후 진흥원에

다음연도 3월 31일까지 제출해야 합니다.

- 단 최초 실적보고 제출자는 의료법 시행(2009.5.1) 후 최초 유치한 외국인부터 보고 대상으로 하고 외국인환자 실적보고 양식은 추후 진흥원 홈페이지를 통해서 공지할 예정입니다.

마. 해외교포가 외국인환자 유치 대상에 포함이 되나요?

- 외국인환자 유치활동의 허용 대상은 「국민건강보험법」 제93조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 외국인에 한정하며 보건복지부령이 정하는 바에 따라 유치활동이 불가능한 국내에 거주하는 외국인은 아래와 같습니다.
 - 「출입국관리법」 제31조의 규정에 따라 외국인등록을 한 사람
(출입국관리법시행령 제12조 및 별표1에 따른 기타(G-1)에 해당하는 체류자격을 가진 자는 제외함)
 - 「재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포
- 또한 이중국적자 등 내국인 범주에 속하는 사람도 그 대상에서 제외됩니다.

◆ 외국인환자 범위

- 국민건강보험 가입자나 피부양자가 아닌 외국인(단, 외국인 등록이나 거소신고를 한 국내 거주 외국인은 제외)
 - 주한미군 및 그 가족, 외교관 등 관련법상 외국인등록대상이 아닌 국내 거주 외국인
 - 외국인 등록을 한 사람일지라도 「출입국관리법시행령」 제12조 및 별표1에 따른 기타(G-1)의 체류자격을 가진 사람
 - 외국인 등록이나 거소신고를 하지 않은 외국국적동포(시민권자)
- ※ 재외국민(영주권자)는 유치 대상자에서 제외

바. 등록증을 분실하였거나 훼손 됐을 경우 어떻게 하나요?

- 외국인환자 등록증을 분실 또는 훼손(잃어버렸거나 찢어서 못쓰게 된 경우) 되었을 경우, 해당 의료기관 및 유치업자는 한국보건산업진흥원에 재신청하며 진흥원은 이를 검토 후 복지부에 재발급을 요청하고 복지부로부터 등록증을 재발급받아 신청자에게 재교부합니다.

제3부 외국인환자 사증발급 체류절차

1. 외국인의 입국절차

가. 개요

대한민국에 입국하고자 하는 **외국인은 유효한 여권에 사증**을 받아야 함 [출입국관리법 제7조 제1항]

1) 외국인

대한민국의 국적을 가지지 아니한 자(법 제2조 제2호)

- 무국적자와 외국국적을 가진 자를 모두 포함

2) 유효한 여권

○각국 정부가 발급하는 여행문서 (외교관·관용·일반여권)

○국제연합 또는 그 전문기구의 직원에 대하여 국제연합사무국이 발급하는
국제연합통행증(LAISSEZ-PASSER, 라세파세)

○난민협약에 따라 체약국이 자국에 체류하는 난민에게 발급하는 난민여행증명서, 각국
정부 발급 외국인여행증명서 등

3) 사증

○사증이란 일종의 배서 또는 확인

- 국가정책에 따라 “입국허가 확인”으로 보는 국가와 영사의 “입국추천행위”로 보는
국가로 대별

○우리나라는 “입국추천행위”에 해당

- 사증을 소지하고 있어도 입국허가 요건(법제12조제3항 각호)을 갖추지 못한 경우에는
입국을 허가하지 아니할 수 있음 (동조제4항)

○사증의 종류

- 사용가능 횟수에 따라 단수사증(유효기간 내 1회 입국, 발급일로부터 3개월간 유효)과
복수사증(유효기간 내 2회 이상 입국, 유효기간 다양)

※ 2회 유효사증 : 러시아 통과여객에게 발급 ('09.8.1.)

- 체류기간에 따라 단기사증(90일 이하)과 장기사증(91일 이상)

- 입국목적에 따라 A, C, D, E, F, G, H계열로 세분

A계열 : 외교(A-1), 공무(A-2), 협정(A-3)

C계열 : 일시취재(C-1), 단기상용(C-2), **단기종합(C-3)**, 단기취업(C-4)

D계열 : 문화예술(D-1), 유학(D-2), 산업연수(D-3), 일반연수(D-4), 취재(D-5), 종교(D-6), 주재(D-7), 기업투자(D-8), 무역경영(D-9), 구직(D-10)

E계열 : 교수(E-1), 화화지도(E-2), 연구(E-3), 기술지도(E-4), 전문직업(E-5), 예술흥행(E-6), 특정활동(E-7), 연수취업(E-8), 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10)

F계열 : 방문동거(F-1), 거주(F-2), 동반(F-3), 재외동포(F-4), 영주(F-5)

기타(G-1), 관광취업(H-1), 방문취업(H-2)

4) 사증발급 절차

- 신청인이 신청서류 등을 구비하여 직접 재외공관에 신청하여 영사의 심사 등을 거쳐 발급 받는 것이 일반적(법제8조)
- 초청자의 편의 등을 위해 미리 출입국관리사무소장으로부터 사증발급인정서를 발급받아 재외공관에 신청하는 것도 허용(법제9조)

나. 입국허가 요건

- 법제11조에 규정된 입국금지사유에 해당되지 않아야 하고 법제12조(입국심사)의 요건을 모두 갖추어야 함
- 원칙적으로 사증을 소지하여야 하나 다음의 경우에는 사증 없이 입국할 수 있음(법제7조 제2항, 시행령 제8조 제1항)

- 재입국허가를 받은 자 또는 재입국허가가 면제된 자로서 그 허가 또는 면제받은 기간이 만료되기 전에 입국하는 자 (난민여행증명서를 발급받고 출국하여 유효기간내 입국자 포함)
- 대한민국과 사증면제협정을 체결한 국가의 국민으로서 그 협정에 의하여 면제대상이 되는 자
 - 프랑스 등 90개 국가, 취업 등 영리활동 및 장기체류자는 목적에 적합한 사증 필요
- 국제친선·관광 또는 대한민국의 이익 등을 위하여 입국하는 자로서 대통령이 정하는 바에 따라 따로 입국허가를 받은 자
 - 관광·통과 등 목적 무사증입국허가지정국가(51개국) 국민, 국제연합기구 등 발급 여권소지자
 - 캐나다, 호주, 홍콩, 슬로베니아, 마카오, 일본, 미국 등 (상호주의)
 - 제주지역 관광입국자 등
 - 기타
- 국가는 외국인의 입국을 허용할 의무는 없으며, 사증(Visa)제도 등을 통해 외국인의 입국과 체류를 적절하게 관리

다. 입국심사

- 모든 출입국자는 출입국관리공무원의 출입국심사를 받아야 하며 업무수행에 필요한 정당한 질문에 성실히 답변하여야 함 (법제12조)
- 만일 외국인이 입국심사를 받는 과정 중에 이를 어길 경우 비우호적 행위 등으로 간주되어 입국거부 등을 당할 수 있음
- 우리나라의 출입국심사시스템(KISS)은 세계 최고 수준을 자랑 (5년 연속 세계 1위)
- ※ 첨단 여권심사장비(MRP) 설치, 사전여객정보 검색(APIS), 무인자동심사시스템 구축, 세계 최고 수준의 위변조여권 감식 능력, 여객의 흐름에 따라 탄력 대응하는 근무시스템 등

2. 외국인의 체류관리

외국인은 그 체류자격과 체류기간의 범위 내에서 대한민국에 체류할 수 있다. (법제17조)

가. 개관

1) 개요

- 국내 체류 외국인의 체류자격에 따른 활동과 기간 등에 따라 수반되는 외국인등록, 체류기간연장, 체류자격변경 등 일련의 절차
- 우리나라는 외국인의 출입국 및 체류관리에 관한 기본제도로써 체류자격제도를 두고 있음(법 제10조 및 시행령 제12조)
- 체류자격이란 외국인이 국내에 체류하면서 행할 수 있는 사회적인 활동이나 신분의 종류를 유형화한 것
 - 그 활동이나 신분을 유지하고 강제퇴거사유에 해당하는 법령 위반을 하지 않으면 그 허가기간 동안 국내 체류가 허용
- 다른 체류자격으로 변경하거나 그 체류자격에 해당하는 활동이외의 활동을 할 경우에는 반드시 사전허가를 받아야 함

2) 체류관리 조직

- 외국인 관련 정책·법령 등은 법무부출입국외국인정책본부가 담당, 전국 36개 산하 출입국관리사무소는 실무 집행 담당

3) 체류자격 및 활동

- 체류자격의 종류(37개) 및 자격별 활동범위는 시행령 제12조에 규정
- 입국목적에 따른 사증상의 체류자격에 사증면제(B-1), 무사증입국(B-2)이 추가

나. 체류단계별 절차

1) 체류관리 일반기준

- 국익우선, 국민대체성, 상호주의 원칙 적용
 - 우수 전문외국인력에 대한 체류 특혜, 국민 대체 가능한 분야에 외국인취업 제한, 복수 재입국허가 등
- 체류자격별 체류기간 부여 등 체류관리기준의 신축적 운영
 - 90일부터 무기한까지 체류자격별로 1회 체류허가기간을 차등 부여
- 외국인의 인권보호 및 인도주의와 형평성 유지
 - 불법체류자라 하더라도 신병치료, 소송 등 인도적 사유가 있는 경우 기타자격으로 체류허가 (또는 특별체류허가)
- 국제화개방화 추세에 따른 환경변화에 능동적으로 대처
 - 고액투자자 등에 대한 영주자격 부여, 구직비자 신설 등

2) 외국인등록 (법 제31조 내지 제37조, 영 제40조 내지46조)

- 90일 이상 장기체류하는 외국인의 체류지 및 체류지 변동 등 체류사항 전반을 관리하기 위한 제도
- 입국한 날부터 90일을 초과하여 체류하거나 체류자격변경을 받아 입국일로부터 90일을 초과하여 체류하려는 자는 체류지 관할 출입국관리사무소(출장소)에 입국일로부터 90일 이내(또는 자격변경 허가일)에 외국인등록을 하여야 함
 - ※ 외교·공무협정수행자(A-1·-2·-3) 및 그 가족, 기타 법무부장관이 특별히 외국인등록을 면제할 필요가 있다고 인정되는 자는 외국인등록의무 면제
- 출입국관리법 개정('10.4.21.)으로 입국 및 외국인등록 시 지문채취 가능(개정 출입국관리법 공포 3개월 후부터 적용)

3) 체류지변경의 신고(법 제36조, 영 제45조)

○체류지 변경 시에는 신 체류지 관할 출입국사무소 또는 자치단체장에게 전입한 날로부터 14일 이내에 신고

- 전입신고를 받은 기관의 장은 상대 기관에 체류지변경사실 등 통보(전산처리)

4) 체류자격 부여(법 제23조, 영 제30조)

○ 국내에서 출생한 외국인이나 한국국적을 상실하고 외국 국적을 취득한 자에게 국내에 체류할 수 있도록 허가하는 제도

○ 국내에서 출생한 외국인의 자녀, 주한미군 현지제대자, 한국 국적상실자 등으로서 국내에서 30일 이상 체류하려는 자

※ 개정 출입국관리법 공포 3개월 후부터는 90일로 변경

○ 부모 등의 체류자격 및 체류기간, 신청인의 국내 체류활동 내용 등을 감안하여 체류자격 및 체류기간 부여

- 단, 사유발생일로부터30일 이내 출국 시 별도허가 불필요

5) 체류기간 연장(법 제25조, 영 제31조)

○ 허가받은 체류기간을 초과하여 계속 체류하고자 하는 경우 그 활동내용이나 체류필요성 등을 심사하여 허가하는 제도

○ 외국인의 활동이 국익이나 사회질서에 반하거나 법령에 체류기간의 상한이 정해져 있는 경우를 제외하고는 연장 허용

○ 체류기간 만료 전에 체류지 관할 출입국사무소장의 체류기간연장허가를 받아야 하며, 체류자격별로 1회 부여 체류허가기간의 상한이 있음

○ 체류기간연장 등의 신청을 불허하는 경우 불허결정통지서를 발급하고 14일 범위 내에서 출국기한을 명시(단, 필요시 기 허가받은 체류기간만료일까지 출국기한 부여 가능)

6) 체류자격 변경(법 제24조, 영 제30조)

○ 원래 허가 받은 체류자격의 활동을 하지 않고 다른 체류자격의 활동을 하고자 신청하는 경우에 그 허가여부를 심사하는 제도

- 국내에서 무분별하게 체류자격 변경허가 시 사증제도의 실효성이 상실되므로 체류자격별 허용기준에 따라 심사 결정

○반드시 사전에 소정의 첨부서류를 제출하여 관할 출입국관리사무소장 등의 체류자격 변경허가를 받은 후에 활동하여야 함

7) 체류자격외활동(법 제20조, 영 제25조)

- 원래 허가받은 체류자격과 활동을 유지하면서 종전의 활동과 다른 체류자격의 활동을 추가로 할 수 있도록 허용하는 제도
- 체류질서 확립 차원에서 취업자격의 경우 제한적으로 허용하지만 한국어 연수, 유학 등은 별도의 허가 없이 전면적으로 허용

8) 근무처변경·추가(법 제21조, 영 제26조)

- 원래 허가받은 체류자격과 활동을 유지하면서 근무처를 변경하거나 추가하려는 경우에 허가여부를 결정하는 제도
- 외국인력 활용도를 일정 부분 제고할 수 있으나 남발할 경우 체류질서 문란 등의 소지가 있어 제한적으로 허용
- 미리 소정의 첨부서류를 제출하여 허가를 받아야 하며, 허가 받지 아니한 외국인을 고용하거나 알선하는 행위는 금지

9) 재입국허가(법 제30조, 영 제38조)

- 등록외국인이 국내 체류 중에 미리 재입국허가를 받으면 일시적으로 출국하였다가 동일한 체류자격의 활동을 하려고 다시 입국할 경우 새로운 비자를 받지 않아도 되는 제도
 - 재입국면제협정이 체결된 국가의 국민이나 영주자격의 경우에는 재입국허가 면제대상이며, 개정 출입국관리법 공포일로부터 6개월 후에는 국민의 배우자 등 법무부장관이 정하는 등록외국인은 재입국허가 면제대상이 됨
- 체류외국인 편의를 위해 복수재입국허가를 확대하고 있으며, 재외공관의 장이 최대 3개월까지 연장가능

10) 외국인을 고용한 자 등의 신고의무 (법제19조, 영제24조)

- 외국인을 고용한 자가 선량한 관리책임을 다하도록 법정 신고의무를 부여하는 제도
- 외국인을 해고하거나 외국인이 퇴직 또는 사망한 때, 그 소재를 알 수 없게 된 때, 고용계약의 중요한 내용을 변경한 때, 출입국관리법령 등의 위반행위를 한 때에는 신고의무 발생

- 사유 발생일 또는 안날로부터 15일 이내 체류지 관할 출입국관리사무소에 신고 (방문 신고, 온라인 신고, 팩스 신고 가능)

11) 외국인 고용의 제한 (법제18조, 영제23조)

- 외국인의 불법고용을 방지하여 국내노동시장을 보호하고 외국인체류질서를 확립하기 위해 취업자격을 가지지 아니한 외국인을 고용하거나 알선하는 행위 등을 금지
- 불법고용주에게는 범칙금(통고처분)을 부과하고, 범칙금 불이행 또는 상습적 위반 등 죄질이 나쁜 경우에는 가중처벌이나 형사고발을 하고 외국인고용이나 초청 등을 제한

12) 허가권한의 위임 (법제92조 제1항, 영제96조 제1항)

- 출입국관리법 상 사증발급 및 체류허가 등의 권한은 법무부장관에게 있으나 입국금지자, 사증발급규제자 등을 제외한 일반적인 체류허가권한을 출입국관리사무소장 등에게 위임

다. 초청 및 각종 허가신청, 신원보증 등

1) 허위초청의 금지(법제7조의2)

- 누구든지 외국인을 입국시키기 위해 허위사실의 기재 또는 허위의 신원보증 등 부정한 방법으로 외국인을 초청하거나 알선하는 행위, 허위로 사증 또는 사증발급인정서를 신청하거나 알선하는 행위를 하여서는 아니됨
- 위반 시 3년 이하의 징역이나 금고 또는 2천만원 이하의 벌금(출입국관리법 제94조)

2) 각종 허가 등의 신청 (법제79조, 영제89조)

- 신청인의 체류지 관할 사무소에 본인이 신청하는 것이 원칙이나 위임을 받은 대리자가 대리 가능
- 위임의 대상업무 및 체류자격별 대리인의 자격은 법무부장관이 고시하며, 필요시 본인이 직접 신청토록 제한 가능

3) 신원보증인 (법제90조, 영제93조)

- 체류 외국인의 준법활동을 보장하고 유사 시 출국비용 등을 부담할 수 있도록 신원보증인 제도 운영(공증제도는 '05.9.폐지)

- 국내에 주소를 둔 성년자로 일정한 직업을 가진 자나 미성년자의 부모가족 등은 보증능력이 있는 것으로 봄
 - 주로 고용주나 초청자 및 부모 등 가족 친지가 보증인이 됨

3. 외국인환자 사증발급 및 체류절차

가. 개관

1) 추진 경과

- '08.4. ~ '09.4.<외국인환자 전용비자 발급 이전>
 - 재외공관장 재량으로 G-1 복수사증 발급 (사증 유효기간 1년, 체류기간 90일 또는 1년)
 - 질병치료 또는 요양목적으로 국내 전문의료기관 또는 요양시설에 입원하고자 하는 환자 및 그 배우자자녀 또는 직계가족
 - 계속적인 치료 또는 요양이 필요한 경우 체류기간 연장(최장 4년)
- '09. 5. ~ 현재 <외국인환자 전용비자 발급 이후>
 - 외국인환자 전용비자 발급 : 체류자격에 메디컬 코드(M) 부여
 - 의료법상 외국인환자 유치의료기관 또는 유치업자로 등록한 자의 초청으로 의료기관에서 진료 또는 요양을 하기 위해 입국하는 환자 및 간병 등을 위해 동반 입국하는 배우자 또는 가족
 - 체류기간에 따라 구분 발급
 - ▶90일 이하 단기는 C-3-M, 91일 이상 장기는 G-1-M
 - 외국인환자의 사증신청 편의를 위해 사증발급인정서에 의한 사증발급도 허용
 - ▶C-3-M (체류기간 90일), G-1-M(체류기간 6개월)
 - 계속적인 치료 또는 요양이 필요한 경우 체류기간 연장
 - ※ C-3-M 자격으로 입국 후 91일 이상 체류 시는 G-1-M 자격으로 체류자격 변경 및 외국인등록 필요
 - 외국인환자의 국내 체류편의를 제고하기 위해 유치 의료기관 및 유치업자에게 각종 신청 및 수령의 대리 허용

- 초청한 외국인환자의 불법체류자 발생 정도에 따라 초청을 제한, 유치 의료기관 및 유치업자의 관리책임 강화

2) 첨부서류 등

- 해당공관 홈페이지 등 참조

나. 외국인환자 사증발급 및 체류실태 ('09.5.11. ~ '10.3.31.)

□사증발급 현황 : 총 2,077건

○국가별 (23개 국가)

구분	몽골	러시아	중국	베트남	카자흐스탄	기타
건수	1,001	583	306	51	44	92

○공관별 (40개 공관)

구분	몽골(대)	블라디보스톡 (총)	심양(총)	중국(대)	베트남(대)	알마티(분)	기타
건수	1,003	575	170	55	47	44	183

□현 체류자 : 총 15개 국가 233명 (총 입국자 대비 14.4%)

구분	몽골	중국	러시아	일본	베트남	미국	기타
인원	136	43	14	8	7	7	18

□불법체류자 : 총 88명

구분	몽골	중국	네팔	베트남	소말리아	기타
인원	55	15	4	2	1	11
불체율(%)	8.2	5	80	3.7	100	1.9

□평가

○총 입국자 대비 불법체류자 비율이 5.4%로 나타나 외견상 의료관광 제도를 악용한 불법체류자 발생 현상은 심각하지 않은 것으로 분석

○외국인환자 비자 발급 주요 대상국들이 몽골·중국·네팔·베트남 등

불법체류다발국가인 점을 고려, 지속적인 체류실태 모니터링이 필요

4. 향후 추진계획

가. 외국인환자 사후관리강화

- 공관별·사무소별 불법체류자 명단 등 재외공관 및 산하기관 통보
- 불법체류자 발생 유치업체 등의 신청 건에 대한 정밀심사 이행 및 관련 정보 공유

나. 외국인환자 유치기관 등의 책임강화

- 출입국관련 직무교육 실시 ('10. 하반기)
 - 전국 주요 출입국관리사무소 주관 교육 실시, 교육 이수자에 한해 신청대행 허용
- 유관기관 합동점검 및 관리감독 강화 ('10. 하반기)
 - 보건복지부, 문화관광부 등과 합동점검 및 관리부실 유치기관에 대한 제재강화방안 등 협의

제4부 의료분쟁 예방 및 해결 방안

1. 리스크 관리 체크리스트

가. 의료기관 체크리스트

진행일정	예상 위험요인	RISK 예방을 위한 체크사항
① 최초상담	유치업자와 분쟁	○ 유치업자를 통해 환자진료를 요청받게 되는 경우 환자 국적에 따라 *사전 체크사항을 확인한다. * 사전체크사항 - 환자의 국적, 성별, 나이, 병력, 재정상황 등 체크 - 입국비자 필요시 비자유형은 확인하였는가 - 현재 진료현황 자료는 확인하였는가 (환자 국적 병원의 진단서) - 환자 진료 설계 범위는 확정하였는가 (진료 요청 기간, 진료 범위, 지병 여부에 따른 추가 진료사항, 진료기간 재조정 등) - 전염병 예방 접종 및 관련서류 확인하였는가 - 환자가 가입한 보험의 범위는 확인하였는가 (안전사고 발생시 책임범위 확인) - 입국에 필요한 준비사항은 충분히 설명하였는가 - 병원이용승인서(첨부) 항목을 미리 설명하고, 상호 요청사항을 반영 하였는가 - 예상치 못한 추가 병력 발견시 진료기간 연장 및 상호 조정사항 에 대해 확인하였는가 - 사고 발생시 상호 책임범위 및 분쟁해결 방안에 대해 협의하여 진료계약서에 반영하였는가
	통역오류로 인한 환자 연결 안됨	○ 환자가 직접 병원으로 전화 연락이 온 경우 - 환자 국적별 통역 가능한 코디네이터가 있는가 - 코디네이터의 통역내용은 상담일지에 작성 하였는가 - (여러차례 전화를 하게 됨으로) 환자에게 코디 연락처를 정확하 게 전달 하였는가 - 상호 연락처가 변경되었을 경우 올바르게 수정 후 변경사항을 교류 하였는가 - 환자 상담시 안내 매뉴얼은 구비되어있는가 (영어, 일어, 중국어 등 최소 3개 언어 정비 필요)
②	상담내용	- 상담내용에 대해 해당 진료과장, 원무, 보험심사 등 관련부서와

상담내용 분석 및 비용산출	분석 오류	함께 논의 후 분석하여 진료프로세스를 설계 하였는가 - 알레르기 유무, 식사 주의사항 등 환자 특이사항을 올바르게 체크 하였는가 - 과거 병력은 상세히 체크 하였는가 - 현재 복용 중인 약물은 체크 하였는가
	비용 산출 오류	- 세부 진료 내용별 검사항목, 투약 여부(양약/한약), 옵션사항 등 환자의 요청사항을 올바르게 반영하여 전체 치료비용을 산출하였는가 - 예상 진료비용을 에이전시 및 환자에게 미리 설명하였는가 (환자 개인부담이 될 경우 준비가 필요)
	체류자격 및 비자 기간 체크 오류	- 비자가 필요한 국적을 가진 환자의 경우 비자 발급 및 기간은 체크 하였는가 - 만료 7일전일 경우 담당의사 소견서 및 체류연장 신고서는 제출하였는가 - 체류 자격에 따라 조치계획을 수립 하였는가
③ 예약	진료설계 오류	- 진료설계(진료 범위, 절차, 기간, 비용산정 포함) 완료 후 예약 확인서를 발급 하였는가
	대사관과의 분쟁	- 입국비자를 위해 대사관에서 요청한 사전 필요서류를 확인하였는가 - 대사관 요청서류를 충족하여 제출하였는가
④ 입국	진료 불가	○ 체류기간 만료 등 대사관과 사전 체크 미비로 인해 진료가 불가한 경우 발생 ★ 대사관 담당자와 다음 사항을 체크 하였는가 - 필요서류: 현지 의사 진단서, 병원 예약 확인서, 지불능력 확인서(재직증명서, 은행 잔고확인서, 기타 재산증명원) - 입국비자 종류 - 치료연장이 필요한 경우 주치의 소견서 - 만료 7일전인 경우 담당의사 소견서와 체류신고서
⑤ 교통편의 제공	안전사고 발생	- 환자 입국, 출국 시 교통편의 제공이 옵션사항인가 - 공항 픽업은 누가 할 것인가 (업체 위탁 여부 결정) - 업체 위탁할 경우 계약체결은 적정한가 - 안전사고 예방을 위한 주의사항은 충분히 설명하고 계약 체결시 반영하였는가 - 사고보험의 외국인 보장 여부는 확인하였는가 - 사고 발생시 보고체계 및 대응조치는 수립되어 있는가
⑥	진행오류에 따른	- 환자 국적에 맞는 코디네이터가 배정되었는가

도착 및 접수	만족도 하락	- 예약된 진료설계에 따라 진행되었는가 - 만일 예약된 담당 주치의가 진료할 수 없는 상황이 발생한 경우 조치계획은 수립되어 있는가 - 변경사항에 대해 환자에게 충분히 설명하고 동의를 얻었는가 - 변동사항은 코디네이터 상담일지 및 진료차트에 기록되었는가 - 환자 진료상황에 맞는 주치의가 배정되었는가
⑦ 진료, 입원, 검사	의사소통 오류	- 진료행위 설명시 코디네이터가 항상 배정되었으며 올바르게 통역되었는가 - 입원 서약서는 올바르게 통역 후 서명 받았는가 - 병원 생활 안내 및 주의사항에 대해 충분한 설명을 하였으며, 환자가 이를 올바르게 이해하고 있는가
	환자의 건강상태 파악오류	- 진료 전 환자 과거 병력에 대한 모든 사항이 문진 되었는가
	설명 의무 위반	- 검사, 시술, 수술 및 투약 전 중, 후에 주의사항이 환자에게 충분히 설명되었으며, 환자가 이해하고 있는가 - 검사, 시술 및 수술 동의서를 모두 받았는가 - 환자에게 모든 치료 계획에 대해 설명하였으며, 환자가 이를 올바르게 이해하고 있는가
	부작용에 대한 대처	- 진료 과정상 예상 위험요인에 대해 환자가 올바르게 이해할 수 있도록 통역 되었는가 - 예상치 못한 부작용 발생 시에 적절하게 대응하였는가
	비용 정산 오류	- 진료 중간정산이 필요한 경우 미리 체크 하였는가 (3~4일 간격으로 중간 진료비를 공지하고, 7일 간격으로 중간 수납을 하면 효율적임)
⑧ 퇴원 및 사후관리	퇴원서류 발급 지연	- 환자의 국적별로 퇴원시 필요서류를 미리 체크 하였는가 (진단서, 영수증 공통) - 해당 필요서류는 환자 국적에 필요한 언어로 번역 되었는가 - 진단서 발급시 필요한 기간 및 비용은 환자에게 사전에 올바르게 공지하고 발급되었는가 * 한방약의 경우 미리 조제하여 환자 귀국시 동행할 수 있는 조치 하였는가
	주의사항 통역 오류	- 수술 환자의 경우 귀국 후 음식물 섭취, 운동량 등 주의사항은 올바르게 전달하였는가 (통역시 녹음 해두면 사후 분쟁시 증명 용이) - 특히 복용약의 주의사항은 올바르게 전달하였는가 - 최초 진료설계와 달리 추가 시술/수술을 한 경우 변동된 진료내용이 담긴 서류(진단서)를 올바르게 전달하였는가

		- 에이전시와 보험사에 변동사항을 올바르게 전달하고 요청하는 서류를 원활히 제출하였는가
--	--	--

나. 유치업자 체크리스트

내 용	YES	NO	비 고
환자의 국적, 성별, 나이, 병력, 재정상황(지불능력 확인서 - 재직증명서, 은행 잔고확인서, 기타 재산증명원 등) 체크			
입국비자 필요시 비자유형 및 잔여기간 확인			
현재 진료현황 자료의 확인(환자 국적 병원의 진단서 및 처방전 등)			
CKMP의 의료기관처럼 외국인 환자를 치료할 수 있는 준비(해당 언어별 통역이나 코디네이터 여부)가 되어 있는지 확인			
환자 진료 설계 범위의 확정 (진료 요청 기간, 진료 범위, 지병 여부에 따른 추가 진료사항, 진료기간 재조정 등) 및 예약			
환자의 특이사항(알레르기유무, 종교 및 식사에 관한 주의사항, 과거 병력, 현재 복용 중인 약물, 습관, 국적별 주의사항 등)에 관하여 의료기관에 고지			
전염병이 있는 경우 예방 접종 및 관련서류 준비			
환자가 가입한 보험 범위의 확인 및 가입 (안전사고 발생 시 책임범위 확인)			
입국에 필요한 준비사항의 충분한 설명 및 서류 준비(대사관요구서류등)			
병원이용승인서(및 동의서등) 항목을 미리 설명하고, 상호 요청사항을 반영			
환자 입국·출국 시 교통편의 제공의 주체 및 안전사고 대처방안			
예상치 못한 추가 병력 발견 시 진료기간 연장 및 상호 조정사항 확인			
예약된 담당 주치의가 진료할 수 없는 상황이 발생한 경우에 대비한 대책 여부 확인			
의료사고외의 사고 발생 시 상호 책임범위 및 분쟁해결 방안에 대한 협의 및 계약서 반영			
의료사고 발생 시 분쟁해결 방안 및 대책에 대한 설명			
응급상황 발생 시 대응 방안 및 절차에 대한 설명			
최초 진료설계와 달리 추가 시술/수술을 한 경우 그 내용에 대한 충분한 설명과 환자의 동의가 있었는지의 여부 및 변동된 진료내용의 문서화			

2. 외국인환자 의료분쟁 가상사례분석

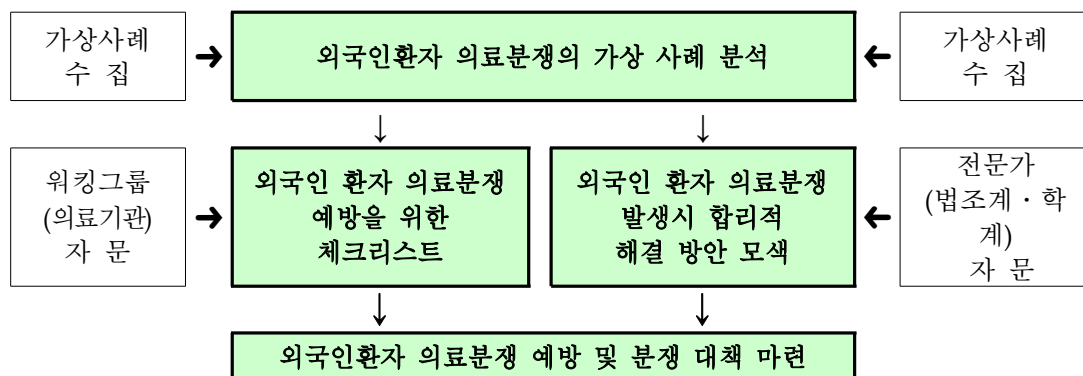
□ 개 요

연구의 목적 및 목표

- 목 적 - 외국인환자 진료시 발생할 수 있는 여러 분쟁 사례들을 찾아보고 개별 사례들을 분석하여 각 사례의 쟁점사항과 합리적인 해결방안을 모색함
- 목 표 - 실제 비슷한 문제가 발생했을 때에 의료인을 비롯한 실무자들이 당황하지 않고 침착하고 현명하게 대응할 수 있도록 함

연구방법

- 사례수집 - 한국국제의료서비스협의회(CKMP) 의료기관들로부터 가상 사례 모집
- 사례분석 - 정부기관·학계·법조계·의료기관 전문가들이 수차례의 회의와 토론을 통해 분석



전문가 패널

대 표	소 속	직 책	성 명
학 계	연세대학교 의과대학	교수	김 소 윤
법 조 계	대외법률사무소	변호사	김 선 욱
의 료 계	대한의사협회	법제이사(MD, 변호사)	박 형 욱
의료기관	신촌 세브란스병원	법무팀장	윤 종 태
	서초 아이누리한의원	원장	황 만 기
	우리들병원	대외협력팀 차장	이 황
	우리들병원	법무팀장	김 은 숙
	청심국제병원	국제협력팀장	강 흥 림
정부기관	보건복지부	사무관	이 강 희
	한국보건산업진흥원	글로벌헬스케어센터 외국인환자마케팅팀장	이 영 호
	한국보건산업진흥원	글로벌헬스케어센터 연구원	홍 승 욱

□ 외국인환자 진료프로세스와 예상 위험요인



1	최 초 상 담	
---	---------	--

1. 최초상담		
1-1. 유치업자와의 분쟁		
1-2. 통역오류로 인한 환자 연결 안됨		

2	상담 내용 분석 및 비용 산출	
---	------------------	--

2. 상담내용 분석 및 비용 산출		
2-1. 상담내용 분석 오류		
2-2. 비용산출 오류		
2-3. 체류자격 및 비자기간 체크 오류		
□ 체류연장기간 도과		
환자는 ○○ 국적을 가진 자로 대한민국에 여행자 신분으로 입국하여 체류 중, 체류 만료 기간인 2009. 4. 10. 까지 대한민국 출입국관리사무소에 체류연장신청을 하는 등의 절차를 취하여야 함에도 이를 연장하지 아니하고 2009.4.5. 15:00 경 대한민국에서 만난 한국인 친구소유의 자동차를 운전하여 가다가 교통사고를 당하여 큰 부상을 입음. 이에 치료를 받기 위하여 응급실에 내원하여 수술 및 입원진료를 받고 의식이 회복되어 가고 있었음. 위 교통사고와 관련하여 의식을 회복한 사실을 안 경찰관이 사고경위에 대하여 조사를 하던 중 불법체류 사실이 확인되어 대한민국 ‘출입국관리법’상 강제 퇴거 대상이 됨		
○ 쟁점		
1. VISA 연장의 책임 소재		
2. 불법체류자의 건강권		
○ 사안의 해결		
1. 여행자가 VISA 연장신청을 미루고 있던 중(아직 기간이 만료되지 않았음) 불의의 사고를 당하여 연장신청기간이 도과함으로써 불법체류자 신분이 된 사안		
2. VISA 연장의 책임은 원칙적으로 본인에게 있으므로, 처음부터 의료관광의 목적으로 내원하지 않은 여행자에 대한 VISA 연장신청에 대한 책임을 의료기관에게 묻는 것은 불합리		
→ 그러나 치료 목적(의료관광)으로 입국한 환자에 대한 VISA연장 신청 책임은 환자 본인·유치업자·의료기관 모두에게 있다고 보여짐		
3. 본 사안에서 환자는 체류 만료기간 전 불의의 사고를 당하였으므로 정상적으로		

VISA 연장신청을 할 수 있을 것이라는 기대가능성이 없음, 따라서 비록 VISA 연장 신청을 미루었다는 도덕적인 비난을 받을 수는 있을지언정 치료가 다 끝날 때까지는 직접적인 강제퇴거는 사실상 힘들어 보임

○ 관련 문제의 대책

1. 불법체류로 인하여 ‘출입국관리법’ 제62조 ①에 의해 강제퇴거명령을 받은 경우라 하더라도 그 집행이 불가능할 때(사안에서처럼 환자의 경우)에는 ‘출입국관리법 시행령’ 제77조 ③에 의해 그 사유서를 사무소장·출장소장·보호소장 등에 제출하여야 한다.
2. 위의 경우 불법체류자인 환자는 ‘출입국관리법’ 제63조 ①에 의거하여 송환이 가능할 때까지 외국인보호실·외국인보호소 또는 기타 법무부장관이 지정하는 장소에서 보호될 수 있다.

* 출입국관리법

제62조 ① 강제퇴거명령서는 출입국관리공무원이 이를 집행한다.

제63조 ① 사무소장·출장소장 또는 외국인보호소장은 강제퇴거명령을 받은 자를 즉시 대한민국밖으로 송환할 수 없는 때에는 송환이 가능할 때까지 그를 외국인보호실·외국인보호소 기타 법무부장관이 지정하는 장소에 보호할 수 있다.

* 출입국관리법 시행령

제77조 ③ 출입국관리공무원 또는 사법경찰관리는 법 제62조의 규정에 의하여 강제퇴거명령서에 의한 송환을 마치거나 그 집행이 불가능하여 집행하지 못한 때에는 강제퇴거명령서에 그 사유를 기재하여 지체없이 사무소장·출장소장 또는 보호소장에게 제출하여야 한다.

3. 치료목적으로 들어온 환자의 소재불명에 대한 책임은 경우에 따라 달리 판단되어질 수 있지만 대개 의료기관 보다는 유치업자에게 더 많이 있다고 보여진다. 왜냐하면 의료기관보다는 유치업자가 환자에 대하여 보다 더 많이 알고 있고 또 의료기관에게 소개를 해준 책임이 있기 때문이다.

3. 예약

3-1. 진료설계오류

□ 환자의 자의적인 치료중단

환자가 수술을 위해 입원하여 첫 날 몇 가지 검사를 시행하고 입원실에 돌아와서는 시설 등 본인이 유치업자로부터 들었던 설명과 차이가 많이 난다며 치료와 검사를 중단 후 귀가하겠다고 함. 이에 의료기관에서는 일부 시행한 검사와 입원비 수납을 요청하였으나, 환자는 이미 유치업자에게 초기 비용으로 상당한 금액을 지불했다면서 유치업자의 계약 위반을 언급하며 지불 거절 후 탈원, 유치업자는 에이전시 비용은 환불 불가능하며 치료에 대한 비용은 의료기관 몫이라고 책임회피

○ 쟁점

1. 환자의 자의적인 치료중단과 진료비 지불
2. 진료비 지불 보증 문제

○ 사안의 해결

1. 유치업자의 계약위반을 이유로 검사비와 입원비 지급을 거절한 환자의 자의적인 치료중단과 이를 둘러싼 진료비 지불의 책임 소재 사안
2. 유치업자와 환자 사이의 계약 내용을 자세히 살펴보아야 보다 정확한 책임소재를 정할 수 있으나, 본 사안에서는 명확하게 드러나지 않음
3. 원칙적으로 의료관광과 관련하여 진료비 지급은 의료기관과 환자사이의 계약에 따라 이루어져야 함, 즉 환자가 유치업자에게 수수료를 포함한 진료비 전액을 선불 지급하는 등의 계약은 환자에게 매우 불리함
4. 결국 진료비 지급에 대한 책임은 환자에게 있고, 유치업자의 계약 위반에 대한 채무불이행 책임은 환자가 직접적으로 유치업자에게 따로 청구해야 함

* 민법 (채무불이행 책임)

제390조 (채무불이행과 손해배상) 채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 채무자의 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다.

5. 본 사안의 경우 환자가 탈원한 상태이므로, 의료기관은 환자의 진료비에 대하여 유치업자에게 책임을 추궁할 수 있을 것으로 보임

○ 관련문제의 대책

1. 예상했던 진료비 보다 많이 청구 될 경우에 환자와의 다툼이 예상된다. 따라서 처음 진료 상담을 할 때부터 예상되는 진료비의 최저 금액과 최대 금액을 제시하고 검사 결과에 따라 추가 시술 및 비용이 청구 될 수 있음을 확실하게 인지시켜야 한다.

3-2. 대사관과의 분쟁

4	입 국	
---	-----	--

4. 입국

4-1. 진료불가

5	교통 편의 제공	
---	----------	--

5. 교통편의 제공

5-1. 안전사고발생

□ 자동문 센서 고장

환자는 운동 중 넘어지는 사고를 당하여 좌측 상완골 골절상을 입게 되었고, 엠블런스를 이용하여 응급실에 내원하여 치료받은 후 퇴원함. 환자는 3주 뒤 본원 정형외과 외래 진료를 위해 병원 건물입구에 들어오던 중 자동출입문의 센서 고장으로 문이 열렸다가 바로 닫히는 바람에 골절상을 입은 팔에 충격이 가해진 사례

○ 쟁점

1. 의료기관내 시설의 오작동으로 환자가 상해를 입은 경우 책임 소재

○ 사안의 해결

1. 의료기관내 시설의 안전 상태는 모두 의료기관 책임
2. 따라서 본 사안의 경우 자동출입문 고장의 책임은 의료기관에 있으므로 환자의 상해에 대하여 병원이 전적으로 책임을 져야 함

□ 병동에서 미끄러져 다친 경우

환자 보호자가 병동 바닥에서 미끄러져 골절상을 당함

○ 쟁점

1. 의료기관내 안전사고에 대한 책임 소재

○ 사안의 해결

1. 의료기관에서 일어난 안전사고에 대하여 누구에게 과실이 있는지 불명확한 사안
2. 본 사안에서 사실관계가 명확하지 않으므로 골정상의 원인이 누구 쪽의 과실인지 알 수 없지만 일반적으로 이러한 경우에 환자 측의 과실이 어느 정도 있다하더라도 '고객만족(CS)'의 차원에서 병원 측이 손해배상을 해줌
3. 그러나 상해의 정도가 매우 큰 경우이거나 피해자가 사망에 이른 경우 또는 인과관계가 복잡해지는 경우에는 각 당사자의 과실 정도와 책임의 범위를 보다 정확히 파악하기 위하여 법적인 절차를 밟는 수도 있음

○ 관련 문제의 대책

1. 입원환자의 경우, 의료기관내에서의 절도사건을 예방하기 위해서는 반드시 병실 출입문에 잠금장치를 설치하도록 하고 '개인 금고' 등을 비치하여 둔다. 외래환자의 경우에 검사 등이 많아 귀중품을 분실할 염려가 있을 때에는 경리부서 등에 맡겨두도록 고지하여야 한다.
2. 일반적으로 유치업자나 의료기관은 미리 환자에게 본국에서 출국하기 전에 귀중품 등을 한국에 가져오지 않도록 주의를 주도록 한다.

6

도착 및 접수

6-. 도착 및 접수

6-1. 진행오류에 따른 만족도 하락

☐ 진료과목에 대한 결정

환자가 내원하여 진료 접수를 하면서 어지러움으로 인한 진료를 받기 위하여 내원하였다는 설명을 수납창구 직원에게 구체적으로 설명하였으나, 수납창구 직원이 통역 상의 실수로 환자의 증상을 잘못 해석하여 '어지러움증 등'은 신경과적 진료를 받아야하는 것을 '머리아픔'으로 알고 이비인후과로 접수하였다가 재차 신경과로 전과하였음

○ 쟁점

1. 환자의 진료과목에 대한 사전합의 중요성
2. 사전합의가 없을 경우 진료과목 결정의 주체

○ 사안의 해결

1. 진료과목에 대하여 환자와 의료기관 사이에 사전합의가 없었고, 따라서 그 결정을 비의료인인 수납직원이 한 사안
2. 진료과목의 결정은 의료인과 환자가 충분히 상담한 이후에 하는 것이 보다 안전하고 현명한 방법. 더군다나 질환의 증상은 어느 한쪽 진료과목의 사유만으로 발생하는 것이라고 단정 지을 수 없으므로 보다 세심한 문진 필요.
3. 진료과목의 결정을 수납직원에게 맡긴 의료기관에게 환자가 겪은 불편함의 책임이 있다고 보여짐.

○ 관련 문제의 대책

1. 진료과목에 대한 결정은 외국인환자(또는 그 대리인-유치업자)가 우리나라 의료기관에 진료상담을 하는 제일 처음부터 신중하게 하도록 한다.
2. 이 때에 비의료인 보다는 반드시 의료진의 상담을 받게 하는 것이 안전하고 현명하다.
3. 진료과목에 대한 결정 없이 내원한 경우에 일반의가 먼저 문진 등을 하고 전문의에게 전의하도록 한다.

7	진료·입원·검사	
---	----------	--

7. 진료·입원·검사

7-1. 의사소통 오류

☐ X-ray 검사실의 미국 국적 한국인

영어이름으로 접수된 ○○국적의 동양인이 검사실 앞에서 기다리고 있었음. 검사자는 영문 이름만 보고 서양인의 얼굴을 가진 환자를 찾았지만 보이지 않았고, 그 다음에 영문 이름으로 호명하였으나 환자 이름을 원래 발음해야 될 이름과 다르게 발음하여 환자가 오랜시간 기다림

○ 쟁점

1. 이름을 잘못 호명한 경우에 책임 소재

○ 사안의 해결

1. 외모가 동양인이라 하더라도 이름은 서양식 이름을 가질 수도 있다는 생각을 해야 한다는 사안

2. 아직까지 우리 사회가 동양인은 동양식 이름, 서양인은 서양식 이름을 사용할 것이라는 고정된 생각을 많이 가지고 있음 따라서 외국인환자 유치사업을 수행하는 담당자들은 보다 개방적인 사고방식으로 임해야 할 것임
3. 이 사안은 단지 서비스의 문제이기 때문에 담당자가 정중하게 예의를 갖추어 환자에게 사과하면 될 것으로 보임

○ 관련 문제의 대책

1. 이와 관련하여 더욱 주의해야 할 점은 환자의 이름이 비슷하여 약이나 주사약 등이 서로 바뀌는 경우가 발생할 수도 있다는 사실이다.
2. 이를 방지하기 위하여 본인을 확인 할 수 있는 tag을 환자의 손목 등에 착용 시킨 다던가 관련서류에 사진을 부착하는 방안 등을 강구해야한다.

□ 약 이름 오역

입원 전에 복용중인 약에 대하여 환자가 이야기 하였으나, 의료진의 약 이름 오역으로 수술 하기 며칠 전에 끊어야하는 ‘혈액순환제’를 수술 직전까지 복용하도록 방치하였음. 입원 후 ‘혈액순환제’ 복용 사실을 확인하고 즉각 복용 중단 시켰으나 그로 인해 수술 날짜 길어짐, 환자는 안내미흡으로 입원기간 길어져 비용 발생하는 것에 대하여 컴플레인

○ 쟁점

1. 수술 전 주의사항에 대한 안내고지의무
2. 복용중인 약에 대한 확인의무

○ 사안의 해결

1. 의료진의 약 이름 오역으로 인하여 불가피하게 수술이 지연되고 입원기간이 길어지게 된 사안.
2. 약 이름을 잘못 이해한 의료진의 과실이 명백하므로 입원이 연장됨으로 인하여 발생한 추가비용은 의료기관에서 부담하여야 할 것으로 보임.

○ 관련 문제의 대책

1. 의료인은 수술하기 전 주의사항에 대하여 환자에게 설명하고 고지하여야 한다.
→ 주의사항을 체크리스트로 만들어 환자와 함께 하나씩 체크해 나가는 것도 한 방법
2. 이 사안에서처럼 약 이름을 환자로부터 직접 듣고 받아 적는 과정에서 오류가 날 수 있으므로(통역 또는 사투리 등에 의한 실수) 반드시 ‘진료의뢰서’와 함께 문서화된 ‘처방전 (또는 복용중인 약물리스트)’을 받아놓아야 한다.

7-2. 환자의 건강상태 파악 오류

□ 자신의 과거 병력을 자세히 밝히지 않음

<사례①> 사각턱교정술 케이스

○○국적의 환자가 사각턱교정술을 받기위하여 시술 전 검사를 받았고 검사결과 이상이 없자 의료진은 전신마취를 하고 수술을 하였음, 그러나 환자는 사전 문진에서 질환이 있다는 사실을 의사에게 고지하지 않았으며 시술 중에 출혈이 심하여 **shock**상태가 발생한 상태에서 과다 출혈로 사망함

<사례②> 설소대 단축증 케이스

음성질환 환자의 음성상태를 정밀하게 검사하기 위해 검사실에 의뢰된 환자를 대상으로 후두기능검사를 시행함(후두기능검사는 모두 4가지의 검사절차로 진행되는데 그 중 환자의 성대를 직접적으로 관찰할 수 있는 스트로보스코피와 초고속성대촬영검사가 있다). 이 두 가지의 검사는 모두 환자가 혀를 내민 상태에서 검사자가 거즈를 사용하여 환자의 혀를 잡고 있고, 내시경이 구강(목젖)까지 들어가 성대를 촬영하는 검사임. 검사 전 환자의 이전 수술경력에 대한 정보가 없어서 환자가 이전에 설소대 단축증으로 설소대 확장술(**frenotomy**) 수술한 경력을 놓쳐 검사 시 환자의 혀에서 출혈, 환자가 이것에 대하여 컴플레인을 제기.

○ 쟁점

1. 환자가 고지하지 않은 사실 때문에 악결과가 발생한 경우 책임소재
2. 환자의 고지여부와 상관없이 의료인에게 주어지는 진료상의 주의의무

○ 사안의 해결

1. 환자는 진료 전 자신의 과거병력과 특이한 체질 등에 대하여 의료인에게 사실대로 고지할 의무가 있음
2. 그러나 환자가 고지하지 않았다 하더라도(또는 사실과 다르게 고지하였더라도) 의료인은 문진표 등을 통하여 꼼꼼하게 의학적으로 환자의 상태에 대하여 체크하여야 함
3. 또 시술 전 검사를 하고 ‘이상이 없다하더라도 부작용이 일어날 수 있다’라는 사실에 대하여 환자에게 정확하게 설명하고 고지한 이후에 동의서를 받고 시술을 하여야 함
4. 사례 ①은 과거 병력을 고지하지 않은 환자가 시술 중 과다 출혈로 사망한 사안
5. 본 사안에서 위 4번과 같은 과정이 있었는지 또 시술 중 의료인의 과실이 있었는지 등의 여부가 명확하게 드러나지는 않지만, 만약 이러한 과정이 생략되었다면 비록 환자가 자신의 과거 병력을 고지하지 않았다 하더라도 의료인의 설명의무 위반으로 의료사고에 대한 책임을 회피하기는 힘들 것으로 보임
6. 환자가 고지하지 않은 사실에 대하여는 환자 측의 과실 또한 명확하므로 손해배상금을 산정할 때에 과실상계를 하여 손해배상액이 감액될 것으로 판단됨
7. 사례 ②는 과거 병력을 고지하지 않았고 검사 중 출혈한 사안
8. 환자가 이전 수술 경력을 고지하지 않았다 하더라도 문진표 등을 통하여 충분히 사실을 파악할 수 있었음에도 불구하고 인지하지 못하였으므로 그에 대한 책임이 있음

9. 사안이 상대적으로 중하지 않으므로 의료인이 환자에게 정중히 사과하고 검사비를 청구하지 않는 수준에서 해결될 것으로 판단됨

○ 관련 문제의 대책

1. 환자의 과거병력이나 특이체질 등에 관하여 환자 본인의 이야기만으로는 정확하게 판단할 수는 없으므로 시술을 하기 전에, 간단한 테스트는 반드시 하도록 하고 예상되는 부작용에 대하여 환자에게 충분히 설명하고 검사할 수 있도록 한다.
2. 문진표를 작성할 때에 환자의 과거 병력이나 수술이력, 특이체질 등을 정확하게 파악할 수 있는 설문조항을 반드시 삽입하도록 한다.

7-3. 설명의무 위반

□ 중복검사에 대한 불만

<사례①> 갑상선 수술환자

환자가 갑상선 수술을 받기 위하여 2차 병원에서 발급받은 진료의뢰서를 가지고 내원한 후 수술을 위해 수반되는 각종 검사를 실시하였음, 후에 환자는 2차 병원에서도 전부 검사하였음에도 불구하고 중복하여 검사를 실시하였다고 불만 제기

<사례②> 내과 방문한 미국인

환자는 한 달 전 다른 병원에서 시행된 혈액 검사 결과지를 내과 의사에게 보여주며 상담을 받고 혈액 검사를 하였음. 수납 시 예상외의 높은 금액이 나오자 검사 하나하나의 진료비 세부 내역서를 요청하였고, 본인이 다른 병원에서도 시행한 검사와 중복되는 것은 하지 않겠다고 의사에게 이야기했는데 왜 검사를 하였냐며 환불을 요청함. 담당 의사는 본원에 처음 등록된 환자의 정확한 상태를 파악하고 기록을 남기기 위하여 검사는 불가피 하였으며, 한 달 동안 환자의 상태가 변할 수 있는 가능성이 있으므로 재검사가 반드시 필요했다는 입장이며, 이러한 상황을 분명히 환자에게 설명하였고 환자도 이에 동의하였기에 처방하였다고 함. 그러나 환자는 그런 적이 없다고 말하며, 미국사고방식으로 도저히 이해할 수 없다고 검사비 환불 요구(이미 검사가 진행되어 환불이 불가능한 데도 자신은 합당한 이유를 가지고 있으므로 반드시 환불받아야 한다고 강력히 주장).

○ 쟁점

1. 중복검사의 정당성 및 효용성

○ 사안의 해결

1. 사례①은 전원이나 전의의 경우에 중복되는 검사가 있음에도 불구하고 환자에게 그 사실을 고지하지 아니하고 검사한 사안
⇒ 의료기술이나 장비, 담당의사의 소견차이 등으로 인하여 중복검사가 발생할 수도 있음, 따라서 이 사실에 대하여 환자에게 충분히 설명한 후 동의를 받아 검사를 시행하는 것이 나중에 진료비 문제로 인한 분쟁 발생할 소지가 줄어들게 됨

⇒ 그러나 비록 MRI, CT 등의 검사를 하지 않는다 하더라도 판독비 정도는 청구할 수 있다고 보여짐

2. 사례②는 중복검사 설명여부에 대한 의사와 환자의 견해 차이 사안

⇒ 설명이 있었는지의 여부에 대하여 양 당사자의 견해가 극명하게 대립하고 있으므로 보다 더 정확한 사실관계 조사가 필요

⇒ 의료인이 환자에게 검사할 내용에 대하여 설명에만 그칠 것이 아니라, 문서로 작성하여 직접 환자의 서명을 받아 놓을 필요가 있음

⇒ 때로는 상담 및 진료 할 때에 환자의 동의를 받고 음성 녹음하는 방법도 생각해 볼 수 있음

□ 환자의 오해

직장내시경 검사를 위하여 내원한 환자가, 직장내시경 직전 시행된 의사의 직장수지 검사에 대하여 본인이 성추행을 당했으며 검사 시 발생한 통증에 적절한 케어를 받지 못했음을 적극적으로 컴플레인함. 당시 검사 진행 중 의사가 영어로 안내를 했으나 알아듣지 못하였으며 직원간 대화를 본인을 모욕하는 대화로 오해함. 이를 위한 해명을 수 차례 하였고 결국 책임자의 설명을 통해 검사진행 내용을 이해함.

○ 쟁점

1. 환자가 오해를 살만한 검사 수행시 사전 설명의 중요성

○ 사안의 해결

1. 의료진의 불충분한 설명 또는 환자의 오해로 인한 불만 표출 사안
2. 모든 검사나 시술 전에 의료진은 환자에게 검사 및 시술의 필요성과 그 과정, 부작용 등에 대하여 환자가 충분히 이해할 수 있도록 설명을 해야 하는 의무가 있음
3. 환자의 이해도 증진 및 (시술에 대한)동의를 받기 위해서, 관련 사항을 문서화하고 설명과 함께 문서를 확인한 후 서명을 받는 것이 필요
4. 본 사안에서는 의료진의 설명을 환자가 완전히 이해하지 못하였다고 할 수 있으므로, 환자가 충분히 이해하였는지 확인하는 절차가 생략되었다고 볼 수 있음
5. 따라서 충분한 설명이 이루어 지지 않은 사실에 대하여 환자에게 정중히 사과를 하고, 이러한 일이 재발되지 않도록 하기 위하여 의료기관은 시술(검사)전 동의서를 자세히 작성하여 비치해 놓아야 할 것임

□ 불충분한 설명 후 채혈

아침에 채혈을 하고 혈액 검사를 하였는데 검사가 부적절하게 되어 다시 채혈이 필요하게 되었음. 언어적 문제로 이러한 상황이 환자에게 제대로 설명이 되지 않은 상태에서 의료진이 다시 채혈을 시도하자, 환자는 왜 채혈을 다시 해야 하는지에 대하여 강하게 불만을 표출함.

○ 쟁점

1. 거듭되는 채혈에 대한 충분한 설명의무

○ 사안의 해결

1. 의료진의 불충분한 설명 또는 환자의 오해로 인한 불만 표출 사안
2. 본 사안에서는 처음 이루어진 혈액검사의 부적절성에 대하여 사실관계가 빈약하므로 누구에게 그 원인이 있는지가 명확하게 드러나지 않음
3. 그러나 의료기관측의 과실로 추정될 수 있을 경우에는 재검사에 대한 비용을 환자에게 청구하지 못하며, 재검사 전에 반드시 환자가 온전히 이해할 수 있도록 상세히 설명을 해야 함
4. 결국 언어적 문제로 의사소통이 원활하지 않았을 경우에는 검사 등의 시술행위를 곧바로 시행하지 말고 시간을 갖고 상호 이해할 수 있을 때까지 기다려야 할 것임

7-4. 부작용에 대한 대처

□ 마취부작용

<사례①> 사랑니발치 케이스

환자가 마취가 덜 된 상태로 (커뮤니케이션도 잘 안 되기에) 통증 호소의 소리를 내자 의료진이 마취가 잘 안된 것으로 판단하여 몇 번의 마취 시도 후에 결국 발치함. 마취가 오래 갈거라 했던 의료진의 예상대로 오랜 시간 마취 상태가 지속됨. 환자는 종종 볼 안쪽이 얼얼하고 무감각과 함께 턱이 빠들어지는 느낌 및 빠근한 현상이 있다고 불만제기.

<사례②> 전신마취 케이스

환자가 전신마취 후 병실로 돌아왔으나 기도의 근육 경련으로 갑자기 호흡곤란 상태에 빠짐. 의료진은 계속해서 심호흡을 하도록 유도하였으나 환자의 상태는 좀처럼 안정되지 않았고 결국 기관절개를 시행하기 위한 준비까지 하였으나 다행히도 안정제 투여 후 호흡이 안정을 되찾음.

<사례③> 구강마취 케이스

스트로보스코피와 초고속성대촬영검사 시도 중 환자의 감각이 예민한 경우에 구역반사(gag reflex)가 나타날 수 있는데, 이러한 경우 보통 첫 번째 검사를 시도해보고 환자가 참기 힘들어 하거나 구역반사가 심할 때에는 구강마취를 실시하게 됨. 이에 따라 이비인후과 전문의가 환자에게 구강마취제를 사용하여 구강마취를 실시하였는데, 환자가 갑자기 일시적인 호흡곤란 증세를 보여 검사가 중단, 이후 환자가 호흡이 안정된 상태로 돌아왔으나 검사 전 마취 가능성과 마취 이후 생길 수 있는 증세에 대하여 충분한 설명이 이뤄지지 않았다면 컴플레인 제기.

○ 쟁점

1. 마취 전 충분한 설명의무 준수 여부

○ 사안의 해결

1. 의료진은 마취 전에 마취 후에 발생할 수 있는 신체 상태에 대하여 환자가 충분히 이해할 수 있도록 설명할 의무가 있음
2. 외국인환자의 특성상 우리나라 사람과는 체질과 유전적 소인이 다르기에 마취제의 dose도 다를 수 있음을 인지하고 그에 따른 준비를 하여야 함,
3. 사례① 은 환자가 처음부터 제대로 마취가 되지 않자 재차 마취술을 거듭하게 되어 결국 과다하게 마취가 된 사안
⇒ 본 사안에서는 마취제의 dose 조절에 실패한 의료진의 과실이 크므로, 환자에게 정중히 사과하고 그 당시의 상황을 충분히 설명하여 의료분쟁으로 비화되지 않도록 노력하여야 함
⇒ 단, 턱이 빠진 후 빠지는 원인은 많은 부분에서 복합적인 영향으로 일어날 수 있으므로(이 갈이가 심한 경우, 턱 관절증, 부정교합, 스트레스, 이를 악무는 습관 등) 환자의 상태가 심각한 경우에 보다 근본적인 원인을 찾아야 할 것임
4. 사례②는 전신마취후 근육경련으로 호흡이 곤란해진 사안
⇒ 본 사안 역시 사실관계가 명확하지 않으므로 환자의 호흡곤란에 대한 원인이 누구한테 있는지 판명하기 힘들
⇒ 마취 전에 마취후에 나타날 수 있는 부작용 등에 대하여 환자가 충분히 이해할 수 있도록 설명하는 것이 제일 중요함
5. 사례③은 의료진의 마취에 대한 사전 설명이 누락된 경우의 책임 소재 사안
⇒ 의료진이 환자에게 검사중 마취가능성과 마취후의 증상에 대하여 사전 설명을 하지 않았으므로 의료진은 설명의무 위반에 따른 책임을 져야 함

□ 부작용

<사례①> 수술후 합병증 케이스

환자가 수술 전 수술에 대한 설명을 듣고 동의서에 사인을 하는 과정에서 담담의사로부터 수술로 인한 모든 부작용에 대하여 설명을 듣지 못하고, 주요 부작용에 대해서만 설명을 듣고 동의서에 사인을 한 후 수술을 받음. 수술이 성공적이었기에 퇴원하여 환자는 본국으로 돌아갔으나 8개월 뒤 수술 부작용을 호소하며 국제클리닉으로 연락 함.

확인 결과, 환자에게 생긴 부작용은 흔치 않은 경우였으나 수술로 인해 생길 수 있는 부작용 중의 하나로, 환자는 이에 대해 보상을 요구하였으나 의사의 자세한 설명을 듣고서 합병증 발병에 대하여 적절한 치료 후 귀국.

<사례②> 상안검시술 케이스

○○에 거주하는 환자가 눈꺼풀 처짐 현상을 개선하기 위하여 상안검성형술을 받고 본국으로 돌아감. 1개월 후에 에이전시를 통하여 시술을 받은 왼쪽 눈의 눈꺼풀이 제대로 감기지 않아 수면을 취하는데 방해가 되고, 한쪽 눈이 올라가 거울을 볼 때마다 스트레스를 받는다고 배상을 요구.

<사례③> 성형 후 감염된 미국 환자

환자는 평소 성형 수술에 관심이 많아 눈과 코 수술을 계획하고 본원에 내원했다가 전문의 상담 후 추가로 턱의 뼈를 깎아 얼굴선을 다듬는 수술까지 시행 후 ○○으로 귀국(귀국 당시까지 얼굴의 부기는 가라앉지 않았고 수술 후 **care**를 끝까지 못한 상태에서 예정된 일정이 있어 일찍 귀국할 수 밖에 없었음). ○○에서 계속 치료를 하였으나 불행히도 턱 수술 후 감염이 생겨 ○○에서 입원 치료를 받았고 일체의 비용을 포함하여 손해배상 소송 제기.

환자는 턱교정술은 예정에 없었으나 본원의 전문의가 강력히 권고하였고 수술 합병증을 설명할 때에 그러한 부작용은 흔치 않으므로 대수롭지 않게 설명했다고 진술. 본원의 전문의는 수술 후 Tx 를 본원에서 끝내고 싶었으나 예정된 일정이 있다며 환자가 귀국하기 강력히 원해 소견서를 첨부하여 항생제 처방하여 지속적인 치료 권유함. 수술 동의서 설명 시 가능한 합병증에 **infection** 이 있었음.

○ 쟁점

1. 시술 행위 전 부작용 등에 대한 의료진의 설명의무 준수 여부

○ 사안의 해결

1. 의료인은 환자에게 시술행위 전, 시술행위와 관련한 모든 부작용에 대하여 설명할 의무가 있으며, 그에 따른 주의점등을 환자가 이해할 수 있도록 설명하여야 함
2. 사례①은 흔치 않은 부작용에 대한 설명의무 위반시 그에 대한 책임소재에 대한 사안
⇒ 의료인은 외국인환자 진료시 우리나라 사람과의 체질·유전적 소인에 대한 차이를 분명히 인지하여야 함
⇒ 수술후 부작용에 대하여는 의료인의 설명의무 준수 여부에 따라 그 책임이 결정 됨
⇒ 본 사안에서 흔치않은 부작용에 대한 의료인의 설명이 결여된 것으로 보이나 사후치료에 대한 확실한 보장 및 양해를 구하여 환자가 의료진의 입장을 수용한 것으로 보임
⇒ 일반적으로 이러한 경우 의료기관에서 환자의 합병증에 대한 치료비 및 입원비 등 일체를 부담할 것으로 판단됨
3. 사례②는 상안검성형술에 따른 수술 후유증 사안
⇒ 사실관계에서 명확하게 드러나지는 않지만 의료진의 과실이 명백하다면 왕복항공료를 포함한 재수술비용 및 위자료 등을 의료기관에서 부담하여야 할 것으로 판단됨
4. 사례③은 성형 후 감염과 관련한 책임소재 사안
⇒ 의료인의 ‘수술 후 합병증’에 대한 설명이 온전하지는 않았으나 포괄적인 infection에

대한 고지가 있었고, 환자 측의 개인적인 이유로 조기귀국을 하였으므로 수술 후 주치의에 의한 care는 기대할 수 없었음

⇒ 본 사안에서 양당사자 모두에게 책임이 있다고 보여지므로 환자는 교통비 등을 부담하고, 의료기관에서 치료비와 입원비 등을 부담하여야 할 것으로 판단됨.

○ 관련 문제에 대한 대책

1. 흔치 않은 부작용이라 하더라도 발생가능성이 있다면 반드시 환자에게 설명하는 것이 현명하다. 이와 관련하여 후에 의료분쟁으로 발전될 가능성을 줄여주기 때문이다.
2. 진료비와 관련하여 ‘수술 후 불만족’에 대한 재수술등 치료비 및 입원비는 고객만족차원에서 의료기관이 부담하고, 교통비는 환자 측의 부담으로 하는 것이 일반적이다.
⇒ 피부·성형 시술과 관련하여 환자의 불만족은 대개 정신과적 문제를 수반하기도 하므로 정신과 치료도 함께 받도록 하는 것이 현명
3. ‘수술 후 합병증’에 대한 진료비 청구 등은 의료인의 설명의무 위반 여부에 따라 개별적으로 검토되어야 한다.

□ 한방치료

<사례①> 침 치료 케이스

목디스크 환자가 침을 맞은 후 갑자기 어지러워하며 쓰러지면서 벽에 머리를 부딪힘

<사례②> 한방약찜질 케이스

허리디스크 환자가 허리에 한방약찜질을 받으면서 (따뜻하고 기분이 좋아지므로) 뜨거운 것을 참고 찜질을 받다가 피부에 수포가 발생함.

<사례③> 봉 침 치료 케이스

봉침을 맞은 환자가 전신 두드러기와 가려움증을 호소함.

<사례④> 한약 복용 후 부작용

환자가 보약을 처방 받아 , 본국에 가서 약을 복용한 이후부터 설사 증세 보임.

○ 쟁점

1. 한방 치료후 부작용에 대한 책임소재

○ 사안의 해결

1. 한방 치료(침· 찜질· 한약 처방 등)를 하는 경우에 후유증이나 환자가 주의해야 할 사항에 대한 사전설명 의무 준수 여부 사안
2. 사례①은 침을 놓기 전에 침을 맞은 후의 증상에 대하여 환자가 충분히 이해할 수 있도록

록 설명하여야 하고, 침을 뱉 이후에 한 시간(환자의 상태에 따라 다름)정도는 침상에 누워 휴식을 취할 수 있도록 안내하여야 함

⇒ ‘침훈’ 또는 ‘훈침’이라는 현상으로 침의 빠른 효과를 몸이 그것을 받아들일 만큼 체력이 뒷받침이 안된 경우에 발생함. 보통 환자가 밥을 안 먹고 왔다거나, 전날 과로를 한 후(특히 시차적응을 잘못하거나 긴 여행으로 피로가 누적된 분들)에 침을 맞은 경우, 또 선천적으로 체력이 약하신 분에게 나타나는데 잠시 안정을 취하면 상태는 말끔히 좋아짐.

⇒ 머리를 부딪혔으므로 의료기관의 부담으로 MRI·CT 등의 검사를 하도록 하고 적합한 치료를 하도록 함

3. 사례②는 찜질을 받기 전에 환자에게 주의할 점 등을 자세히 설명하고, 이상 증세가 나타나면 바로 의료진에게 알리도록 안내하여야 함

⇒ 의료기관의 부담으로 화상치료가 완료될 때까지 적합한 치료를 하도록 함

4. 사례③은 '봉침과민반응' 현상으로, 봉침을 이용하여 염증을 치료하는 과정에서 봉침에 대한 개인적 취약성으로 인하여 과민반응을 보이는 경우에 발생하므로 미리 이 사실에 대하여 환자가 충분히 이해할 수 있도록 안내하여야 함

⇒ 허리 봉침 시술부위에서 시작하여 전신에 봉침 과민성 두드러기와 홍반이 나타나는데, 일반적인 경우에는 봉침 시술부위의 가려움증만 주로 호소, 환자의 봉침과민 반응을 즉각 줄일 수 있도록 협진을 하고 있는 oo의원에 처치(페닐아민, 덱사등의 주사제)를 요청하여 부작용을 최소화 하였고 주사제 처치 후 즉각 호전반응 보임.

5. 사례④는 한약 처방전에 환자의 체질과 상태에 대한 정확한 진단이 필요함을 보여줌, 또 복용 전에 주의사항 등에 대하여 환자가 충분히 이해할 수 있도록 안내하여야 함

⇒ 환자 본인의 체질에 맞는 맞춤처방을 했기 때문에 약에는 문제가 없을 거라고 판단되지만, 환자 본인이 약을 먹은 뒤부터 라고 말하였기 때문에, 전액 환불(외화송금)처리해 주고, 위장을 ‘보’하는 치료약을 서비스로 발송해 줌(원래 처방 받아 간 약은 반송처리).

○ 관련 문제에 대한 대책

1. 안과치료의 경우에 안약을 넣고 1시간 후에 운전하도록 지시한다.
2. 찜질시 화상을 예방하기 위하여 반드시 수건을 덧대어 찜질기가 직접 피부에 닿지 않게 하여야 한다.
3. 한약 처방의 경우에 맛이 어떨다는 것 까지도 설명할 필요가 있다.

7-5. 비용정산오류

□ 진료비지불

<사례①> 결제시스템에 대한 사전 안내 부족

환자가 진료비를 결제하려하였으나 자국(○○)에서만 가능한 체크카드였기에 결제가 불가능하였음. 환자에게 타 카드는 없는 상태였으며, 현금 또한 충분하지 않았음. 타인을 통한 국제 송금도 개인 사정상 어려운 상태여서 고국으로 돌아가 진료비를 직접 송금해주기로 합의를 봄. 담당직원은 환자의 여권과 연락처의 정보를 재확인하였고, ○○도착 후 이를 뒤 국제송금 입금이 확인되었음.

<사례②> 보험회사의 지불 거절

환자가 한국 여행 중 혈압 저하, 배뇨 곤란 등으로 ER에서 검사 후 **R/O Acute renal failure**로 입원, 본원에서 Tx 중 환자가 해외 유명 사보험 회사의 **Member**임을 밝혀 보험회사와 **contact** 후 100% 치료비에 대한 **guarantee paper**를 받고 치료 후 귀국함(환자의 입원당시 급성 신부전이 의심되어 진단을 목적으로 한 여러 가지 검사가 많이 이루어졌었고 결론적으로 환자의 상태가 좋아져 귀국한 것이었음). 그 후 **claim document**를 받은 보험회사에서는 당사의 치료 범위에 속하는 검사와 치료가 아니라며 지불을 거절.(환자의 **condition**과 진단명에 대한 의사 소견서를 보험회사에 중간에 보내 **guarantee paper**를 받았으나 궁극적으로 검사의 대부분이 **negative**로 나왔고 환자 검사 수치와 증상이 좋아져 퇴원했지만 보험회사는 **over treatment**를 주장) 환자에게 다시 **contact** 했으나 환자와는 연락이 되지 않았으며 진료비 1500만원은 미불된 상태.

<사례③> 예상 밖의 치료비

에이전시를 통해 환자에 대한 문의가 들어와 예상 소요 비용과 대략의 입원 기간에 대해 설명했고 접수 담당자가 문의하는 과정에서 환자가 당뇨가 있다는 사실이 누락되었음. 내원하여 치료받던 도중 당뇨병을 앓고 있는 사실이 밝혀졌으며 이로 인해 상처 회복이 매우 더디고 감염 위험이 높아져 더 많은 항생제 등이 사용되어졌고 결국 의료비용이 처음 예상치 보다 높아졌음. 환자는 에이전시에 이미 본인에 대한 정보를 통보했고 그에 관련 된 제반 비용이 포함 된 것으로 알았다며 더 이상 지불할 용의가 없다 하였음(지불 능력 또한 없었음)
에이전시도 환자 의료비용에 대해서는 본인들도 책임이 없다고 함.

○ 쟁점

1. 진료비 지불 보증

○ 사안의 해결

1. 사례①은 결제되지 않는 신용카드 사용 여부에 대한 사안

⇒ 의료기관에서는 외국인환자와 처음 진료 상담을 하고 예약을 할 때부터 진료비 지불 방법에 대하여도 환자에게 충분히 설명을 하여야 함

⇒ 예) 현금지급방법, 통장계좌이체방법, 사용가능한 신용카드의 종류 등

⇒ 본 사안에서는 다행히도 진료비를 받을 수 있었지만, 받지 못할 경우를 대비하여 진료비 추심방법에 관하여 연구가 필요함

2. 사례②는 보험회사의 진료비 지불 보증이 있었지만 보험금이 지급되지 않은 사안

⇒ 진료비의 지급자인 보험회사와 의료기관 사이에 치료의 범위에 대한 설정이 미리 명문화 되어야 함

⇒ 부득이하게 진료의 범위가 넓어지거나 새로운 내용이 추가될 경우에는 시술 전에 보험회사에 연락을 하여 추가적으로 승인을 받아야 함

⇒ 중간에 지속적인 contact을 통해 환자의 상태에 대한 보고와 진료비 지급에 대한 확인을 받아 놓아야 함

3. 사례③은 처음 진료 상담시 누락된 병력 때문에 증가하게 된 치료비의 책임 문제 사안

⇒ 최초 진료 상담시 환자가 없는 상황에서 의료기관과 유치업자가 진료 설계를 하게 되어 환자의 병력과 현재의 상태확인이 정확하게 이루어 지지 않음

⇒ 이를 방지하기 위하여 최초 상담 및 진료설계 할 때에 반드시 환자가 참여하도록 하여야 함

⇒ 또 의료기관에서도 진료상담 등은 간호사 등 의료인만 할 수 있도록 하여야 함

○ 관련 문제의 대책

1. 진료비 지불보증과 관련하여 유치업자는 환자의 경제력(현재의 소득 및 통장 잔고확인 등)을 정확히 파악하여 진료비가 미납 및 체납되지 않도록 진료비 지급 확보를 위한 여러 대책 등을 수립해야 한다.

2. 의료기관에서는 진료비확보를 위해 유치업자나 보험사로부터 지불 보증 각서를 받을 수도 있고 또는 미리 환자로부터 deposit을 받거나, 중간 정산 혹은 신용카드 체크를 통해 실비용에 대한 지급을 확보 할 수도 있다.

⇒ 분할납부의 예) 계약 : 중간 : 퇴원 = 50% : 30% : 20%

3. '의료급여법'에 의하면 진료비와 관련하여 보증금 등을 요구할 수 없도록 하고 있으나 이것은 어디까지나 그 대상이 의료급여환자에 한하는 것이므로, 외국인환자에게 적용될 여지는 없다.

* 의료급여법

제11조의 4 (의료급여기관의 비용 청구에 관한 금지행위) 의료급여기관은 진료 등의 의료급여를 행하기 전에 수급권자에게 본인부담금을 청구하거나 수급권자가 이 법에 따라 부담하여야 하는 비용과 비급여비용 외에 입원보증금 등 다른 명목의 비용을 청구하여서는 아니 된다.

제28조 (의료급여기관의 업무정지 등)

①보건복지부장관은 의료급여기관이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 1년의 범위 내에서 기간을 정하여 의료급여기관의 업무정지를 명할 수 있다.

2. 제11조의4의 규정을 위반하여 본인부담금을 사전에 청구하거나 입원보증금 등 다른 명목의 비용을 청구한 때

4. 간혹 ‘행위별 수가제’로 인한 불편이나 불만을 제기하는 환자들도 있는데 이럴 경우에는 병원의 재량으로 ‘포괄수가제’를 적용할 수도 있다.

8

퇴원 및 사후관리

8. 퇴원 및 사후관리

8-1. 퇴원 서류 발급 지연

□ 투약

<사례①> 해외 약물 배송 사고 -> 생략

약을 해외로 발송했는데, 받지 못했다고 함

○쟁점

1. 약물배송사고에 대한 책임소재

○ 사안의 해결

1. 약물이 환자에게 제대로 전달되지 않았을 때의 의료기관 책임 문제 사안
2. 일반적으로 해외로 약물을 배송할 때에는 ‘국제우편발송(EMS)’을 이용하고 세관서류와 영문처방전, 의사소견서, 약제성분증명서까지 동봉하여야 함.
3. 본 사안은 의료기관에 어떠한 잘못이 없다 하더라도 환자 고객만족 측면에서 다시 약을 보내주는 것이 환자와의 지속적인 유대관계를 위해 좋을 듯

□ 대리처방

<사례②> 대리처방 : 생략

○○국적의 여자 환자가 복부 통증으로 내원하여 상담한 결과, 복부 단층 촬영·복부 초음파·내시경·혈액 검사 등을 권유 받았으나 비용 부담으로 혈액검사와 내시경 검사만 하였음. 검사 결과위염 증상이 있어 3개월치 약만 타서 귀국. 3개월 후 국내에 거주하던 환자의 친언니가 내원하여 약 효능이 좋아 동생(환자)의 건강이 회복되어 가고 있다며 환자의 사정상 국내에 들어오기 어려우니 대리처방을 강력히 원하여 3개월치 약을 더 받아감.

그로부터 다시 3개월 후 ○○에서 E-mail로 “복부 통증이 다시 심해져 ○○ 현지 병원에서 복부 초음파와 단층 촬영을 시행한 결과 간암 진단을 받았으며, 당신들 병원(한국 의료기관)에서 검사 시 암을 발견하지 못해 치료시기를 놓쳤으니 손해배상 소송을 제기 하겠다”며 통고함.

○ 쟁점

1. 대리처방의 허용범위
2. 환자의 사정에 의한 검사 축소와 진단 착오의 연관성

○ 사안의 해결

1. 환자의 사정으로 제대로 된 검사가 이루어 지지 않았고 그로 인해 정확한 진단을 하지 못한 사안
2. 환자 본인의 사정으로 검사를 받지 않았고, 부족한 검사로 암이라는 정확한 병명을 진단하기는 현실적으로 어려움, 따라서 진단오류에 대한 과실이 의료진에게 있다고 볼 수 없음
3. 대리처방과 관련하여 원칙적으로는 허용되지 않으나(의료법 제18조), 약사법 제23조 제4항에 의거한 예외적 허용이 가능한지는 사안별로 보건복지부의 유권해석이 필요함

⇒ 본 사안에서는 대리처방이 원칙적 금지임에도 불구하고 환자의 사정과 편의를 봐주어 의사가 위법함을 감수하고 처방을 해주었는데, 후에 오진(이것도 환자 측의 이유 없는 주장임)이라며 손해배상을 청구하는 것은 지나친 권리 남용임

○ 관련문제에 대한 대책

1. 대리처방이 허용되지 않을 경우에는 한국에서 처방전만 보내고 현지에서 약을 탈 수 있게 한다.
2. 만약 대리처방을 할 수 있다하더라도 진통제중 몰핀 같은 향정신성의약품은 외부로의 유출을 방지하기 위해 환자가 직접 현지에서 탈 수 있도록 한다.

* 대리처방 관련한 견해 대립

① 허용하는 입장

i) 보건복지부 의료자원팀 유권해석(869호, 2007.2.5)

Q. 의료기관이 만성질환자·노약자·영아·거동불편자·도서산간벽지인·기타 사유로 인하여 환자가 직접 의료기관을 내원하지 않고 보호자가 내원하는 경우

에 처방전 교부가 가능한지 여부?

A. 의료법 제17조(구 의료법 제18조)에서 의료업에 종사하고 자신이 진찰 또는 검안한 의사(치과·한의사 포함)가 아니면 진단서·검안서·증명서·처방전을 작성 교부하지 못하도록 규정하고 있고, 만약 이를 위반한 때에는 자격정지 2월의 행정처분을 실시하도록 되어 있음.

그러나 환자가 의료기관에서 의사로부터 최초 진찰을 받고서 만성질환 등으로 동일 상병치료를 위해 반복적인 의약품 투약이 필요로 함에도 불구하고 만성질환자·노약자·영아·거동불편자·도서산간벽지인·기타 특수한 사유로 인하여 환자가 직접 의료기관을 내원하지 못해 보호자가 내원할 경우 처방전 교부가 가능할 것으로 판단됨 다만, 재진환자라 할지라도 동일 상병이 아닌 다른 상병으로 처방할 경우에는 의사의 직접 진찰에 의한 처방전이 교부되어야 함.

* 의료법

제17조 (진단서 등) ①의료업에 종사하고 직접 진찰하거나 검안(檢案)한 의사 [이하 이 항에서는 검안서에 한하여 검시(檢屍)업무를 담당하는 국가기관에 종사하는 의사를 포함한다], 치과의사, 한의사가 아니면 진단서·검안서·증명서 또는 처방전[의사나 치과의사가 「전자서명법」에 따른 전자서명이 기재된 전자문서 형태로 작성한 처방전(이하 "전자처방전"이라 한다)을 포함한다]을 작성하여 환자(환자가 사망한 경우에는 배우자, 직계존비속 또는 배우자의 직계존속을 말한다) 또는 「형사소송법」 제222조 제1항에 따라 검시(檢屍)를 하는 지방검찰청검사(검안서에 한한다)에게 교부하거나 발송(전자처방전에 한한다)하지 못한다.(이하 생략)

제18조 (처방전 작성과 교부) ①의사나 치과의사는 환자에게 의약품을 투여할 필요가 있다고 인정하면 「약사법」에 따라 자신이 직접 의약품을 조제할 수 있는 경우가 아니면 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 처방전을 작성하여 환자에게 내주거나 발송(전자처방전만 해당된다)하여야 한다. <개정 2008.2.29>

ii) 건강보험심사평가원이나 건강보험공단

대리처방의 경우 별도의 병명기호를 부여하여 대리처방 수가를 50% 정도를 인정하고 있다.

② 반대하는 입장

i) 창원지법 판례

– 거동이 불편한 아버지가 전립선비대증을 앓고 있으니 처방해 달라는 말만 듣고 처방전을 작성해 준 뒤 공단에 의료비를 청구한 혐의로 기소된 의사를 비롯하여 대리처방을 한 부산·경남 지역 33개 의원의 의사에게 의료법 위반죄를 적용해 벌금 50만원~150만원을 각각 선고

ii) 박형남 변호사(부산시의사회지 제45권, ‘대리처방은 위법인가?’, pp 32~33, 부산광역시의사회, 2009.7/8.)

– 복지부의 유권해석이나 심평원의 대리 처방 코드 부여는 대리처방시 의료법위반 여부를 판단함에 있어 참고사항에 불과하고 의료법이 우선적으로 적용되며, 판례도 대리처방이 의료법 위반이라는 점을 인정하고 있으므로, 의사의 대리처방은 현행 의료법에 위배된다.

– 의사가 공단이나 심평원에서 부여한 대리처방코드에 따라 의료비를 청구하는 행위는 자신의 의료법 위반 행위에 관한 증거를 그대로 남기는 행위이므로 신중을 요하며, 또한 의사가 대리처방으로 인한 의료법 위반으로 처벌을 받는 경우 의사는 심평원이나 공단, 환자 측에서 의사 대신 책임을 지지 않는다는 점을 유념해야 한다. 따라서 의사는 의료법에 대리처방 규정이 삽입되기까지 대리처방을 하지 않는 것이 바람직하다.

8-2. 주의사항 통역 오류

□ 통역코디네이터 실수

<사례③> 통역코디네이터 실수

○○ 국적 환자 입원 후 내시경 현미경 레이저 수술, 외주로 ○○ 통역 코디네이터가 의료통역함. 퇴원 후 주의사항에 대한 설명 시 ○○어로 통역하는 과정에서 퇴원 약에 복용법 설명 오류가 생겨 1주일 간 약을 과다복용하게 됨. 환자가 위장장애 및 어지럼증 등으로 내원하여 진료 한 결과, 통역이 잘못되어 약복용법에 대한 설명이 잘못되었다는 사실을 알고 강하게 컴플레인.

○ 쟁점

1. 통역코디네이터의 과실을 의료기관의 책임으로 전가할 수 있는지 여부

○ 사례의 해결

1. 통역코디네이터의 과실로 환자에게 약화사고가 발생한 사안

2. 통역코디네이터의 고용주에 따라 그 책임범위가 달라짐

⇒ 통역코디네이터가 외주(유치업자· 보험사 혹은 통역전문회사 등) 소속이고 환자가 있을 때마다 의료기관과의 위임계약으로 일을 하는 경우 : 사용자책임 지지 않는다.

⇒ 통역코디네이터가 의료기관에 직접 고용되어 일을 하는 경우 : 사용자책임

* 민법

제391조 (이행보조자의 고의, 과실)

채무자의 법정대리인이 채무자를 위하여 이행하거나 채무자가 타인을 사용하여 이행하는 경우에는 법정대리인 또는 피용자의 고의나 과실은 채무자의 고의나 과실로 본다.

제756조 (사용자의 배상책임)

① 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 사용자가 피용자의 선임 및 그 사무 감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사용자에게 가름하여 그 사무를 감독하는 자도 전항의 책임이 있다.

③ 전2항의 경우에 사용자 또는 감독자는 피용자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

⇒ 그러나 현실적으로 의료기관에서 도의적 책임 등을 이유로 공동불법행위 책임을 질 가능성이 큼

* 민법

제760조 (공동불법행위자의 책임)

① 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.

② 공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다.

③ 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.

9 기 타 사 례

9. 기타 사례

□ 지시에 따르지 않는 환자

Uncontrolled DM (조절이 잘 되지 않는 심한 당뇨)로 인슐린 주사 치료를 하고 있는 환자이며 퇴역 미군으로 지방에 거주 중, DM foot (혈당 조절이 잘 안되어 말초 혈관 순환에 문제가 생기거나 상처가 생긴 후 발가락 조직이 괴사하는 병)으로 진단받고 본원에 전원 됨.

- 본원 성형외과에 입원 후 내분비내과, 정형외과와 협진 하여 조직 이식 등 수술 받고 연고지 근처의 병원에서 당뇨치료와 소독과 상처 관찰 등 수술 후 care를 하기로 하고 퇴원, 퇴원 당시 환자에게 혈당 조절의 중요성과 수술 후 감염 가능성에 대하여 주지시킴(환자가 당뇨 조절에 있어서도 연고지 지방병원을 불규칙하게 방문하는 등 의사의 권고에 잘 따르지 않은 적이 있어 치료의 필요성에 대하여 강력히 인식시킴).

- 그 후 본원 담당의사와의 진료 예약이 있었으나 오지 않았고, 연락 되지 않음.

- 3달 후 부인으로부터 환자가 하와이 소재 미군 병원에서 다리 절단 수술 받았으며 본원에서 수술 후 infection 가능성에 대하여 제대로 검사를 하지 않았다고 소를 제기하겠다고 화를 내며 전화가 옴.

- 미군 병원에서는 이미 infection 이 있었을 것이라고 하였고, 본원 의료진들은 퇴원 당시 감염 징후가 전혀 없었으며 follow up을 할 수 있었다면 문제가 발생했을 때에 즉각 대응할 수 있었을 텐데 그러한 기회조차도 주지 않은 환자의 잘못이라고 함.

○ 쟁점

1. 의료진의 지시를 따르지 않아 발생한 악결과에 대한 책임소재

○ 사례의 해결

1. 의사의 지시에 따르지 않아 다리까지 절단하게 된 당뇨병환자 사안
2. 본 사안에서는 의료인이 충분히 설명의무를 다한 것으로 판단되어짐 따라서 환자에게 발생한 악결과에 대하여 의료진에게 책임을 추궁하기는 힘들
3. 의료진의 지시에 따르지 않으면 구체적으로 어떠한 결과가 나타나는 지에 대하여 환자에게 자세히 설명하고 설명한 부분에 대하여 문서화 하여 서명을 받아 놓을 필요성이 있음

□ 서비스 불만

<사례①> 진료 절차상의 불만

환자는 대한민국에서 만난 여자 친구의 차량을 이용하여 드라이브를 하던 중 중앙선을 침범한 차량과의 충돌로 인해 큰 부상을 입었고, 이에 본원 응급실로 내원하여 치료를 받음. 보험금 청구를 위해 가해차량이 가입한 보험회사에 제출하고자 진단서 발급 신청을 하였으나, 진료 과에서 한 번에 발급해 주는 것이 아니라 여러 곳을 다니며 발급받아야 하는 절차상 불만

을 제기함.

<사례②> 의료진의 응대표정 불만

외국인환자 인터뷰 중 “진료를 받는 환자의 입장은 늘 걱정이 되게 마련인데 의료진의 표정이 진지하지 않고 환자의 질환에 대하여 가볍게 생각하는 것 같아요. 그렇다고 늘 심각하고 웃지 말라는 것은 아니지만 어떨 때는 나를 무시하는 듯 한 느낌이 들 때도 있어요. 그리고 병원 직원들 중에는 본인이 대답하기 어려우면 다른 사람을 불러주면 될 텐데 아무런 안내도 해주지 않고 그냥 지나칩니다.”

○ 쟁점

1. 의료기관에서 겪게 되는 절차상의 불편함이나 (의료인을 포함한)직원들의 태도가 맘에 들지 않아 제기한 불만에 대한 해결

○ 사례의 해결

1. 사례①은 진단서발급과정이나 절차가 복잡하여 환자가 불만을 제기한 사안
⇒ 본 사안은 비단 외국인에게만 적용되는 문제는 아님
⇒ 따라서 진단서등 각종 증명서를 발급하는 과정을 환자의 입장에서 불편함이 최소화 될 수 있도록(動線을 충분히 고려하여) 단순화·집중화 시킬 필요가 있음
⇒ 특히 외국인환자의 경우 보호자가 없을 수도 있으므로 의료기관에서 많은 부분 편의를 제공하여야 할 것임
2. 사례②는 의료진이나 직원들의 서비스에 대한 불만을 제기한 사안
⇒ 본 사안 역시 외국인에게만 적용되는 문제는 아님
⇒ 의료인과 직원들의 서비스 교육을 강화해야 하며, 언어교육도 정기적으로 편성하여 기초적인 **의사소통이 가능하도록 교육해야 함**
⇒ **가급적이면 의료기관내에서 외국인환자를 케어해줄 전담요원을 배치하는 것이 현명**

□ 시술결과 불만족

<사례①> 얼굴주름제거시술을 받은 일본인 환자

○○ 환자가 본원에서 얼굴 주름제거시술을 받음. 시술 후 일주일 동안 머물면서 치료를 마치고 일본으로 돌아갔으나, 한 달 후 에이전시를 통해 연락이 오기를 자기가 원하는 만큼의 주름제거 시술 효과가 없다고 complain을 제기하며, 환불과 피해 보상을 요구 함.

<사례②> 목소리 치료 후 불만

환자가 목 주변 경련 및 목소리 이상으로 진료 후 재활의학과 외래에서 보톡스 치료를 받고, 이비인후과에서 후두경으로 목 상태를 점검하였음. 시술 및 검사 후 완치가 어렵다는 설명에 대하여 환자도 동의하였으나, 정작 본인의 기대치에 못 미치자 시술 및 진료 후 목소리 치료가 안 되었다고 주장하며 치료에 들인 시간과 진료비에 대하여 환불을 요청함.

○ 쟁점

1. 시술의 완성도에 대한 환자의 판단과 의료인의 판단 차이

○ 사례의 해결

1. 사례①과 ② 모두 시술의 결과에 대하여 환자가 만족하지 못한 사안
2. 성형외과와 치과, 피부과 등 그 치료의 완성도에 대한 판단이 지극히 주관적인 경우에는 시술 전에 반드시 환자의 현재 상태를 사진 등으로 기록하여 놓는 것이 중요, 또 시술 후에도 환자의 상태를 기록하여 놓아 시술 전과 비교할 수 있도록 자료를 정리 해 놓아야 함
3. 환자와 처음 진료상담을 할 때에도 무조건적인 치료의 보장 등 환자를 현혹할 만한 설명을 하기 보다는 어느 정도까지 개선이 되는지 솔직하게 답변을 하고, 할 수 없는 부분은 할 수 없다고 설명해야 함
⇒ 진료상담을 한 이후 실제 진료계약을 할 경우에도 다시 한 번 자세히 설명한 후에 반드시 환자의 자필 서명을 받아놓아야 함
4. 시술후의 예상되는 부작용에 대해서도 충분히 설명을 해야 함

□ 환자가 사망한 경우

○ 쟁점

환자가 의료기관에서 사망한 경우의 행정 처리 절차

○ 해결

<한국>

- 1) 사망 장소 등의 확인
- 2) 경찰의 소환
- 3) 시신 운반 방법 결정
- 4) 관계서류 구비 제출
- 5) 화장 또는 부식 처리
- 6) 귀국

<일본>

- 1) 사망 진단서를 진료 담당의가 작성
- 2) 사망하신 분의 유족, 보호자가 한국에서 화장할 것인지 방부제 처리를 해서 일본에 모실 것인지 결정, 일본 에 화장문화가 있어서 대부분 화장 절차가 더 쉽고 비용도 싸다
- 3) 일본대사관에 유족 분을 모시고(1분) 화장동의서 발급신청서(서식-02)를 작성
(사망진단서, 사망하신 분의 여권, 유족 본인 여권지참)

가. 화장 시

- 일본대사관으로부터 화장동의서를 받음
- 원무팀장 또는 담당자가 장례식업자에게 연락
- 화장할 날짜를 정함. 화장의 경우에는 사후 최소한 24시간이 지나야 함.
- 유골함을 일본에 가져갈 때 공항에서 신청 안 해도 됨
- 화장터 이용 + 장리사 + 유골함 = 100만원~150만원

나. 방부제 처리시 국제 장의사에 연락 (국제 장의사가 필요한 서류, 검사, 공항수송 처리)

- 일본대사관에 가서 방부증명서 발급
- 24시간 지난 뒤에 서울 적십자 병원에 옮겨서 유체를 검사 (1~2일)
- 공항까지 수송
- 비용: 400만원

<러시아>

- 주러시아 대사관에 환자 사망신고
- 사망 진단서 진료 과장이 작성, 번역공증
- 외무부 아포스티유* 신청 발급, 러시아대사관 제출
- 사망하신 분의 유족, 보호자가 한국에서 화장할 것인지 방부제 처리를 해서 러시아에 모실 것인지 결정 한다. 화장 절차가 더 쉽고 비용도 저렴하다.
- 주러대사관에 유족 분을 모시고 (1분) 화장동의서 발급신청서(서식-02)를 작성
(사망진단서, 사망하신 분의 여권, 유족 본인의 여권지참)
- 최종 러시아 영사의 심사 후 2가지 서류 발급(감염여부확인서/시신확인서)
- 최종 이송
⇒ 다른 나라의 경우에도 병원과 대사관, 화장시설 또는 국제방부처리(국제장의사) 업체를 통해 위 국가와 비슷한 절차를 밟아 처리

* 아포스티유 협약

□ 개요

- 명칭 : Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document (외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약)
- 개요 : 협약 가입국들 사이에서 공문서의 국제적 활용을 보다 용이하게 하기 위해, 외국 공관의 영사확인 등 복잡한 인증절차를 폐지하는 대신 공문서 발행국가가 인증하는 내용을 골자로 하는 다자간 협약
- 발효시기 : 1961.10.5 헤이그에서 작성, 1965.1.24 발효
- 가입국현황 : 미·영·불·독·일·중(홍콩, 마카오만 적용) 등 92개국(2007년.5월 현재)
- 우리나라에 대한 발효 : 2007.7.14

□ 절차비교

기존 절차	Apostille 발효 이후 절차
공문서 발급→우리정부확인(필요시)→주한 공관 확인→해당국가에서 공문서로서 인정	공문서발급→외교통상부확인→협약가입국 에서 공문서로서 인정

□ 아포스티유 발급 절차



□ 아포스티유 신청 구비서류

- 아포스티유 발급 신청서
- 아포스티유 확인을 받고자 하는 공문서 또는 공증된 문서
- 대리인에 의한 신청인 경우 대리인의 신분증 사본
- 외무부장관이 행하는 영사관계문서의 확인사무 수수료 규칙에 의한 수수료

□ 아포스티유 발급을 위한 문서의 번역문 필요 여부

- 원칙적으로 아포스티유 발급 대상이 되는 문서는 우리 공문서임. 번역문에 대해서는 국가별로 요구 조건이 다르기 때문에 신청인이 문서를 제출할 국가에서 번역문을 필요로 하는지 필요하다면 어떤 절차를 거쳐야 하는지 정확하게 파악하여 대처하여야 함
- 번역 공증된 문서는 아포스티유 발급대상입니다.

□ 아포스티유 발급을 위한 심사내용

- 협약에 따라, 외교통상부는 발행된 문서의 날인된 관인 또는 서명이 원본과 일치하는지 여부 등을 심사. 이를 위해 외교통상부는 정부기관, 공증인사무소의 협조를 얻어 대조에 사용할 관인과 서명을 등록받아 데이터베이스로 구축하고 있음.

□ 아포스티유 확인 제도에 관한 자세한 정보

- www.0404.go.kr
- 전용 상담전화 (02) 2100-7500 , (02) 3210-0404

외국인환자 유치 관련 법규

○ 의료법

제27조(무면허 의료행위 등 금지) ①의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 보건복지부령으로 정하는 범위에서 의료행위를 할 수 있다. <개정 2008.2.29, 2009.1.30, 2010.1.18>

1. 외국의 의료인 면허를 가진 자로서 일정 기간 국내에 체류하는 자
2. 의과대학, 치과대학, 한의과대학, 의학전문대학원, 치의학전문대학원, 한의학전문대학원, 종합병원 또는 외국 의료원조기관의 의료봉사 또는 연구 및 시범사업을 위하여 의료행위를 하는 자
3. 의학·치과의학·한방의학 또는 간호학을 전공하는 학교의 학생

②의료인이 아니면 의사·치과의사·한의사·조산사 또는 간호사 명칭이나 이와 비슷한 명칭을 사용하지 못한다.

③누구든지 「국민건강보험법」이나 「의료급여법」에 따른 본인부담금을 면제하거나 할인하는 행위, 금품 등을 제공하거나 불특정 다수인에게 교통편의를 제공하는 행위 등 영리를 목적으로 환자를 의료기관이나 의료인에게 소개·알선·유인하는 행위 및 이를 사주하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 할 수 있다. <개정 2009.1.30, 2010.1.18>

1. 환자의 경제적 사정 등을 이유로 개별적으로 관할 시장·군수·구청장의 사전승인을 받아 환자를 유치하는 행위
2. 「국민건강보험법」 제93조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 외국인(보건복지부령으로 정하는 바에 따라 국내에 거주하는 외국인은 제외한다)환자를 유치하기 위한 행위

④ 제3항제2호에도 불구하고 「보험업법」 제2조에 따른 보험회사, 상호회사, 보험설계사, 보험대리점 또는 보험중개사는 외국인환자를 유치하기 위한 행위를 하여서는 아니 된다. <신설 2009.1.30>

제27조의2(외국인환자 유치에 대한 등록 등) ① 제27조제3항제2호에 따라 외국인환자를 유치하고자 하는 의료기관은 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 보건복지부장관에게 등록하여야 한다. <개정 2010.1.18>

② 제1항의 의료기관을 제외하고 제27조제3항제2호에 따른 외국인환자를 유치하고자 하는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 보건복지부장관에게 등록하여야 한다. <개정 2010.1.18>

1. 보건복지부령으로 정하는 보증보험에 가입하였을 것
2. 보건복지부령으로 정하는 규모 이상의 자본금을 보유할 것
3. 그 밖에 외국인환자 유치를 위하여 보건복지부령으로 정하는 사항

③ 제1항에 따라 등록한 의료기관 및 제2항에 따라 등록한 자(이하 "외국인환자 유치업자"라 한다)는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 매년 3월 말까지 전년도 사업실적을 보건복지부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2010.1.18>

④ 보건복지부장관은 의료기관 또는 외국인환자 유치업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 등록을 취소할 수 있다. <개정 2010.1.18>

1. 제1항 또는 제2항에 따른 등록요건을 갖추지 아니한 경우
2. 제27조제3항제2호 외의 자를 유치하는 행위를 한 경우
3. 제63조에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 경우

⑤ 제1항에 따른 의료기관 중 상급종합병원은 보건복지부령으로 정하는 병상 수를 초과하여 외국인환자를 유치하여서는 아니 된다. <개정 2010.1.18>

⑥ 제1항 및 제2항에 따른 등록절차에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정

2010.1.18>

[본조신설 2009.1.30]

제56조(의료광고의 금지 등) ①의료법인·의료기관 또는 의료인이 아닌 자는 의료에 관한 광고를 하지 못한다.

②의료법인·의료기관 또는 의료인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의료광고를 하지 못한다. <개정 2009.1.30>

1. 제53조에 따른 평가를 받지 아니한 신의료기술에 관한 광고
2. 치료효과를 보장하는 등 소비자를 현혹할 우려가 있는 내용의 광고
3. 다른 의료기관·의료인의 기능 또는 진료 방법과 비교하는 내용의 광고
4. 다른 의료법인·의료기관 또는 의료인을 비방하는 내용의 광고
5. 수술 장면 등 직접적인 시술행위를 노출하는 내용의 광고
6. 의료인의 기능, 진료 방법과 관련하여 심각한 부작용 등 중요한 정보를 누락하는 광고
7. 객관적으로 인정되지 아니하거나 근거가 없는 내용을 포함하는 광고
8. 신문, 방송, 잡지 등을 이용하여 기사(記事) 또는 전문가의 의견 형태로 표현되는 광고
9. 제57조에 따른 심의를 받지 아니하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 광고
10. 제27조제3항에 따라 외국인환자를 유치하기 위한 국내광고
11. 그 밖에 의료광고의 내용이 국민건강에 중대한 위해를 발생하게 하거나 발생하게 할 우려가 있는 것으로서 대통령령으로 정하는 내용의 광고

③의료법인·의료기관 또는 의료인은 거짓이나 과장된 내용의 의료광고를 하지 못한다.

④의료광고는 다음 각 호의 방법으로는 하지 못한다.

1. 「방송법」 제2조제1호의 방송
2. 그 밖에 국민의 보건과 건전한 의료경쟁의 질서를 유지하기 위하여 제한할 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 방법

⑤제1항이나 제2항에 따라 금지되는 의료광고의 구체적인 기준 등 의료광고에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 의료법 시행령

제42조(업무의 위탁) ① 법 제86조제2항에 따라 보건복지부장관은 법 제25조에 따른 신고 업무를 각 중앙회장에게 위탁한다. <개정 2010.3.15>

② 법 제86조제2항에 따라 보건복지부장관은 다음 각 호의 업무를 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원에 위탁한다. <개정 2010.3.15>

1. 법 제27조의2제1항 및 제2항에 따른 등록 업무(등록 요건 검토는 포함하되, 등록 여부 결정 및 등록증 발행·재발행은 제외한다)
2. 법 제27조의2제3항에 따른 사업실적 보고 업무

③ 제1항 및 제2항에 따라 업무를 위탁받은 각 중앙회장 및 한국보건산업진흥원은 위탁받은 업무의 처리 내용을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2010.3.15>

[전문개정 2009.4.20]

○ 의료법 시행규칙

제19조의2(유치행위를 할 수 없는 국내 거주 외국인의 범위) 법 제27조제3항제2호에 따라 외국인환자를 유치할 수 있는 대상에서 제외되는 국내에 거주하는 외국인은 「국민건강보험법」 제93조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 국내에 거주하는 외국인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인을 말한다.

1. 「출입국관리법」 제31조에 따라 외국인등록을 한 사람[「출입국관리법 시행령」 제12조 및 별표 1에 따른 기타(G-1)의 체류자격을 가진 사람은 제외한다]
 2. 「재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포
- [본조신설 2009.4.29]

제19조의3(외국인환자 유치 의료기관의 등록요건) 외국인환자를 유치하려는 의료기관은 법 제27조의2제1항에 따라 외국인환자를 유치하려는 진료과목별로 법 제77조에 따른 전문의 1명 이상을 두어야 한다. 다만, 진료과목이 「전문의를 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정」 제3조에 따른 전문과목이 아닌 경우에는 그러하지 아니하다.

[본조신설 2009.4.29]

제19조의4(외국인환자 유치업자의 등록요건) ① 법 제27조의2제2항제1호에서 "보건복지부령으로 정하는 보증보험에 가입하였을 것"이란 다음 각 호를 모두 충족하는 보증보험에 가입한 경우를 말한다. 다만, 그 보증보험에 가입한 후 외국인환자에게 입힌 손해를 배상하여 보험계약이 해지된 경우에는 1개월 이내에 다시 가입하여야 한다. <개정 2010.3.19>

1. 외국인환자를 유치하는 과정에서 고의 또는 과실로 외국인환자에게 입힌 손해에 대한 배상책임을 보장하는 보증보험일 것
2. 해당 보험회사가 「보험업법」 제4조제1항제2호라목의 보증보험에 대하여 금융위원회의 허가를 받은 보험회사일 것
3. 보험금액이 1억원 이상이고, 보험기간을 1년 이상으로 하는 보증보험일 것

② 법 제27조의2제2항제2호에서 "보건복지부령으로 정하는 규모"란 1억원을 말한다. <개정 2010.3.19>

③ 법 제27조의2제2항제3호에서 "보건복지부령으로 정하는 사항"이란 국내에 설치한 사무소를 말한다. <개정 2010.3.19>

[본조신설 2009.4.29]

제19조의5(상급종합병원의 외국인환자 유치 제한) 법 제27조의2제5항에서 "보건복지부령으로 정하는 병상수"란 법 제3조의4에 따라 지정된 상급종합병원(2010년 1월 31일 전에는 「국민건강보험법」 제40조제2항에 따라 종합전문요양기관으로 인정된 의료기관을 말한다)의 병상수의 100분의 5를 말한다. <개정 2010.3.19>

[본조신설 2009.4.29]

제19조의6(외국인환자 유치를 위한 등록절차) ① 외국인환자를 유치하려는 의료기관은 법 제27조의2제6항 및 영 제42조제2항제1호에 따라 별지 제9호의4서식의 등록신청서(전자문서로 된 등록신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원(이하 "한국보건산업진흥원"이라 한다)에 제출하여야 한다. <개정 2010.1.29>

1. 별지 제15호서식의 의료기관 개설신고증명서 사본 또는 별지 제17호서식의 의료기관 개설허가증 사본
2. 사업계획서
3. 제19조의3에 따른 진료과목별 전문의의 명단 및 자격증 사본

② 제1항에 따른 의료기관 외에 외국인환자를 유치하려는 자는 법 제27조의2제6항 및 영 제42조제2항제1호에 따라 별지 제9호의5서식의 등록신청서(전자문서로 된 등록신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 한국보건산업진흥원에 제출하여야 한다. <개정 2010.1.29>

1. 정관(법인인 경우만 해당한다)

2. 사업계획서

3. 제19조의4제1항에 따른 보증보험에 가입하였음을 증명하는 서류

4. 제19조의4제2항에 따른 규모 이상의 자본금을 보유하고 있음을 증명하는 서류

5. 제19조의4제3항에 따른 사무실에 대한 소유권이나 사용권이 있음을 증명하는 서류

③ 한국보건산업진흥원은 제1항 또는 제2항에 따른 신청 내용이 법 제27조의2제1항 또는 제2항에 따른 등록요건에 적합한지 여부를 검토하여 그 검토 내용을 보건복지부장관에게 알려야 한다. <개정 2010.3.19>

④ 보건복지부장관은 제3항에 따른 검토 내용을 확인한 결과 법 제27조의2제1항 또는 제2항에 따른 등록요건에 적합한 경우 제1항의 신청인에게는 별지 제9호의6서식에 따른 외국인환자 유치 의료기관 등록증을, 제2항의 신청인에게는 별지 제9호의7서식에 따른 외국인환자 유치업자 등록증을 각각 발행하여야 한다. <개정 2010.1.29, 2010.3.19>

⑤ 한국보건산업진흥원은 제4항에 따라 발행된 등록증을 제1항 및 제2항에 따른 신청인에게 내주어야 한다.

[본조신설 2009.4.29]

제19조의7(외국인환자 유치 관련 등록증의 재발급) ① 법 제27조의2제1항 및 제2항에 따라 등록한 의료기관 및 외국인환자 유치업자는 제19조의6에 따라 발급받은 등록증을 잃어버렸거나 헐어서 못쓰게 된 경우에는 별지 제9호의8서식에 따른 신청서에 각 등록증(헐어서 못쓰게 된 경우만 해당한다)을 첨부하여 한국보건산업진흥원에 제출하여야 한다. <개정 2010.1.29>

② 한국보건산업진흥원은 제1항에 따른 신청 내용을 보건복지부장관에게 알려야 한다. <개정 2010.3.19>

[본조신설 2009.4.29]

제19조의8(외국인환자 유치 관련 등록 업무 처리 보고) 한국보건산업진흥원은 영 제42조제3항에 따라 제19조의6 및 제19조의7에 따른 등록 업무의 처리 내용을 매분기별로 보건복지부장관에게 보고하여야 한다.

<개정 2010.3.19>

[본조신설 2009.4.29]

제19조의9(외국인환자 유치 사업실적 보고) ① 법 제27조의2제1항 및 제2항에 따라 등록한 의료기관 및 외국인환자 유치업자는 법 제27조의2제3항 및 영 제42조제2항제2호에 따라 전년도 사업실적(외국인환자의 성명은 제외한다)을 다음 각 호의 구분에 따라 매년 3월 31일까지 한국보건산업진흥원에 보고하여야 한다.

1. 의료기관의 경우 다음 각 목에 관한 사항

가. 외국인환자의 국적, 성별 및 출생년도

나. 외국인환자의 진료과목, 입원기간, 주상병명 및 외래 방문일수

2. 외국인환자 유치업자의 경우 다음 각 목에 관한 사항

가. 외국인환자의 국적, 성별 및 출생년도

나. 외국인환자의 방문 의료기관, 진료과목, 입원기간 및 외래 방문일수

다. 외국인환자의 입국일 및 출국일

② 한국보건산업진흥원은 영 제42조제3항에 따라 제1항에 따른 보고 내용과 결과를 매년 4월 30일까지 보건복지부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2010.3.19>

[본조신설 2009.4.29]

○출입국관리법

제25조(체류기간연장허가) 외국인이 체류기간을 초과하여 계속 체류하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 체류기간이 끝나기 전에 법무부장관의 체류기간 연장허가를 받아야 한다.[전문개정 2010.5.14] 제31조(외국인등록) ① 외국인이 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 입국한 날부터 90일 이내에 그의 체류지를 관할하는 사무소장이나 출장소장에게 외국인등록을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 주한외국공관(대사관과 영사관을 포함한다)과 국제기구의 직원 및 그의 가족 2. 대한민국정부와의 협정에 따라 외교관 또는 영사와 유사한 특권 및 면제를 누리는 사람과 그의 가족 3. 대한민국정부가 초청한 사람 등으로서 법무부령으로 정하는 사람 ② 제23조에 따라 체류자격을 받는 사람으로서 그 날부터 90일을 초과하여 체류하게 되는 사람은 제1항에도 불구하고 체류자격을 받는 때에 외국인등록을 하여야 한다. ③ 제24조에 따라 체류자격 변경허가를 받는 사람으로서 입국한 날부터 90일을 초과하여 체류하게 되는 사람은 제1항에도 불구하고 체류자격 변경허가를 받는 때에 외국인등록을 하여야 한다. ④ 사무소장이나 출장소장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 외국인등록을 한 사람에게는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 개인별로 고유한 등록번호(이하 "외국인등록번호"라 한다)를 부여하여야 한다.[전문개정 2010.5.14] 제59조(심사후의 절차) ① 사무소장·출장소장 또는 외국인보호소장은 심사 결과 용의자가 제46조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다고 인정하면 지체 없이 용의자에게 그 뜻을 알려야 하고, 용의자가 보호되어 있으면 즉시 보호를 해제하여야 한다. ② 사무소장·출장소장 또는 외국인보호소장은 심사 결과 용의자가 제46조제1항 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정되면 강제퇴거명령을 할 수 있다. ③ 사무소장·출장소장 또는 외국인보호소장은 제2항에 따라 강제퇴거명령을 하는 때에는 강제퇴거명령서를 용의자에게 발급하여야 한다. ④ 사무소장·출장소장 또는 외국인보호소장은 강제퇴거명령서를 발급하는 경우 법무부장관에게 이의신청을 할 수 있다는 사실을 용의자에게 알려야 한다. [전문개정 2010.5.14]

○ 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률

제6조(국내거소신고) ① 재외국민과 재외동포체류자격으로 입국한 외국국적동포는 이 법을 적용받기 위하여 필요하면 대한민국 안에 거소(居所)를 정하여 그 거소를 관할하는 출입국관리사무소장(이하 "사무소장"이라 한다) 또는 출입국관리사무소출장소장(이하 "출장소장"이라 한다)에게 국내거소신고를 할 수 있다. ② 제1항에 따라 신고한 국내거소를 이전한 때에는 14일 이내에 그 사실을 신거소(新居所)가 소재한 시·군·구의 장이나 신거소를 관할하는 사무소장·출장소장에게 신고하여야 한다. ③ 제2항에 따라 거소이전 신고를 받은 사무소장이나 출장소장은 신거소가 소재한 시·군·구의 장에게, 시·군·구의 장은 신거소를 관할하는 사무소장이나 출장소장에게 각각 이를 통보하여야 한다. ④ 국내거소신고서의 기재 사항, 첨부 서류, 그 밖에 신고의 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2008.3.14] 제10조(출입국과 체류) ① 재외동포체류자격에 따른 체류기간은 최장 3년까지로 한다. <개정 2008.12.19> ② 법무부장관은 제1항에 따른 체류기간을 초과하여 국내에 계속 체류하려는 외국국적동포에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 체류기간 연장허가를 할 수 있다. 다만, 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
--

- ③ 국내거소신고를 한 외국국적동포가 체류기간 내에 출국하였다가 재입국하는 경우에는 「출입국관리법」 제30조에 따른 재입국허가가 필요하지 아니하다.
- ④ 대한민국 안의 거소를 신고하거나 그 이전신고(이전신고)를 한 외국국적동포에 대하여는 「출입국관리법」 제31조에 따른 외국인등록과 같은 법 제36조에 따른 체류지변경신고를 한 것으로 본다.
- ⑤ 재외동포체류자격을 부여받은 외국국적동포의 취업이나 그 밖의 경제활동은 사회질서 또는 경제안정을 해치지 아니하는 범위에서 자유롭게 허용된다.

[전문개정 2008.3.14]

○ 국민건강보험법

제5조(적용대상등) ①국내에 거주하는 국민으로서 다음 각호의 1에 해당하는 자외의 자는 이 법에 의한 건강보험(이하 "건강보험"이라 한다)의 가입자(이하 "가입자"라 한다) 또는 피부양자가 된다. <개정 2001.5.24, 2006.10.4>

1. 「의료급여법」에 따라 의료급여를 받는 자(이하 "수급권자"라 한다)
2. 「독립유공자예우에 관한 법률」 및 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의하여 의료보호를 받는 자(이하 "유공자등의료보호대상자"라 한다). 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 자는 그러하지 아니하다.

가. 유공자등의료보호대상자중 건강보험의 적용을 보험자에게 신청한 자

나. 건강보험의 적용을 받고 있던 자가 유공자등의료보호대상자가 된 경우로서 보험자에게 건강보험의 적용배제신청을 하지 아니한 자

②제1항의 피부양자는 다음 각호의 1에 해당하는 자중 직장가입자에 의하여 주로 생계를 유지하는 자로서 보수 또는 소득이 없는 자를 말한다.

1. 직장가입자의 배우자
2. 직장가입자의 직계존속(배우자의 직계존속을 포함한다)
3. 직장가입자의 직계비속(배우자의 직계비속을 포함한다) 및 그 배우자
4. 직장가입자의 형제·자매

③제2항의 규정에 의한 피부양자 자격의 인정기준, 취득·상실시기 기타 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2008.2.29>

제6조(가입자의 종류) ①가입자는 직장가입자 및 지역가입자로 구분한다.

②모든 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원 및 교직원은 직장가입자가 된다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 자를 제외한다. <개정 2000.12.29, 2004.1.29, 2006.10.4>

1. 1월 미만의 기간동안 고용되는 일용근로자
2. 「병역법」의 규정에 의한 현역병(지원에 의하지 아니하고 임용된 하사를 포함한다), 전환복무된 사람 및 무관후보생
3. 선거에 의하여 취임하는 공무원으로서 매월 보수 또는 이에 준하는 급료를 받지 아니하는 자
4. 기타 사업장의 특성, 고용형태 및 사업의 종류 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원 및 교직원

③지역가입자는 가입자중 직장가입자와 그 피부양자를 제외한 자를 말한다.

④제2항제4호의 규정에 의한 근로자 및 사용자는 대통령령이 정하는 절차에 따라 직장가입자가 되거나 탈퇴할 수 있다. <신설 2000.12.29>

제93조(외국인등에 대한 특례) ①정부는 외국정부가 사용자인 사업장의 근로자의 건강보험에 관하여 외국정부와의 합의에 의하여 이를 따로 정할 수 있다.

②국내에 체류하고 있는 재외국민 또는 외국인으로서 대통령령이 정하는 사람은 제5조의 규정에 불구하고 이 법의 적용을 받는 가입자 또는 피부양자가 된다. <개정 2005.7.13>

○ 국민건강보험법 시행령

제64조(외국인등 가입자) ①법 제93조제2항의 규정에 의하여 직장가입자가 되는 재외국민 또는 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 직장가입자 적용사업장에 근무하는 자와 공무원·교직원으로 임용 또는 채용된 자로 한다. 다만, 법 제6조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 제외한다. 1. 「출입국관리법」 제31조의 규정에 의하여 외국인등록을 한 자 2. 재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률」 제6조의 규정에 의하여 국내거소신고를 한 자 ②제1항에 해당하지 아니하고 국내에 3개월 이상 거주한 재외국민 또는 외국인(국내에 3개월 이상 거주하지 아니한 재외국민 또는 외국인이라도 유학·취업 등의 사유로 3개월 이상 거주할 것이 명백한 자를 포함한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 본인의 신청에 따라 이 법의 적용을 받는 지역가입자가 된다. <개정 2008.2.29, 2008.12.17, 2010.3.15> 1. 「출입국관리법」 제31조에 따라 외국인등록을 한 자로서 보건복지부령으로 정하는 체류자격이 있는 자 2. 제1항제2호에 해당하는 자 ③제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이 법에 의한 가입자가 될 수 없다. 1. 「출입국관리법」 제25조 및 「재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률」 제10조제2항의 규정에 의하여 체류기간연장허가를 받지 아니하고 체류하는 자 2. 「출입국관리법」 제59조제2항의 규정에 의하여 강제퇴거명령서가 발부된 자 ④공단은 제1항에 불구하고 재외국민 또는 외국인이 국내에 근무하는 기간 동안 외국의 법령, 외국의 보험 또는 사용자와의 계약 등에 따라 법 제39조에 따른 요양급여에 상당하는 의료보장을 받을 수 있는 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 가입자에서 제외할 수 있다. <신설 2007.7.25, 2008.2.29, 2010.3.15> ⑤제1항부터 제4항까지에 규정된 것 외에 신청 절차 및 가입자의 제외 신청 절차 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <신설 2007.7.25, 2008.2.29, 2010.3.15> [전문개정 2005.12.28]
--

의료기관 가이드라인

의료기관 가이드라인은 ‘한국국제의료협회(KIMA)’회원 의료기관들 스스로 환자의 이익을 최우선으로 하여 환자 중심의 의료서비스 환경을 조성하고 안전하면서도 수준 높은 의료서비스를 제공하자는 취지에서 제작되었습니다. 따라서 이 가이드라인은 의료기관이 준수하여야 할 최소한의 지침이기에 국내법에 규정된 조항 이외에는 어떠한 법적 효력을 지니지 않음을 알려드립니다.

1. 의료기관은 항상 환자의 최선의 이익을 위해 행동할 윤리적 의무와 직업적 책임을 가지며 국적·종교·인종·성적 편견으로 환자를 차별하지 않습니다.
2. 의료기관은 유치업자나 환자와 계약할 때에 ‘보건복지부의 외국인환자 유치를 인가받은 등록된 기관’임을 알립니다.
3. 의료기관은 유치업자와 계약할 때에 ‘보건복지부의 외국인환자 유치를 인가받은 등록된 유치업자’인지의 여부를 확인합니다.
4. 의료기관은 홈페이지 등을 통하여 환자와 유치업자가 열람할 수 있도록 의료기관 인증, 임상데이터 및 의사의 면허나 임상경험에 대한 정보를 제공합니다.
5. 의료기관은 환자에게 진료절차·분쟁해결제도·개인정보보호 및 환자의 권리와 의무 등에 대하여 환자가 충분히 이해 할 수 있도록 설명합니다.
6. 의료기관은 환자의 개별 진료행위에 대한 진료비, 투약비·옵션사항 및 예상외의 추가시술에 따른 추가비용 등 총 예상 진료비를 환자에게 사전에 알립니다.
7. 의료기관은 환자가 지참한 서류(비자, 진단서, 전원의뢰서, 처방전, 보험증서 등)들을 미리 검토하여 진료행위가 원활하게 이루어 질 수 있도록 준비합니다.
8. 의료기관은 환자가 대한민국에 입국할 경우에 각종 전염병의 국내 유입을 예방하기 위하여 해당 사항이 있는지 확인하고 그 예방조치(예-대한민국 검역법기준 : 예방접종증명서 및 검역증 제출)를 하도록 유치업자 및 환자에게 요구 할 수 있습니다.

9. 의료기관과 환자, 의료기관과 유치업자 사이의 계약과 관련하여, 계약의 체결 및 그 이행에 관한 모든 사항에 관하여 각 당사자는 (대한민국 민법 제2조) ‘신의성실의 원칙’에 입각하여 각자의 업무에 최선을 다합니다.
10. 의료기관은 외국인환자의 진료상담 및 진료행위를 도와줄 전담 코디네이터나 통역사를 배치합니다.
11. 의료기관은 진단 및 치료 과정에 환자의 의사와 선택을 반영함으로써 환자의 인격과 자기결정권을 존중합니다.
12. 의료기관은 직무상 알게 된 환자의 비밀을 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 치료의 목적 외에 누설하지 않습니다.
13. 환자와 의료기관 사이에 의료분쟁이 발생한 경우 양 당사자는 분쟁이 원만히 해결 될 수 있도록 상호협조를 하여야 하며, 의료기관은 ‘한국보건산업진흥원(Medical Call Center)’에 사고의 접수 및 상담을 요청 할 수 있습니다.
14. 의료기관의 종사자들은 의료분쟁에 대비한 관련교육을 이수하여야 하며 분쟁해결 매뉴얼을 숙지합니다.
15. 의료기관은 의료분쟁의 해결과 관련하여 배상 자원(손해배상보험 등)을 별도로 마련합니다.
16. 의료기관은 환자에게 응급상황이 발생할 경우를 대비하여 이에 대한 대응 체계 및 방법 등에 관하여 미리 환자에게 설명하고, 환자의 응급상황 접수를 받은 경우 신속하게 대처합니다.
17. 의료기관은 외국인 환자가 대한민국에서 치료를 마치고 본국으로 귀국할 경우에 환자에게 적절한 건강관리 방법에 대해서 조언 합니다.

유치업자 가이드라인

유치업자 가이드라인은 환자의 이익을 최우선의 목표로 하며 건전한 유치사업을 증진 하고 안전한 의료서비스를 제공하기 위한 목적에서 제작되었습니다. 따라서 이 가이드라인은 외국인환자를 국내 의료기관에 소개하는 경우에 유치업자가 준수하여야 할 최소한의 지침이기에 국내법에 규정된 조항 이외에는 어떠한 법적인 효력을 지니지 않음을 알려드립니다.

1. 유치업자는 언제나 환자의 최선의 이익을 위해 행동할 윤리적 의무와 직업적 책임을 가지며 국적·종교·인종·성적 편견으로 환자를 차별하지 않습니다.
2. 유치업자는 의료기관이나 환자와 계약할 때에 ‘보건복지부의 외국인환자 유치를 인가 받은 등록된 유치업자’임을 알립니다.
3. 유치업자는 의료기관과 계약할 때에 ‘보건복지부의 외국인환자 유치를 인가받은 등록된 의료기관’인지의 여부를 확인 합니다.
4. 유치업자는 의료기관으로부터 의료기관 인증, 임상데이터 및 의사의 면허나 임상경험에 대한 정보를 제공받아 환자에게 안내합니다.
5. 유치업자는 환자가 진료를 받아야 할 의료기관과 의료인이 정해지면 해당 의료기관의 진료절차 · 분쟁해결제도 · 개인정보보호 및 의료진의 전문성과 환자의 권리· 의무 등에 대하여 충분히 이해한 후 환자에게 그 사실을 설명합니다.
6. 유치업자는 의료기관에 문의하여 환자의 개별 진료행위에 대한 진료비, 투약비·옵션사항 및 예상외의 추가시술에 따른 추가비용 등 총 예상 진료비를 환자에게 안내합니다.
7. 유치업자는 원활한 진료행위를 위해 환자가 대한민국에 입국할 때에 관련 서류(비자, 진단서, 전원의뢰서, 국내 의료기관의 예약 입증자료, 보험증서 등)들을 빠짐없이 준비할 수 있도록 확인합니다.

8. 유치업자는 환자가 대한민국에 입국할 경우에 관련법에 의한 각종 전염병의 국내 유입을 예방하기 위하여 예방 접종을 하도록 안내하고 확인서 (예-대한민국 검역법기준 : 예방접종증명서 및 검역증 제출)를 제출하도록 하며 그 사실을 해당 의료기관 및 관계기관에 알립니다.
9. 환자와 유치업자, 의료기관과 유치업자 사이의 계약과 관련하여, 계약의 체결 및 그 이행에 관한 모든 사항에 관하여 각 당사자는 (대한민국 민법 제2조) ‘신의성실의 원칙’에 입각하여 각자의 업무에 최선을 다합니다.
10. 유치업자는 직무상 알게 된 환자의 비밀을 치료의 목적 외에 누설하지 않습니다.
11. 환자와 의료기관 사이에 의료분쟁이 발생한 경우 유치업자는 양 당사자 간의 분쟁이 원만히 해결 될 수 있도록 협조를 하며, 환자를 대리하여 ‘한국보건산업진흥원 (Medical Call Center)’에 사고의 접수 및 상담을 요청 할 수 있습니다.
12. 유치업자는 환자에게 응급상황이 발생할 경우를 대비하여 해당 의료기관의 대응 방법 및 적절한 대응책 등에 관하여 충분히 인지하고 이를 환자에게 설명하여야 하며 ‘한국보건산업진흥원(Medical Call:15777-129, www.medicalkorea.or.kr)’에 도움을 요청할 수 있습니다.
13. 유치업자는 외국인 환자가 대한민국에서 치료를 받고 본국으로 귀국한 후에 문제제기를 한 경우 ‘한국보건산업진흥원(Medical Call)’에 그 사항에 관하여 보고합니다.
14. 유치업자는 의료행위의 전문성을 감안하여 외국인환자의 상담 및 의료기관 소개 업무를 담당하는 직원은 의료인 중에서 선발하도록 합니다.

[부록4]

한국의료를 이용하기 위한

환자 안내서

본 환자 안내서는 외국인이 대한민국 의료기관을 이용할 때에 숙지하여야 할 기본적인 사항을 ‘한국국제의료협회(KIMA)’회원 의료기관에게 안내하기 위하여 제작 되었습니다. 따라서 이 안내서는 외국인환자가 대한민국 의료기관에서 진료를 받는 경우에 환자 본인이 지녀야 할 권리와 의무에 대한 안내서일 뿐 국내법에 규정된 조항 이외에는 어떠한 법적인 효력을 지니지 않음을 알려드립니다.

1. 환자들의 해외 의료서비스 이용은 환자 자신이 자발적으로 선택합니다.
2. 환자들은 해외 의료서비스를 이용하기 전에 주치의 등과 상의를 할 필요가 있고, 귀국 후의 치료에 대하여도 충분히 검토가 되어야 합니다.
3. 환자들은 장시간 비행과 외부활동이 시술결과와 맞물려서 발생할 수 있는 잠재적인 위험에 관하여 충분히 인지한 후에 해외 의료서비스 이용을 결정합니다.
4. 환자들은 해외 의료서비스 이용에 앞서 자신의 권리가 무엇이고, 어떠한 의무 사항이 있는지를 확인합니다.
5. 환자들은 의료기관 홈페이지 등에 게시된 의료기관 인증, 임상데이터 및 의사의 면허나 임상경험 정보에 대하여 확인합니다.
6. 환자들은 의료기관과 유치업자로부터 개별 진료행위에 대한 진료비, 투약비·옵션사항 및 예상외의 추가시술에 따른 추가비용 등 총 예상 진료비에 대하여 미리 확인하도록 합니다.
7. 환자들은 해외 의료서비스 이용에 필요한 서류(비자, 진단서, 전원의뢰서, 처방전, 보험증서 등)들을 미리 확인하여 진료행위가 원활하게 이루어 질 수 있도록 준비합니다.

8. 환자들은 국적·종교·인종·성적 편견으로 인한 차별을 받지 않을 권리가 있습니다.

9. 진단 및 치료 과정에 있어 환자 본인의 의사와 선택이 항상 최우선이며 환자의 인격과 자기결정권은 언제나 존중받을 권리가 있습니다.

10. 안전한 의료서비스를 제공받기 위해서는 환자들은 대한민국 보건복지부로부터 외국인환자 유치를 인가 받은 등록된 의료기관 및 유치업자와 계약하는 것이 올바른 선택입니다.

★ ‘한국국제의료협회(KIMA)’에 가입된 의료기관 추천

11. 환자들은 의료기관 및 유치업자로부터 진료절차 · 분쟁해결제도 · 개인정보보호 및 환자의 권리와 의무 등에 대하여 자세한 안내를 받을 수 있습니다.

12. 환자와 의료기관, 환자와 유치업자 사이의 계약과 관련하여, 계약의 체결 및 그 이행에 관한 모든 사항에 관하여 각 당사자는 (대한민국 민법 제2조) ‘신의성실의 원칙’에 입각하여 각자의 의무를 성실히 수행하여야 합니다.

13. 환자들은 진료를 받아야 할 의료기관에 상담 및 진료행위를 돕기 위한 전담 코디네이터나 통역사가 배치되어 있는지 확인합니다.

14. 환자들은 본인과 관련된 모든 진료기록 정보(결과)와 의학적 사실 및 건강상태에 관하여 충분히 알 권리가 있으며, 환자의 개인정보는 본인이 명확히 동의하였거나 법적으로 명백히 허용될 경우에 한하여만 공개될 수 있습니다.

15. 환자와 의료기관 사이에 의료분쟁이 발생한 경우 양 당사자는 분쟁이 원만히 해결될 수 있도록 상호협조를 하여야 하며, 환자들은 ‘한국보건산업진흥원(Medical Call:15777-129, www.medicalkorea.or.kr)’에 사고의 접수 및 상담을 요청할 수 있습니다.

16. 환자들은 의료기관이 의료사고 배상 자원(손해배상보험 등)을 별도로 마련하고 있는지 확인합니다.

17. 환자들은 의료기관 및 유치업자로부터 응급상황과 관련한 대응체계와 적절한 대응방법(의료기관이나 Medical Call 의 연락처: 15777-129, www.medicalkorea.or.kr등)에 관하여 미리 자세한 안내를 받고 이를 숙지합니다.
18. 환자들은 대한민국에서 치료를 마치고 본국으로 귀국할 때에 자신의 적절한 건강관리 방법에 관하여 의료인으로부터 조언을 들으십시오.
19. 환자들은 대한민국 의료서비스의 이용 도중 또는 이용한 후 언제라도 소감 또는 의견(불만이나 개선요구 사항 또는 장점 등)을 'Medical Call '에 밝힐 수 있습니다.

Patient Guidelines

This patient guide has been produced for a foreigner to become familiar with general matters when using medical facilities in the Republic of Korea which are members of the Council for Korea Medicine Overseas Promotion (CKMP). Hence, this guide is only for the purpose of guiding foreigners in the Republic of Korea of their rights and duties when receiving medical examinations or treatments, and other than the provisions set forth by domestic law, not a legal force in effect.

1. Foreign medical service utilization is a decision made voluntarily by the patient himself/herself.
2. Before a patient utilizes a foreign medical service, it is necessary that he or she first consult his or her family practitioner, general physician, etc, and investigate thoroughly issues regarding post-treatment care after returning home as well.
3. Patients must fully acknowledge before deciding on utilizing the foreign medical service that long flight hours along with external activities may develop potential dangers to the treatment results.
4. Patients must confirm what their rights are and whether there are any obligatory matters before utilizing the foreign medical service.
5. Patients are able to check information regarding the medical facility certification, clinical data, and a physician's license as well as clinical experience all published on the medical facility's homepage.
6. Patients must check and confirm in advance the individual fees including medical treatment fees, medication fees, as well as fees due to unexpected additional expenses from added optional treatments and have in mind a total

expected expenditures amount from both the hospital and the foreign medical service facilitator.

7. Patients wishing to utilize foreign medical services need to check in advance the necessary documentation (visa, diagnosis, transferral forms, prescriptions, insurance policy, etc) for the treatment to be accomplished smoothly.
8. Patients have the right to not be discriminated based on ethnicity, religion, race, or gender.
9. As for the diagnosis and course of treatment, the first priority will be that which is made by the patient's intention, and it is a patient's right to have his or her character and individual decisions respected.
10. In order to receive safe medical service provision, it is proper for the patient to deal with medical facilities and foreign medical service facilitators that are registered and authorized to attract foreign patients by the Korea Ministry of Health and Welfare.

*The medical facilities registered with the Korea International Medical Association (KIMA) are recommended.

11. Patients can be informed in details of examination procedures, dispute settlement system, private information protection as well as patient's rights and requirements by medical facilities and facilitators.
12. In terms of the contract between the patient and medical facilities or the contract between the patient and foreign medical service facilitators, each party is responsible to faithfully perform all its duties about the division and implementation on the contract based on the 'Principle of Duty of Good Faith and Fair Dealing', Article 2, Civil Code of Republic of Korea.

13. Patients are recommended to check that medical coordinators or interpreters are arranged in the potential medical facilities to support the patients' consultation and examination activity.
14. Patients have right to have full knowledge of all related medical treatment records (results), medical facts and health status, and the patients' personal information can only be disclosed with a patient's agreement or when the law clearly allows it.
15. When the medical dispute occurs between a patient and a medical facility, both parties have to cooperate for the amicable settlement, and the patient may request upon KHIDI (Medical Call Center) for the registration and consultation of the dispute.
16. Patients are recommended to confirm whether or not the medical facilities have their own medical malpractice compensation fund (liability insurance).
17. Patients are to understand and receive all detailed matters from medical facilities and foreign medical service facilitators related to emergency situations including response systems and appropriate response methods (contact information of medical facility, Medical Call Center, etc) in advance.
18. Patients are recommended to take advice from medical doctors or staff regarding appropriate post-treatment care upon arrival to their individual home country.
19. Patients are always able to make any opinion or comment (complaints, improvements requests, etc) to the 'Medical Call : +82-15777-129, www.medicalkorea.or.kr' during or after their medical service utilization in Korea.

외국인환자 유치 사업계획서

※ 외국인환자 유치사업 등록을 위하여 의료기관 및 유치업자는 아래의 사항을 사업계획서에 기입하여 제출하여 주시기 바랍니다.
(기본정보 등을 포함한 자유형식의 사업계획서 제출)

○ 사업계획서 (의료기관)

- 기본정보(양식), 기관개요, 사업 목적 및 주요사업내용, 업무조직 등 포함

○ 사업계획서 (유치업자)

- 기본정보(양식), 회사개요, 사업 목적 및 주요사업내용, 업무조직 및 인원 등 포함

[부록7]

의료기관 기본정보

의료기관명			
구 분	☐ 종합전문요양기관 ☐ 종합병원 ☐ 병원 ☐ 의원 ☐ 기타()		
법 인 명			
설 립 유 형	☐ 국립 ☐ 시·공립 ☐ 지방공사 ☐ 학교법인 ☐ 특수법인 ☐ 사단법인 ☐ 재단법인 ☐ 사회복지법인 ☐ 의료법인 ☐ 개인 ☐ 기타()		
대 표 자		주민등록번호	
법인등록번호		사업자 등록번호	
주 소			
대표전화번호		건강보험 요양기관코드	

1. 전화번호 (외국인 환자 응대 번호) Fax (외국인환자 응대 팩스번호) _____
2. 홈페이지 주소 _____
3. 기관 규모 병상수 : _____ 병상 (VIP실 : _____실, 1인실 : _____실, 2인실 : _____실) 중환자실 병상수 : _____ 병상 수술실 : _____실 외국인환자 병상 또는 병동(전용병상 또는 병동) : _____
4. 주요유치 타겟국가 (복수선택 가능) ☐ 미국 / ☐ 일본 / ☐ 중국 / ☐ 몽골 / ☐ 러시아 ☐ 기타 _____
5. 담당자 정보 성명 : _____ 부서 : _____ 직책 : _____ 전화 : _____ Fax: _____ e-mail : _____ 휴대전화 : _____

※ 기본정보 외에도 기관소개, 사업목적, 주요사업내용, 업무조직(전체 조직 및 외국인 환자 전담 조직) 등 포함하여 작성

[부록8]

유치업자 기본 정보

회 사 명			
자 본 금		설 립 연 도	
대 표 자		주민등록번호	
법인등록번호		사업자 등록번호	
주 소 (주사무소)			
주 소 (분사무소)			
대표전화번호			
비고			

1. 전화번호 (외국인환자 응대 번호) Fax (외국인환자 응대 팩스번호)

2. 홈페이지 주소

3. 회사 규모

종업원수 : _____명

임원수 : _____명

4. 주요유치 타겟국가 (복수선택 가능)

☐ 미국 / ☐ 일본 / ☐ 중국 / ☐ 몽골 / ☐ 러시아

☐ 기타 _____

5. 담당자 정보

성명 : _____

부서 : _____

직책 : _____

전화 : _____ Fax: _____

e-mail : _____

휴대전화 : _____

※ 기본정보 외에도 회사개요, 사업목적 및 주요사업내용, 업무조직 및 인원 등을 포함하여 작성

외국인환자 유치사업 실적조사표(의료기관)

기관명						
전화번호						
소재지						
대표자						
담당자	이름		연락처		이메일	
병상수						
외국인전용창구유무						
외국인전담코디네이터수						
종사자 현황						
법인등록번호						
사업자등록번호						

(단위:일수)

[illegible]

[부록10]

외국인환자 유치사업 실적조사표(유치업자)

가. 일반현황

회사명						
전화번호						
소재지						
대표자						
담당자	이름		연락처		이메일	
법인등록번호						
사업자등록번호						

나. 외국인환자 유치사업 실적

(단위:일수)

번호	국적	출생 년도	성별	입국일	출국일	진료과	방문 의료기관	외래방문 횟수	입원 횟수

[부록11]

☐ 의료기관 ☐ 유치업자 ☐ 휴업 ☐ 폐업 ☐ 재개업 신고서				처리기간 	
신고인	① 성명			② 주민등록번호 /외국인등록번호	
	③ 주소			④ 전화번호	
외국인환자 유치사업	⑤ 상호			⑥ 등록번호	
	⑦ 대표자 성명			⑧ 소재지	
신고사항	휴업()	휴업기간	~ (일간)		
	폐업()	폐업일자			
	재개()	재개일자			
신고사유					
위의 사항과 같이 외국인환자 유치사업을 (폐업·휴업·재개) 하고자 합니다. 신고인(대표자) (서명 또는 인)					
<구비서류> 1. 등록증 1부 2. 현재 계약체결자 등 유치 소개 중에 있는 환자에 대한 조치계획서 1부 (영업의 재개인 경우는 제외됩니다)					

[부록12]

☐ 외국인환자 유치 의료기관

변경신청서

☐ 외국인환자 유치업자

① 상호		② 등록번호	
③ 소재지 ☐ 주사무소 ☐ 분사무소		④ 전화번호	
⑤ 대표자 성명		⑥ 주민등록번호 /외국인 등록번호	
⑦ 변경사항	⑧ 변경전	⑨ 변경후	⑩ 변경사유

위의 사항과 같이 등록 사항을 변경하고자 합니다

년 월 일

신고인 또는 신청인(대표자) (서명 또는 인)

[부록13]

조 치 계 획 서

○ 기 본 정 보

상호명			
대표자 성명		주민등록번호 (외국인 등록번호)	

○ 유 치 실 적

현재 유치과정에 있는 환자 및 계약 유무	과거 유치했던 환자 및 계약 유무	유치실적(국가, 건수 등)

○ 조 치 계 획(현재 유치중인 환자/계약 인계 방안)

--

상기 내용은 사실과 같으며 외국인 환자 계약체결 등 유치 소개 중에 있는 환자에 대하여 일체의 책임을 지겠습니다.

년 월 일

대표자 : (인)

수신 : 한국보건산업진흥원장

외국인환자 유치 등록 영문 증명 신청서

☐ 의료기관

☐ 유치업체

상 호 명

(한글)

(영문)

소 재 지

(한글)

(영문)

대 표 자

(한글)

(영문)

연 락 처

E-mail:

Tel:

C.P:

등록연월일

등록번호

비 고

위와 같이 증명하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 :

(서명 또는 날인)

주 소 :

연락처 :

보건복지부장관 귀하

증권기간단축 확인서

1. 보험계약자	상호 : 사업자(또는 법인)번호 :
2. 보험상품	인허가보증보험증권
3. 증권번호	
4. 보험가입금액	
5. 보험기간	년 월 일부터 년 월 일까지(일간)
6. 계약명	외국인환자 유치업 등록
7. 계약기간	년 월 일부터 년 월 일까지(일간)
8. 계약금액	
9. 기간단축사유	외국인환자 유치업 폐업 (유치기관 등록 취소)
10. 단축기간	년 월 일부터 년 월 일까지

상기 보증보험 계약과 관련하여 피보험자로서 그 증서인 보증보험 증권을 교부받은 바 있으나,

위와 같은 사유로 당해 증권의 계약기간을 단축함을 확인합니다.

20 . . .

확인자 (피보험자)	주소	서울시 동작구 노량진동 57-1번지		
	상호	한국보건산업진흥원		
	대표자	(인)		
	담당부서		담당자	
	직위		연락처	

서울보증보험주식회사 귀중

*Ministry for
Health and Welfare*
CERTIFICATE

To Whom It May Concern:

This is to certify that following provider is registered as a
Healthcare provider for international patients in the Republic of Korea

Issued to:

Address:

Representative:

Date of Registration:

No. of Registration:

Signature _____

Minister of Health and Welfare
Republic of Korea

Date :

*Ministry for
Health and Welfare*
CERTIFICATE

To Whom It May Concern:

This is to certify that following company is registered as a
Facilitator for international patients in the Republic of Korea

Issued to:

Address:

Representative:

Date of Registration:

No. of Registration:

Signature _____

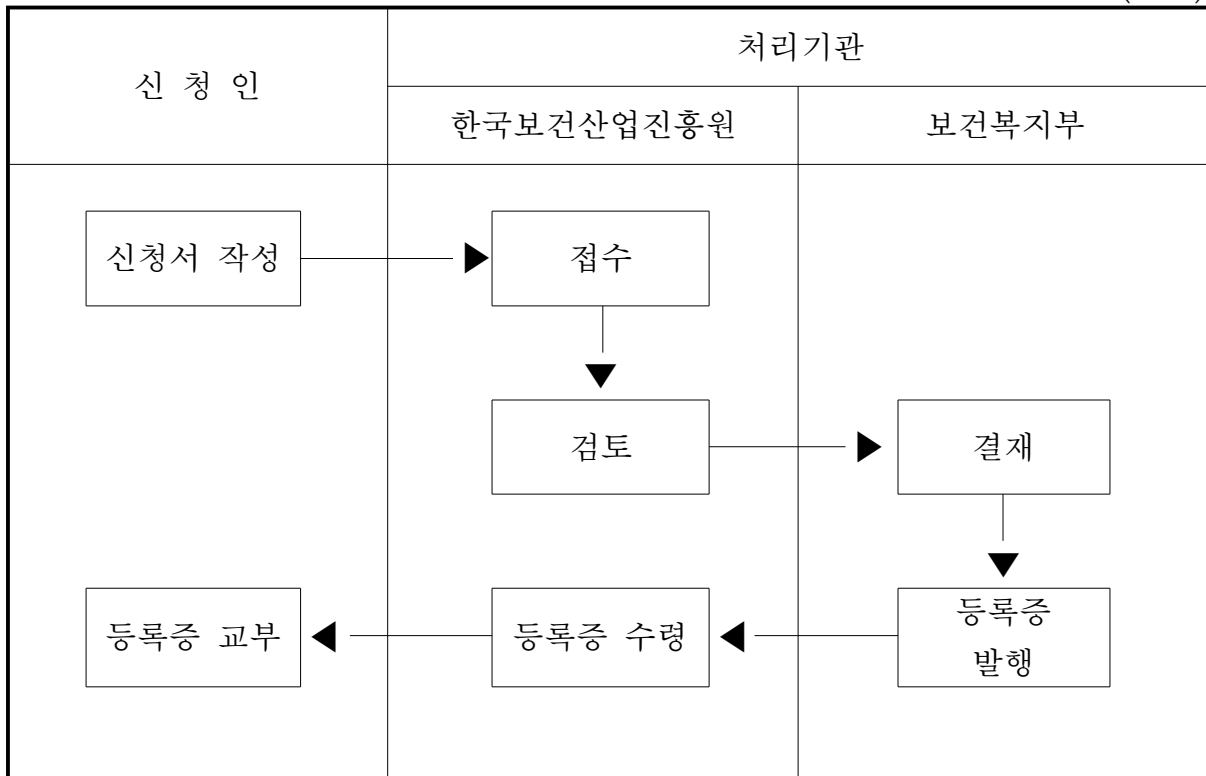
Minister of Health and Welfare
Republic of Korea

Date :

외국인환자 유치 의료기관 등록신청서				처리기간
				20 일
신 청 인	대 표 자 성 명		생 년 월 일 (외 국 인 등 록 번 호)	
	상 호		전 화 번 호	
	소 재 지			
「의료법」 제27조의2제1항, 같은 법 시행령 제42조제2항제1호 및 같은 법 시행규칙 제19조의6제1항에 따라 외국인환자 유치 의료기관 등록을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) 한국보건산업진흥원 귀하				
※ 구비서류 1. 별지 제15호서식의 의료기관 개설신고증명서 사본 또는 별지 제17호서식의 의료기관 개설허가증 사본 1부 2. 사업계획서 1부 3. 「의료법 시행규칙」 제19조의3에 따른 전문과목별 전문의의 명단 및 자격증 사본 각 1부				

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡ (재활용품)]

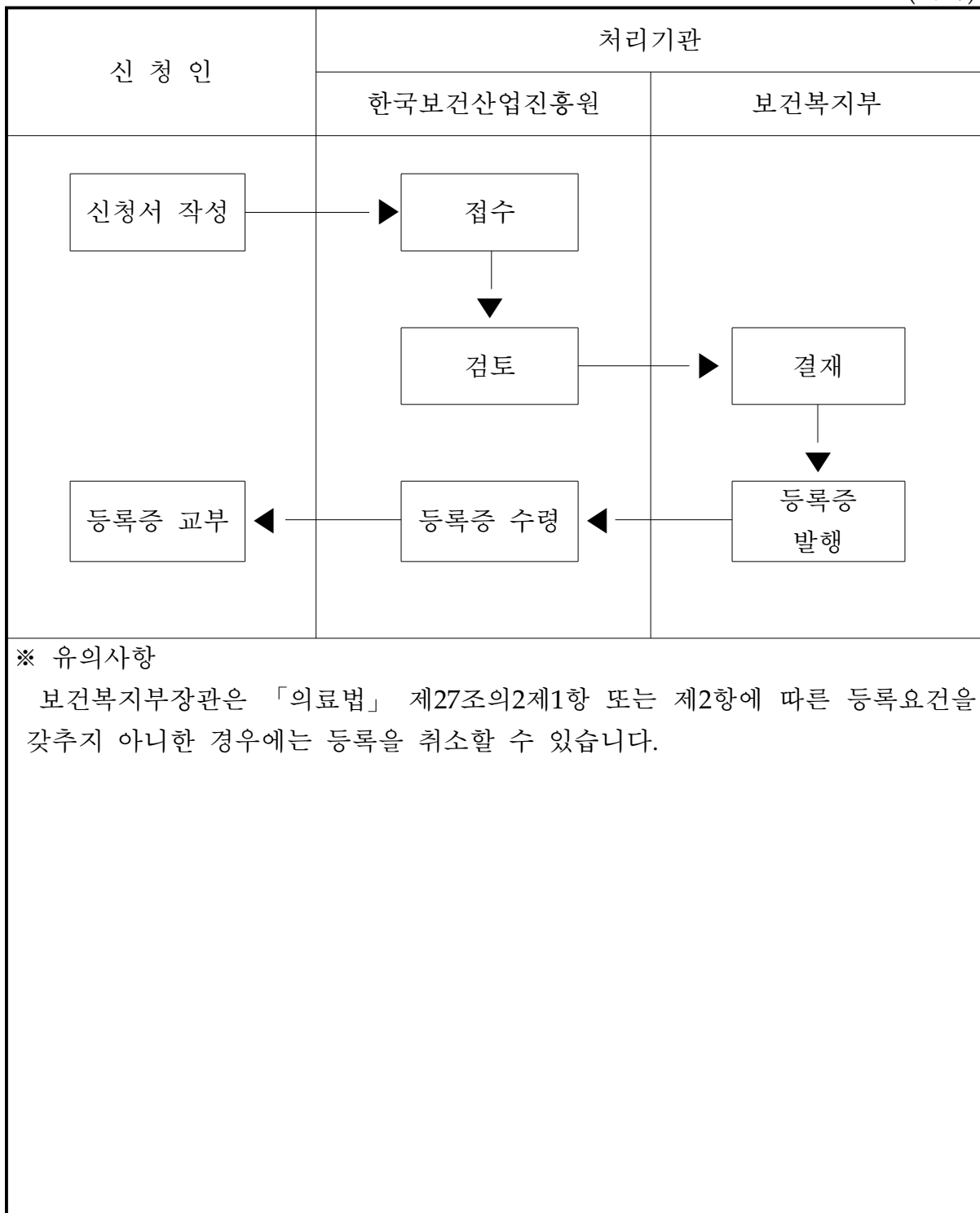
(뒤쪽)



※ 유의사항

보건복지부장관은 「의료법」 제27조의2제1항 또는 제2항에 따른 등록요건을 갖추지 아니한 경우에는 등록을 취소할 수 있습니다.

(뒤쪽)



[부록20]

[별지 제9호의6서식] <개정 2010.3.19>

제 호

외국인환자 유치 의료기관 등록증

○ 상 호:

○ 소 재 지:

○ 대 표 자:

○ 등록연월일:

○ 등록번호:

「의료법」 제27조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제19조의6 제4항에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

년 월 일

보건복지부장관

직인

210mm×297mm[보존용지(1종) 120g/m²]

[부록21]

[별지 제9호의7호서식] <개정 2010.3.19>

제 호

외국인환자 유치업자 등록증

○ 상 호:

○ 소 재 지:

○ 대 표 자:

○ 등록연월일:

○ 등록번호:

「의료법」 제27조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제19조의6 제4항에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

년 월 일

보건복지부장관

직인

210mm×297mm[보존용지(1종) 120g/m²]

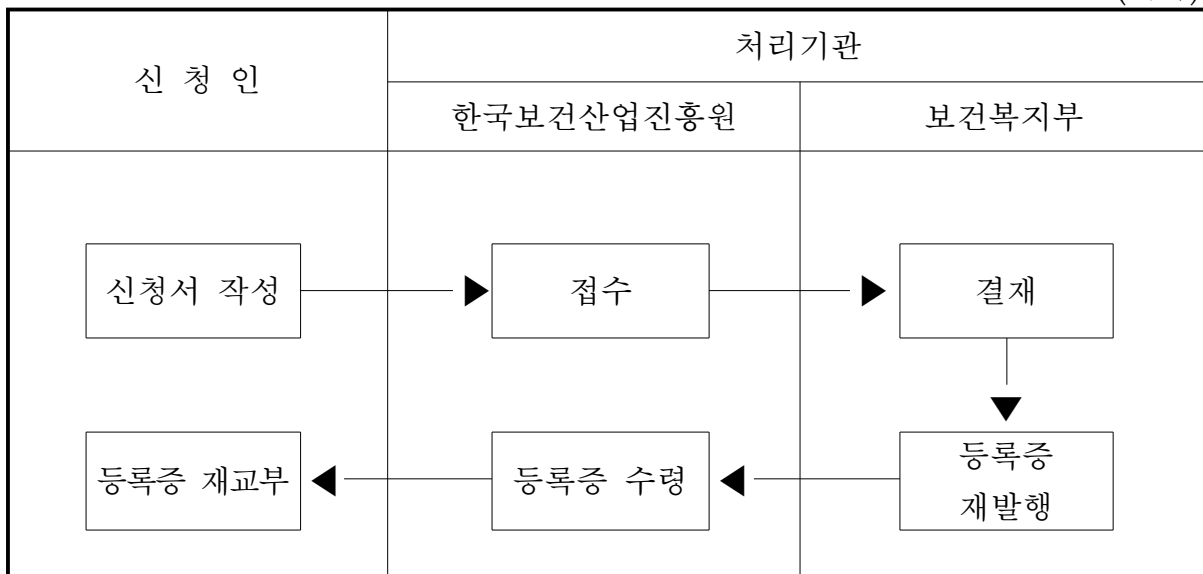
[부록22]

(앞쪽)

☐ 외국인환자 유치 의료기관 ☐ 외국인환자 유치업자				등록증 재발급신청서	처리기간
※ ☐ 에 ☒ 표시를 하시기 바랍니다.					7일
신 청 인	대표자 성명		생년월일		
	주 소	(전화:)			
등록자 (개인사업 자는 제외)	명칭(상호)				
	소 재 지	(전화:)			
재 발 행 사 유					
「의료법 시행규칙」 제19조의7에 따라 위와 같이 등록증 재발급을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국보건산업진흥원 귀하					
※ 구비서류 외국인환자 유치 의료기관 등록증 또는 외국인환자 유치업자 등록증 1부 (헐어서 못쓰게 된 경우만 해당합니다)					수수료 없 음

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)



[부록23]

C-3-M, G-1-M (외국인환자 및 배우자 등 초청)

“의료법”상 외국인 환자 유치 의료기관 또는 유치업자로 등록한 자의 초청에 의해 국내의료기관에서 진료 또는 요양을 할 목적으로 입국하고자 하는 자와 간병 등을 위해 동반 입국의 필요성이 있는 배우자 또는 가족

(2009.5.11부 시행)

제출서류	
초청인측 준비서류	피초청인측 준비서류
-사증발급인정신청서 *피초청인의 반명함판 칼라사진 1장 부착 - 초청사유서 -사업자등록증 또는 법인등기부등본 사본 -외국인환자 유치 의료기관 또는 유치업자 등록증 사본 -의료기관에서 발급한 의료목적 입증서류 * 의료기관 발행 진단서, 소견서 * 국내 의료기관 발행 치료/요양 예약확인서 * 관광일정표 * 기타 입증서류 - 외국인 환자 초청 확인서](중국인의 경우) <u><대리 신청 시 추가서류></u> - 신분증 및 재직증명서 - 업무수행 확인서 (대표자 명의) - 출입국 직무교육 이수증	- 여권 사본 - 거민증 및 호구부 사본 (중국인의 경우) - 치료 및 체류비용 조달 능력 입증서류 <u><환자 가족 초청 시 추가서류></u> -가족관계 입증서류
참고사항	
- 2009.11.1 이후에는 초청단체 소속직원 중 출입국 직무교육 이수자만 대리 신청할 수 있고, 필요한 경우 대리 신청이 제한되며 보완서류를 요구할 수 있습니다. -신청서양식 및 업무안내 등은 홈페이지 (http://immigration.go.kr)를 참조하시기 바랍니다.	

[부록24]

외국인 환자 초청 확인서

피 초 청 외 국 인	성명	영 문		한자명		
	생년월일		성별	국적	여권번호	
	직장/직위/전화번호			직장주소		
	과거 출입국사실		☐ 있음 ☐ 없음		동반자 유무	☐ 있음 ☐ 없음
입·출국 예정사항	입 국 일		입국편명		출국일	출국편명
의료기관명		담당의사	진료기간	진료 내용		소재지
비 고						
위 내용은 사실과 틀림이 없으며 상기 외국인 환자의 주된 입국 목적은 진료, 요양임을 확인합니다. 00 출입국관리사무소장 귀하						
신청일자 : 초청자 : 서명 : _____인						